



الأساليب التربوية والتعليمية للتعامل مع

اضطراب التوحد

أحمد محمود الحوامدة



الأساليب التربوية والتعليمية
للتعامل مع اضطراب التوحد

الأساليب التربوية والتعليمية للتعامل مع اضطراب التوحد

احمد محمود الحوامدة

الطبعة الاولى

2019



-المملكة الأردنية الهاشمية

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة

الوطنية

(2019/2/840) 371.93

الحوامدة ، احمد محمود

الأساليب التربوية والتعليمية للتعامل مع اضطراب التوحد

/ احمد محمود الحوامدة - عمان، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع

.2019

() ص: / <https://www.facebook.com/bank.freebooks/>

ر.إ: (2019/2/840)

الواصفات: / التوحد عند الاطفال // اساليب التدريس // التربية الخاصة

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر

هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

ISBN - 978-9923-24-001-4

الطبعة الأولى: 2019م



+962797135504

+962780080648



Dar ibn alnafees



dar_ibnalnafees@yahoo.com



alnafees02@gmail.com

مقدمة

التوحد أكبر من مجرد حالة من الانطوائية أو الانعزالية، فهو خلل في التطور العصبي للجهاز العصبي المركزي يتميز بفشل في التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الآخرين، مع سلوك نمطي متكرر وثابت وصعوبة بالغة في ممارسة النشاطات اللغوية والحسية. وتبدأ المشكلة في الظهور مع الطفل في مراحل مبكرة من حياته، من بداية السنة الأولى وقبل أن يكمل عامه الثالث، ورغم أنه لم توضح الأسباب المؤكدة لمرض التوحد بشكل دقيق ومباشر، إلا أن هناك الكثير من النظريات العلمية التي تحاول تفسير المرض.

وحاولت عدة نظريات تفسير المرض أهمها نظرية الخلل في عدد من الجينات، الذي ينتج عنه خلل بوظيفة الموصلات الكيميائية في الجهاز العصبي المركزي، مما يتسبب في تكون غير طبيعي للدماغ والأعصاب.

كذلك هناك نظرية أخرى لاقت قبولا علميا هي نظرية التعرض للسموم بالمعادن الثقيلة، مثل الرصاص أو الزئبق. حيث إنه من الثابت علميا أثر هذه السموم على الدماغ، وخاصة في مراحل النمو، ولكن لم يتم التأكد من نتائج الأبحاث الخاصة بهذا التفسير، حيث لا توجد دراسة مسحية كافية تؤكد أو تنفي تعرض هؤلاء الأطفال إلى التسمم. بل إن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى عدم وجود اختلافات في نسب وجود المعادن الثقيلة بالدم بين الأطفال الطبيعيين والمتوحدين.

يتدرج التَّوَحُّدُ أو الذاتوية من الاضطراب البسيط في التواصل أو في السلوك إلى حالات التَّوَحُّد أو الذاتوية الشديدة. إن كثير من الأسر والمربين تختلط لديهم المفاهيم بين التوحد والتخلف العقلي والقصور الذهني وغيرها من المفاهيم التي تطلق على أمراض الإضرابات العقلية، مع العلم أن هناك تفاوتاً كبيراً بين تلك المفاهيم، من النواحي العلمية والطبية، وعند الأخذ في الاعتبار تجربة الطفل الذي يعاني من اضطراب التوحد من المهم التوصل إلى فهم عام للسمات المميزة لذلك الاضطراب بالإضافة إلى الطريقة التي يُظهر الفرد من خلالها ما يعبر به عن اضطراب التوحد. ومن الأهمية أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار العوامل الخارجية التي تؤثر على كيفية قدرة الفرد على التعلم.

تمهيد

البدايات التاريخية لدراسة التوحد

يعد مودزلي Maudsly أول طبيب نفسي اهتم بالاضطرابات التي تسبب اضطرابات عقلية شديدة لدى الأطفال وذلك عام 1867 وكان يعدها ذهانات.

ولكن " ليوكانر " Leo Kanner الطبيب النفسي الأمريكي المتخصص في الأطفال ومؤلف كتاب (نفس الطفل) عام 1953 أشار إلى التوحد الطفولي كاضطراب يحدث في الطفولة وقد كان ذلك عام 1943 عندما قام بفحص مجموعات من الأطفال المتخلفين عقلياً بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية ولفت انتباهه وجود مجموعة من الأنماط السلوكية غير العادية لأحد عشر طفلاً كانوا مصنّفين على أنهم متخلفين عقلياً، فقد كان سلوكهم يتميز بما أطلق عليه بعد ذلك مصطلح اضطراب الذاتوية الطفلية Early Infantile Autism حيث لاحظ انغلاقهم الكامل على الذات والابتعاد عن الواقع والانطواء والعزلة وعدم التجاوب مع المثيرات التي تحيط بهم¹. ويعتبر (ليو كانر) أول من أشار إلى إعاقة التوحد وذلك في 1943م حينما كان يقوم بفحص بعض الأطفال المتخلفين عقلياً حيث لاحظ أنماط سلوكية غير عادية لإحدى عشر طفلاً كانوا مصنّفين على أنهم من المتخلفين عقلياً وقام بوصف هذه السلوكيات وأطلق عليهم مسمى التوحدين. وقد اعتبر كارنر أن العلامة البارزة للتوحد هي عجز الفرد عن

¹ الجلبي، سوسن شاكر (2005): التوحد الطفولي (أسبابه، خصائصه، تشخيصه، علاجه)، ط 1، مؤسسة علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق ص11-12.

الارتباط بالناس والمواقف بالطريقة العادية.¹

وأكد ذلك أيضاً أسبرجر Asperger (1944) حيث حدد لاضطراب "التوحد" زملة أعراض سميت باسمه Asperger Syndrome وأنه يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، وعزا سبب المرض إلى الناحية البيولوجية وكان يصنف هؤلاء الأطفال مع فئة المتخلفين عقلياً²

ولكن مارشيون Marchionne (1982) أشارت إلى أن اضطراب التوحد لدى الأطفال يحدث في الطفولة المبكرة ويعود إلى أسباب نفسية واجتماعية أكثر من الناحية البيولوجية وأن أعراض هذا المرض تتشابه مع أعراض صعوبات التعليم والضعف العقلي.

وحديثاً طور العلماء الدراسات والأبحاث عن التوحد Autism من خلال محاولات التدخل المباشر للتشخيص والوقاية والعلاج المبكر بدلاً من التركيز على الدراسات النظرية فقط، حيث أن التدخل المبكر والتعامل مع مشكلة تعوق الطفل (أو تعوقه في المستقبل) من تحقيق ذاته أو إمكاناته في التكيف مع نفسه أو مع الآخرين ويجب أن يؤدي هذا التدخل في النهاية إلى التغلب على المشكلة أو التقليل من آثارها السلبية لتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطفل وأسرته وبيئته.³

¹ Baron, Cohen, S. (1988): Social and pragmatic deficits in autism: Cognitive or affective? Journal of Autism and Developmental disorders, vol. 18, P. 379

² Barber, C. (1996): The integration of a very able pupil with Asperger syndrome into a mainstream school. British journal of social Education, Vol. 23, No.1, March. P. 19

³ فاروق محمد صادق (1993): أسس برامج التدخل المبكر لذوى الحاجات الخاصة (مجلة معوقات الطفولة - جامعة الأزهر)، مارس مجلد 3، 9-49 .

وقد أوضح روبنس¹ (1991) مدى فاعلية التدخل المبكر في تحسين حالات الأطفال ذوي التوحد وأشار هاندايمان² (1991) على أهمية تقديم برامج متكاملة لهؤلاء الأطفال في الحياة العادية وأن تبدأ هذه البرامج في مراحل مبكرة لتشخيص حالات الأطفال ذوي التوحد.

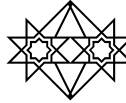
¹ Robbins, F. and Others, (1991): Family characteristic family training and progress of young children with autism. Journal of Early Intervention, Vol. 15, No2, Spr, P. 173

² Handleman, J and others (1991): Specialization Program for preschool children with autism. Language, Speech and Hearing Services in schools, Vol 22, No.3, P. 107



الباب الأول

مدخل إلى اضطرابات التوحد



معنى التوحد

مصطلح التوحد هو ترجمة للكلمة الإغريقية (autos) أي الذات الأنا التي تشير إلى الانطواء والتوحد مع الذات وقد استعمل العالم (بلولير ايغون) وهو عالم وطبيب سويسري ولد في زيورخ 1857-1939م - مفهوم السلوك التوحدي لأول مرة عام 1911م كدالة على الانفصام الشخصي بالرغم من الاختلافات الشديدة بين الاضطرابيين.¹

يظهر التوحد بوضوح في السنوات الثلاث الأولى من الحياة، ويعرف التوحد بأنه عجز يعيق تطوير المهارات الاجتماعية والتواصل اللفظي وغير اللفظي واللعب التخيلي والابداعي وهو نتيجة اضطراب عصبي يؤثر على الطريقة التي يتم من خلالها جمع المعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ مسببة مشكلات في المهارات الاجتماعية تتمثل في عدم القدرة على الارتباط وخلق علاقات مع الأفراد، وعدم القدرة على اللعب واستخدام وقت الفراغ، وعدم القدرة على التصور البناء والملائمة التخيلية.

مهارات التواصل فهي تكمن في عدم القدرة على التعبير عن الذات تلقائياً وبطريقة وظيفية ملائمة، وعدم القدرة على فهم مايقوله الآخرون، عدم القدرة على استخدام مهارات أخرى بجانب المهارات اللفظية لمساعدة الفرد في القدرة على التواصل.

أما مشاكل التأقلم مع البيئة فهي تكمن في عدم القدرة على القيام بعمل وأداء وظيفي بفاعلية في البيئة، وعدم القدرة على مسايرة وتحمل التغيرات في البيئة والتعامل معها بالإضافة الى عدم القدرة على تحمل تدخلات الأفراد الآخرين.

تعريف الجمعية الأمريكية للتوحد

التوحد نوع من الاضطرابات التطورية (النمائية) و الذي يظهر خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل حيث ينتج هذا الاضطراب عن خلل في الجهاز العصبي يؤثر بدوره علي وظائف المخ و بالتالي يؤثر علي مختلف نواحي النمو.

¹ ماجد السيد علي عمارة (2005م)، اعاقاة التوحد، ط/1، القاهرة:مكتبة زهراء الشرق.

فيؤدي إلى:

1. قصور في التفاعل الاجتماعي.
2. قصور في الاتصال سواء كان لفظياً أم غير لفظياً.
3. و هؤلاء الأطفال يستجيبون دائماً إلى الأشياء أكثر من استجابتهم إلى الأشخاص ويضطرب هؤلاء الأطفال من أي تغيير يحدث في بيئتهم و دائماً يكررون حركات بدنية او مقاطع من الكلمات بطريقة اليه متكررة.

التعرف على التوحد

في عام 1943 م كتب الطبيب النفسي ليوكانر Leo Kanner مقالة تصف إحدى عشر مريضاً تابع حالتهم على مدى سنوات في عيادته، هؤلاء الأطفال كانوا يتصفون بمجموعة من الأعراض المرضية تختلف عن الأعراض النفسية التي تعود على متابعتها أو قرأ عنها في المنشورات والكتب الطبية، وقد أستعمل مصطلح التوحد Autism لأول مرة للتعبير عنها، وتتابعت البحوث والدراسات في محاولة لإجلاء الغموض عنه.

- وحدد مصطلح Autism في معجم علم النفس بأنه:

- تفكير محكوم بالحاجات الشخصية أو بالذات.
- إدراك العالم من خلال الرغبات بدلاً من الواقع.
- الانكباب على الذات والاهتمام بالأفكار والخيالات الذاتية.

وحدد مصطلح طفل متوحد Autistic Child بأنه:

طفل منكب على ذاته ومنسحب من العالم، والأطفال المتوحدون قد يجلسون ويلعبون بأصابعهم مثلاً، وإنهم يبدون ضائعين في عالم من الخيالات الداخلية¹.

– وتعرف الجمعية الوطنية (الأمريكية) للأطفال التوحدين (NSAC, 1978)
National Sociely of Autistic Children التوحد بأنه اضطراب أو متلازمة تعرف

¹ عاقل، فاخر (2003): معجم العلوم النفسية، ط1، شعاع للنشر و العلوم، حلب، ص54.

سلوكياً وتشمل الاضطرابات في المجالات التالية: النمو، الاستجابة الحسية للمثيرات، اللغة والكلام، القدرات المعرفية، التعلق والانتماء للناس والتعلق بالأحداث والمواضيع.

- وترى الجمعية الأمريكية للطب النفسي American Psychiatric Association أن التوحد اضطراب نمائي يؤدي إلى العجز في المجالات التالية:

● الكفاءة الاجتماعية

● التواصل واللغة

● السلوك النمطي والاهتمامات والأنشطة

- ويعرف قانون تعليم الأفراد المعاقين الأمريكي Individuals with disabilities Education Act (IDEA) التوحد بأنه اضطراب نمائي يؤثر بشكل واضح على التواصل اللفظي وغير اللفظي ويؤثر على التفاعل الاجتماعي ويؤثر على الأداء التعليمي للفرد ويصاحبه العديد من الخصائص أهمها الانغماس في النشاطات اليومية والحركات النمطية ومقاومة التغير في روتين الحياة اليومية والاستجابة غير الطبيعية للمثيرات الحسية وتتضح هذه الخصائص قبل عمر الثلاث سنوات ¹.

نسبة شيوع إعاقة التوحد عالمياً

تقدر نسبة شيوع التوحد تقريباً 4 - 5 حالات توحد كلاسيكية في كل 10.000 مولود ومن 14 - 20 حالة (أسيرجر) توحد ذا كفاءة أعلى كما أنه أكثر شيوعاً في الأولاد عن البنات أي بنسبة 1:4. وللتوحيدين دورة حياة طبيعية كما أن بعض أنواع السلوك المرتبطة بالمصابين قد تتغير أو تختفي بمرور الزمن ويوجد التوحد في جميع أنحاء العالم وفي جميع الطبقات العرقية والاجتماعية في العائلات.

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 2.

أسباب التوحد

لقد حاول الخبراء تحديد مسببات التوحد ولكن حتى الآن لا يوجد إجابات محددة وبدون أسباب محددة يتم التعرف عليها من المستحيل تطوير استراتيجيات وقائية. أكثر البحوث تشير إلى وجود عامل جيني ذي تأثير في الإصابة بهذا الاضطراب، حيث تزداد الإصابة بين التوائم المتطابقين (من بيضة واحدة) أكثر من التوائم الآخرين (من بيضتين مختلفتين).¹

ويقول الدكتور بينيث ليفينثال من جامعة شيكاغو: (على الأقل خمسة أو ستة جينات تسهم في التوحد) وحتى الآن فإن دراسة إخوة وأقارب التوحديين تقترح أن هذه الجينات في الكروموسومات 15/13/7 ولكن ما تفعله هذه الجينات غير معروف.² يقول سميث في كتابه (Understanding The Nature Of Autism) "تختلف أسباب الإصابة بالتوحد من شخص إلى آخر، فلا ينطبق سبب واحد ومعظمها غامضة إلا أن الأسباب المحتملة هي الجينات الوراثية، التهابات فيروسية قبل أو بعد الولادة، التمثيل الغذائي، نقص الأكسجين، أو التعرض الزائد له بعد الولادة، تعرض الأم إلى كيماويات سامة أثناء الحمل".³

يشير الباحثون إلى مساهمة الوراثة في الإصابة بالتوحد فقد ذكر سجل (Siegel, 1996) أن الوراثة تلعب دوراً في (30 - 50 %) من حالات التوحد والاضطرابات النمائية الشاملة، إلا أن الاستعداد الوراثي ليس مطلقاً ويصعب تحديد كيفية انتقال الجينات، وما هو الموروث تحديداً، حيث يتفاعل أكثر من (20) جين مختلف، ومن الشواهد على الأسباب الوراثية مايلي:

¹ www.autism-society.org

² الفهد، ياسر، (2001) التوحد / مجلة المنال، عدد 155.

³ Smith, Deborah, American journal in mental retardation. V105,no.4. July 2000)

أ - معاناة نسبة لا بأس بها من أقارب الأطفال التوحديين من الإعاقات النمائية المختلفة واضطرابات الكلام وصعوبات التعلم.

ب - زيادة احتمالية إصابة أشقاء الطفل التوحدي بنفس الاضطراب أو اضطرابات مشابهة.

ج - زيادة احتمالية الإصابة بالتوحد عند التوحد المطابقة¹.

والعوامل الوراثية تتمثل بوجود خصائص التوحد والتي تكون ظاهرة لدى واحد من الأقرباء أو ضمن الخصائص الشخصية غير الاجتماعية في الأسرة.

أما العوامل البيئية فقد دلت الدراسات وجود حالات من الانفصام و الاكتئاب في عائلات التوحديين ولكن هناك بعض الدراسات دلت أن بعض حالات التوحد تعود إلى أسباب غير معروفة ودراسات أخرى دلت على أنه ناتج عن تحولات جينية غير معروفة أو محددة أو بسبب التهابات تصيب الجنين وليس الأم الحامل وذلك خلال فترة الحمل².

الفرضيات الجينية:

لم تتوصل البحوث العلمية التي أجريت حول التوحد إلى نتيجة قطعية حول السبب المباشر للتوحد، رغم أن أكثر البحوث تشير إلى وجود عامل جيني ذي تأثير مباشر في الإصابة بهذا الاضطراب، حيث تزداد نسبة الإصابة بين التوائم المطابقين (من بيضة واحدة) أكثر من التوائم الغير متطابقين (من بيضتين مختلفتين)، ومن المعروف أن التوأمين المتطابقين يشتركان في نفس التركيبة الجينية³.

يفترض الباحثون أن الخلل في الكروموسومات والجينات في مرحلة مبكرة من عمر الجنين قد يؤدي للإصابة بالتوحد ويستشهدون على ذلك بمرافقة التوحد

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 8.

² مرهج، ريتا (2001): التوحد، نشرة علمية صادرة عن مركز لبنان للتوحد، بيروت ص 15-16.

³ أبو العزائم، محمود جمال (2003): اضطراب الذاتوية، الصفحة النفسية، موقع د. محمود جمال أبو العزائم.

للعديد من الاضطرابات الجينية والتي أهمها: متلازمة انجلمان (Angelman Syndrome) ومتلازمة الكروموسوم الهش (Fragile x) ومتلازمة كورينلاي لانج (Corneliade Lange Syndrome) ومتلازمة داون (Down Syndrome) ومتلازمة كليفنتر (Klinefenter Syndrome) ومتلازمة ريت (Rett Syndrome) ومتلازمة وليم (Williams Syndrome) والتصلب الدرني. (الحدي) (Tuberous Sclerosis) و الأمراض العصبية الليفية، ومن الكروموسومات ذات العلاقة: كروموسوم 2 - 3 - 5 - 7 - 10¹ و X

الفرضيات البيوكيميائية:

يعتقد أن بعض العوامل التي تسبب تلفا بالمخ قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها تهيج حدوث هذا المرض مثل إصابة الأم بالحصبة الألمانية والحالات التي لم تعالج من مرض الفينيل كيتونوريا والتصلب الحدي واضطراب رت ونقص الاكسجين أثناء الولادة والتهاب الدماغ وتشنجات الرضع فقد أكدت الدراسات أن مضاعفات ما قبل الولادة أكثر لدى الأطفال الذاتويين من غيرهم من الأسوياء.²

تشير الدراسات لوجود عزل في خلايا المخ عند بعض الأفراد التوحديين أكثر من الشكل الطبيعي إضافة لوجود الخلل في توازن بعض النواقل العصبية التالية في الدماغ:

أ - السيروتونين (Serotonin)

وهو ناقل عصبي هام تأثيره معقد وشامل حيث يؤثر في المزاج والذاكرة والتطور العصبي وإفراز الهرمونات وتناول الطعام وتنظيم حرارة الجسم والذاكرة والنوم والألم والقلق وظهور السلوك العدواني والسلوك النمطي، وفي حالة وجود

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 9.

² أبو العزائم، محمود جمال (2003): اضطراب الذاتوية، الصفحة النفسية، موقع د. محمود جمال أبو العزائم.

مشكلات في عملية الأيض (الهضم) يزداد تركيز السيروتونين في الدم والدماغ الأوسط والبول وبالتالي خلل في وظائفه وظهور بعض صفات التوحد. يشير جلبرزون وزملائه إلى أن أكثر من 30 % من الأطفال التوحديين لديهم زيادة في كمية السيروتونين في الصفائح الدموية.

ب - الدوبامين:

ناقل عصبي معقد يلعب دوراً حيوياً في النشاطات الحركية والذاكرة واستقرار المزاج والإرادة والسلوك النمطي.

ج - الببتيدات العصبية:

تلعب دور هام في عملية النقل العصبي ومسئولة عن الانفعال والإدراك وضبط السلوك الجنسي، وتشير الدراسات إلى عدم توازن الببتيدات العصبية عند الأطفال التوحديين.¹

الفرضيات الأيضية:

يؤكد الكثير من الباحثين أن الجهاز الهضمي عند الأطفال التوحديين غير قادر على الهضم الكامل للبروتينات وخاصة بروتين الجلوتين (Gluten) الموجود في مادة القمح والشعير ومشتقاته وهو الذي يعطي القمح اللزوجة والمرونة أثناء العجين، وبروتين الكازين (Casien) الموجود في الحليب ويستدلون على ذلك من خلال استفراغ الطفل المستمر للحليب والاكزيميا الموجودة خلف الركبتين في ثنية المرفق والأورام البيضاء الغريبة تحت الجلد وسيلان الأذن المبكر والإمساك و/ أو الإسهال المزمن واضطرابات التنفس الشبيهة بالأزمة الصدرية.

ومن أسباب اضطراب الهضم عند الأفراد التوحديين ماييلي:

أ - حساسية الجسم الزائدة لبعض الخمائر والبكتيريا الموجودة في المعدة.

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 10.

ب - زيادة الأفيون في المخ.

ج - عدم هضم الأطعمة الناقلة للكبريت.

د - النفاذية المعدية.

التغيرات الطبية الحيوية التي تحدث نتيجة لذلك (العوامل الأيضية) هي زيادة تكاثر الكانديدا (الفطريات) والبكتيريا في الأمعاء، وزيادة نفاذية الأمعاء Leaky Gut Syndrome ونقص الفيتامينات والمعادن وضعف التغذية بشكل عام، وضعف المناعة، ونقص مضادات الأكسدة، ونقص الأحماض الدهنية ونقص قدرة الجسم على التخلص من السموم.

هـ - نقص بعض الأحماض والأنزيمات في الجسم.

فرضيات الفيروسات:

لا يوجد دليل على أن المطاعيم تؤثر أو تسبب التوحد سوى أن بعض أهالي الأطفال المصابين بالتوحد قد أخبروا بأنه عند إعطاء أطفالهم بعض المطاعيم سببت لهم مشاكل سلوكية. وترى الجمعية الأمريكية للتوحد أن هناك علاقة بين مصل (MMR) واضطراب التوحد في عدد قليل من الحالات¹.

وربط بعض العلماء ما بين الإصابة بالتوحد والمطعوم الثلاثي (MMR): مطعوم الحصبة ومطعوم الحصبة الألمانية (Rubella).

نظراً لمعاناة بعض الأطفال من وجود خلل مبكر في الجهاز المناعي لدى الطفل حيث لا تستطيع كريات الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة مهاجمة الفيروسات والالتهابات - إنتاج المضادات الكافية للقضاء على فيروسات اللقاح وبذلك تبقى هذه الفيروسات وتتلفها².

¹ www.autism-society.org

² الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 10

وكذلك فقد أجمع الخبراء أن إصابة الأم بالالتهابات الفيروسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل قد تكون من أبرز العوامل المؤدية للتوحد إضافة إلى أن نقص الأوكسجين أثناء الولادة كما ربط تعاطي الكوكايين أثناء الحمل بتواجد خصائص التوحد لدى الأطفال¹.

التلوث البيئي:

ونقصد به العوامل الخارجية أي تلوث البيئة بسبب (المعادن السامة كالزئبق والرصاص واستعمال المضادات الحيوية بشكل مكثف أو تعرض للالتهابات أو الفيروساتوغيرها من الأسباب).

قد يتعرض الطفل للتلوث البيئي أثناء فترات حرجة من مراحل تطور الطفل مما يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات التي قد تؤثر على القدرات المختلفة للطفل مثل المشي والنطق وبعض أشكال السلوك التوحدي، ومن هذه الملوثات:

أ - الزئبق (Mercury): يشير البعض أن التسمم بالزئبق قد يؤدي إلى التخلف العقلي وعدم أتران عضلي وعصبي وظهور بعض أعراض التوحد.

ب - مادة (Thiromersal): وهي مادة حافظة للمطاعيم حيث يرى الباحثين أن الإصابة بالتوحد لا يعود للمطاعيم نفسها وإنما لهذه المادة.

ج - الرصاص (Lead) يؤدي التسمم بالرصاص إلى تأثيرات سلبية على النمو ويؤدي إلى ظهور مشكلات سلوكية عديدة.

د - التسمم بأول أكسيد الكربون (Monoxide) تؤدي إلى تشوهات خلقية. وتلف في خلايا الدماغ ووفاة الجنين واضطرابات في الحركة سواءً في مرحلة الحمل أو في المرحل النمائية الأولى من العمر².

الأدوية والعقاقير:

¹ مرهج، ريتا (2001): التوحد، نشرة علمية صادرة عن مركز لبنان للتوحد، بيروت ص 15-16.
² الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 11

يعتبر تناول الأم للأدوية والعقاقير أمراً غير مرغوب فيه بشكل عام، حيث قد تؤدي إلى العديد من المخاطر مثل تلف خلايا الدماغ و الإصابة بالتوحد ولعل من أبرز الأدوية دواء (Thalidomise)

أسباب إدراكية و عقلية:

قد ينتج التوحد نتيجة عدم تطوير الأفكار و عدم اكتمال نمو الأفكار بشكل يواكب النمو الطبيعي لمختلف النظم الإدراكية والمعرفة التي تنمو بشكل طبيعي جنباً إلى جنب الأفكار وبذلك فغياب نمو هذه الأفكار لا يسمح للطفل بحل المشكلات التي يواجهها في المواقف الاجتماعية للحياة اليومية وفي نفس الوقت لا يستطيع الفهم بأن الآخرين لديهم أفكار ومشاعر يمكن قراءتها من خلال الإشارات و الإيماءات و أوضاع الجسم¹ ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن إعاقة التوحد سببها اضطراب إدراكي نمائي حيث أشارت بعض الدراسات أن أطفال التوحد لديهم انخفاض في نشاط القدرات العقلية المختلفة و التي ترجع بدورها الى انخفاض قدرتهم على الإدراك فضلا عن اضطراب النطق و اللغة ووجدت الباحثة 1987 leslie بان المشكلة الرئيسية لأطفال التوحد هي افتقارهم للقدرة على تفهم الناس الآخرين و فهم أنفسهم²، و معظم الأفراد الطبيعيين لديهم معلومات عن أنفسهم، كما أن الطفل التوحدي لا يفهم كيف يؤثر سلوكه في أفكار و معتقدات الناس الآخرين و بموجب هذه النظرية فان أطفال التوحد ليس لديهم عالم حسي فضلا عن افتقارهم للجانب الاجتماعي و التواصل مع الآخرين و لديهم مشاكل في الجانب المعرفي و الاجتماعي³.

¹ مرهج، ريتا (2001) : التوحد، نشرة علمية صادرة عن مركز لبنان للتوحد، بيروت ص 15-16.
² الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 10
³ الجلبي، سوسن شاكر (2005) : التوحد الطفولي (أسبابه، خصائصه، تشخيصه، علاجه)، ط 1، مؤسسة علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق ص 50.

ويرى أصحاب هذه النظرية أن التوحد هو عدم القدرة على تنظيم استقبال الرسائل ذات العلاقة بالإحساس وهذا ما يجعل استحالة التوحيدين الصغار من تطوير أفكار مرتبطة أو ذات معنى للحياة الخارجية المحيطة بهم، هذا التقلب والتحول في ما يدرك بالحواس له بعض الموافقين اليوم بالرغم أنهم لم يعرفوا أبداً الطبيعة الدقيقة لهذا الاستقبال الحسي غير الثابت¹.

¹ السعد، سميرة عبد اللطيف (1992): معاناتي و التوحد، منشورات مركز الكويت للتوعية بالتوحد ص19

أنواع التوحد

هناك خصائص ومظاهر سلوكية مشتركة يتصف بها ذوي اضطراب التوحد، وفي المقابل فإنه لا يمكن لنا من ناحية عملية أن نجد نفس الخصائص لدى كل هؤلاء الأطفال، وحتى إن وجدنا نفس الخصائص فإنها في الأغلب تختلف في طريقة ظهورها أو الدرجة والمستوى الحالي لها.

ولمعرفة هذه الخصائص لدى الأطفال فقد تم تصنيف أنماط ظهورها بهدف فهم أكثر لحالة كل طفل وما يمكن أن يقدم له من خدمات وبرامج علاجية لذلك صنف التوحد كما يلي:

1- التوحد التقليدي:

وهو ما يظهر لدى الأطفال في أعمار مبكرة ويكون لديهم مشكلات في التفاعل الاجتماعي، والتواصل، واللعب التخيلي.

2- اضطراب ما يسمى بطيف التوحد

- ويشتمل على ما يلي:

أ- عرض اسبيرجر:

والذي يشتمل على ضعف نوعي في التفاعل الاجتماعي، ولديه سلوكيات نمطية وتكرارية، وفي المقابل لا يوجد تأخر في اللغة أو التطوير المعرفي أو مهارات العناية الذاتية وتظهر المشكلات الاجتماعية عادة في سن المدرسة بشكل واضح حيث يكون هناك مشكلات في التفاعل وإظهار الانفعالات مع الأقران.

ب- اضطراب النمو الشامل غير المحدد:

والذي يشتمل على العديد من مظاهر التوحد، ولكن في الأغلب يكون من الدرجة البسيطة وليس الشديدة أو الشاملة لكل جوانب الاضطراب، ولعل أهم مظاهر الاضطراب لدى هؤلاء الأطفال تكمن في الجوانب الاجتماعية في المهارات اللفظية وغير اللفظية.

ج- اضطراب الطفولة التحليلي:

عادة لا يظهر الا بعد سنتين من عمر الطفل، بعدها يبدأ بفقدان المهارات الأساسية، وتصبح لديه حركات غير عادية، ويصاحبه مشكلة في اللغة الاستقبالية والتعبيرية، وتظهر مشكلات في المهارات الاجتماعية والسلوك التكيفي، وكذلك في القدرة على تطوير علاقات صداقة مع الأقران، ومشكلات في التواصل من خلال فقدان أو ضعف في اللغة المنطوقة، ولدى الطفل سلوكيات نمطية وتكرار للنشاطات، ويصاحبه عادة إعاقة عقلية شديدة، ولا يوجد لدى الطفل مشاكل عصبية.

د- عرض ريت:

ويظهر لدى الإناث عادة، وأسبابه جينية عادة حيث أن النمو في البداية يكون طبيعياً في الجوانب الحركية ومحيط الرأس وبعد ذلك بطيء في نمو الرأس بين (5-48 شهراً) ويظهر قصور في استخدام اليدين بطريقة صحيحة وعدم القدرة على المشي بطريقة مناسبة، وصعوبات في الجانب اللغوي سواء الاستيعابي أو التعبيري، وكذلك يصاحبه عادة مشكلات عصبية، وإعاقة عقلية شديدة، وقصور في جانب العلاقات الاجتماعية. وتدهور في الحالة مع تقدم العمر.

خصائص التوحد

الخصائص الاجتماعية:

إن إحدى أبرز خصائص وأعراض التوحد هو السلوك الاجتماعي، وقد وصفت الكثير من البحوث والتقارير التي كتبها الوالدان هذه المشكلة ورأى الكثير أن ذلك هو مفتاح تحديد خاصية التوحد، ويمكن تصنيف المشكلات الاجتماعية إلى ثلاث فئات: المتقوقع اجتماعيا، والوسط اجتماعيا، والأخرق اجتماعيا.¹

المنعزل (المتقوقع) اجتماعيا:

يتجنب هؤلاء الأفراد فعليا كل أنواع التفاعل الاجتماعي، والاستجابة الأكثر شيوعا هي الغضب/ أو الهرب بعيدا عندما يحاول أحد الناس التعامل معه/ معها. وبعضهم مثل الأطفال يحنون ظهورهم للوراء لمن يقدم لهم المساعدة لتجنب الاحتكاك.

اللامبالي اجتماعيا:

إن الأفراد يوصفون بأنهم وسط اجتماعيا لا يسعون للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين (ما لم يريدوا هم شيئا) ولا يتجنب المواقف الاجتماعية بفعالية، فلا يبدو أنهم يكرهون الاختلاط بالناس ولكن في الوقت نفسه لا يجدون بأسا في الخلو مع أنفسهم. ويعتقد بأن هذا النوع من السلوك الاجتماعي شائع لدى أغلبية الأفراد التوحديين.

الأخرق اجتماعيا:

هؤلاء الأفراد قد يحاولون الحصول بشدة على الأصدقاء ولكنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بهم، وهذه المشكلة شائعة لدى الأفراد الذين لديهم عرض (اسبيرغر) وأحد الأسباب في فشلهم في إقامة علاقات اجتماعية طويلة الأمد مع

¹ لدكتور (ستيفن م إيدلسن) من مركز دراسات التوحد، اوريجون.

الآخرين قد يكون عدم وجود التبادلية في تعاملاتهم حيث أن أحاديثهم تدور غالباً حول أنفسهم وأنهم أنانيون.

الخصائص الجسمية والصحية:

يبد التوحيدين بمظهر جذاب وصحة جيدة¹ كما أن التوحيدين يكون مظهرهم طبيعياً جداً عندما يولدون² إلا أن اضطراب التوحد يمثل حالة لا تمنع إصابة الفرد بأمراض أو اضطرابات أخرى³ مترافقة ومن بعض المشاكل التي تترافق مع الاضطراب⁴:

1- مشاكل النظر- الحركات المضطربة للعيون.

2- مشاكل السمع- عجز السمع.

3- المشاكل المحددة للتخاطب واللغة.

4- الحالة غير السوية للبشرة.

5- مشاكل العظام والمفاصل.

الخصائص السلوكية والحركية:

من أبرز الصفات لدى التوحيدين هي⁵:

1. السلوك التخريبي.

2. إثارة الذات، حركات لا إرادية كالرفرفة.

3. قلة الدافعية.

¹ الشربيني، لطفي، 2000م. أساليب جيدة لعلاج التوحد. مجلة الطب النفسي الإسلامي. العدد 62

² السعد، سميرة 1997م. دراسة حول تقدير والدي الأطفال المصابين بالتوحد. الكويت والسعودية، المجلة التربوية العدد 45

³ جولد جوريث 2000م. تعريف الدراسة التشخيصية للاضطرابات الاجتماعية. الكويت، مركز الكويت للتوحد.

⁴ جيلبيرز وبيتزر، التوحد مظاهره الطبية والتعليمية، مترجم. الكويت. مركز الكويت للتوحد.

⁵ السويدي، عائشة (2000) خصائص الطفل التوحيدي، ورقة عمل ندوة الإعاقة التماثلية.

4. الانتقاء الزائد للمثيرات، كالميل لمثير معين بإفراط.

5. مقاومة التغيير.

وتتلخص مظاهر النمو الحركي لفئة التوحد في صعوبة أداء المهارات الحركية العامة والمهارات الحركية الدقيقة.¹

الخصائص النفسية والانفعالية:

حتى الآن لم توضح الدراسات التي أجريت على التوحد أي من الخصائص النفسية فيه ولكن مع ذلك فإن بعض الحالات التي درست في العيادات الطبية تقترح أنه لا يوجد الكثير من الاضطرابات النفسية في التوحد، والدراسات الاكلينيكية تشير إلى حدوث الاكتئاب في التوحد إلا أن نسبة الانتشار الدقيقة للاكتئاب في التوحد ما زالت غير معروفة. إن المخاوف الشديدة والفوبيا غالباً ما تظهر لدى الأطفال المصابين بالتوحد الذين يعانون من فرط الإدراك الحسي، وإذا وجد فإنه يستمر لفترة طويلة بالإضافة إلى ردود فعل غريبة تعيق تقدمهم وأدائهم.

ولعل من بين التعبيرات الشاذة في الحالات الانفعالية النفسية ضرب البطن أو لف الأصابع في حالة التعبير عن الفرح، أو الضحك الشاذ غير الموظف في حالة التوتر، وقد أكدت الدراسات أن الحالة النفسية للتوحدين يمكن أن تتبدل بين متضادين بسرعة دون سابق إنذار. كما يمكن أن يظهر الطفل المصاب بالتوحد بعض مشاعر الغيرة والإحساس بالسعادة والتعلق بالآخرين والحرن.²

¹ الروسان، فاروق، (2001) مناهج وأساليب تدريس ذوو الاحتياجات الخاصة (المهارات الحركية). الطبعة الأولى الرياض: دار زهراء للنشر.

² كوك، جليا، وجولدينغ، مارجريت (2001) م الاحتياجات المنهجية الخاصة لأطفال التوحد. ترجمة مركز الكويت للتوحد، سلسلة نشر الوعي بالفئات الخاصة (21) الطبعة الأولى. الكويت مركز الكويت للتوحد.

خصائص التوحد (قبل عمر ثلاث سنوات)

1- اضطراب في التفاعل مع الآخرين والسلوك الاجتماعي:

- لا يتواصل مع الآخرين, لا بالنظر ولا باستخدام الاشارات للتفاعل معهم.
- عدم التركيز البصري.
- يتجاهل وجود الآخرين من حوله.
- لا يشاركهم باهتماماته.
- عدم القدرة على التفاعل مع الاطفال.
- عدم تجاوب لطلبات الآخرين.
- يلبي حاجاته بمفرده أو يستخدم يد الشخص الآخر لتلبيتها.

2- القدرات اللغوية ومهارات التواصل:

الاستيعاب:

- لا يتجاوب مع اللغة المحكية
- عدم الالتفات عند مناداته باسمه.
- لا يتجاوب مع الاحداث المحيطة به وبشكل خاص الكلام.
- تجاهل اوامر الاهل.

التعبير اللغوي:

- انعدام أو قلة الكلام.
- تأخر بالنطق.
- يعيد الكلام بشكل ببغائي (اذا سألته ما اسمك يجيب ما اسمك؟)
- يصعب عليه استخدام الكلام للمحادثة والتواصل.
- تردد الكلمات.
- عدم التعبير عن حاجاته بالكلام.

3- اللعب واستخدام الخيال:

- ضعف في القدرة على اللعب والابداع واستخدام المخيلة من أجل اتمام نشاط بناء.
- لا يستخدم العا ب بطريقة مناسبة.
- لا يتشارك بالعا ب الجماعية.
- صعوبة في التركيز على نشاط محدد.
- كثير الحركة أو قليل الحركة: يحرك، يركض، يدور.
- أو يظل في زاوية دون حراك.
- يقوم بحركات منكرة: يرفرف بيديه

يلعب بأصابعه

يهز برأسه

يدور حول نفسه

- يبحث عن الاثار الحسية (الضوء - الملمس).
- يندهش بالاشياء التي تدور أو التي تضوي.
- يبحث عن قرب جسدي من شخص محدد في محيطه.
- يتعلق بشيء معين أو جزء أو خاصة من شيء.

4- أعراض اضافية:

- يقوم بحركات متكررة:
- يرفرف بيديه
- يلعب بأصابعه
- يهز برأسه
- يبدو وكأنه لا يشعر بالام:
- حين يقع أو يحرق نفسه، لا يترجم احساس الالم بالبكاء.

- يقاوم التغيير:
- لا يحبّ الثياب الجديد
- لا يحبّ التغيير في أثاث البيت
- يحبّ أن يتبع روتين معيّن
- يؤذي نفسه:
- يعضّ يده
- يدقّ رأسه بالحيط
- يبدي انزعاجاً بالبكاء مثلاً دون سبب واضح للجميع
- يمكن أن يكون لديه بعض مواهب كالموسيقى مثلاً.

التفسيرات البيولوجية والسيكولوجية لمرض التوحد

تعددت تفسيرات اضطراب التوحد لدى الأطفال شملت التفسيرات البيولوجية

والسيكولوجية كما يلي:

1-التفسير البيولوجي:

تم التعرف على التوحد كاضطراب منذ كانر (1943 Kanner) والذي أكد على أن السبب وجود خلل في العقل وأن هؤلاء الأطفال ذوى التوحد يعتبرون من فئات المعوقين عقلياً ويرجع ذلك إلى الناحية الوراثية أو الجينية في العائلة (Baron – Cohen, 1991,) (385)

إن الضعف في الكروموزم Fragila choromosome هو المسئول عن حدوث هذا الخلل في الناحية العقلية ويؤدي إلى مرض التوحد ويظهر ذلك في 5% إلى 16% من حالات التوحد، وقد يعزو ذلك إلى انتشار التوحد لدى الذكور أكثر من الإناث، وأضاف سبباً آخر وهو أن التحجر في بعض الخلايا الداخلية Sclerois Tuberosus والذي تتحول إلى الجين المسيطر على الناحية العقلية وربما ذلك يؤدي إلى حدوث 5% من الحالات التوحد.¹

2-التفسير السيكولوجي:

يرجع الفضل إلى التفسير السيكولوجي كاضطراب التوحد إلى أسبرجر (1944) Asperger وقد سميت أعراض التوحد باسمه Asperger Syndrome وأوضح أن التوحد يتميز بزملة أعراض سلوكية²

وفي عام (1956) أضاف كانر Kanner أسباب أخرى نفسية تكملته لدراسة عام (1944) وذلك من خلال دراسة أجراها مع ايسنبرج Eisenberg and Kanner

¹ عمر بن الخطاب خليل (1994): خصائص أداء الأطفال المصابين بالتوحدية (الأوتيسية) على اختبار إيزنك لشخصية الأطفال (مجلة معوقات الطفولة - جامعة الأزهر)، مجلد 3، ص 345.

² Barber, C. (1996): The integration of every able pupil with Asperger syndrome into a mainstream school. Brithish journal of social Education, Vol. 23, No.1, March. P. 19

(1956) عن التبلد الانفعالي Refrigeration committal وأوضحا فيها أن رفض الوالدين لسلوك الطفل في البداية يؤدي إلى انسحاب الطفل وهروبه، حيث أكدوا أن الوالدين لا يرغبان في وجود هذا الطفل (Galdstein and other, 1986, 644)

وأكد كولفين (1971) Kolvin أن التوحد يعتبر من الاضطرابات النفسية في الطفولة ولا يرتبط بالنواحي البيولوجية ويحدث في الطفولة المبكرة منذ الميلاد حتى سنة أو سنتين ونصف.¹

ويعتبر التوحد من اضطرابات الطفولة وأن آباء الأطفال ذوي التوحد غالباً ما يكونون شخصيات وسواسية ولديهم تبلد انفعالي وجمود في المشاعر مما يقلل تفاعلهم مع أبنائهم مع العلم أن آباء وأمّهات هؤلاء الأطفال كانوا من المستويات والمراكز التربوية العالية.²

(5) الفروق بين الجنسين:

من استعراض الدراسات والبحوث اتضح أن نسبة حدوث مرض التوحد تزداد لدى الذكور أكثر من الإناث فقد أوضحت دراستي لورد وآخرون³ أن هناك فروقاً واضحة بين نسبة حدوث المرض بين الذكور ونسبتها لدى الإناث بنسبة 3:1 على التوالي.

¹ Goldstein, M. and Other (1986): Abnormal psychology Experiences, origins and Interventions little, Toronto Brownand company.p 641.

² Miller, M. (1990): Characteristics of autism literature review, In Eric.

³ Lord C. and others, (1982): Sex differences in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 12, No.4, Deec, P.317

الأعراض العامة للتوحد

- (1) اضطراب عملية الكلام، أو عدم الكلام مطلقاً: فالطفل الذي يعاني من التوحد قد لا يتكلم، وإذا تكلم فإن كلامه يكون غريباً وغير مفهوم أحياناً، ولا يقلد الآخرين في كلامه كما يفعل الأطفال الأسوياء.
- (2) الابتعاد عن إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين، وعدم الرغبة في مصاحبتهم، أو تلقي الحب و العطف منهم حتى لو كان هذا الحب وذلك العطف من الوالدين، وخاصة الأم، كما يظل الطفل التوحدي ساكناً لا يطلب من أحد الاهتمام به، وإذا ابتسم فإنه يبتسم للأشياء دون الناس، ويرفض الملاطفة والمداعبة، ويعمل على تجنبهما.
- (3) ظهور الطفل التوحدي بمظهر الحزين، دون أن يعي ذلك.
- (4) إظهار الطفل التوحدي للسلوك النمطي الذي يتصف بالتركرار، وخاصة في اللعب ببعض الأدوات، أو تحريك الجسم بشكل معين، وبدون توقف، وبدون الشعور بالملل أو الإعياء.
- (5) اضطراب النمو العقلي للطفل التوحدي في بعض المجالات، وظهور تفوق ملحوظ لديه أحياناً في مجالات أخرى. كما يبدو لدى بعض الأطفال التوحديين في بعض الأحيان أنهم يملكون مهارات ميكانيكية عالية، مثل معرفة طرق الإنارة، وتشغيل الأقفال، وإجادة عمليات فك الأجهزة و تركيبها بسرعة و مهارة.
- (6) كثرة الحركة، أو الميل للجمود، وعدم الحركة، و العزلة عمن حوله حسياً وحركياً.
- (7) عدم الإحساس الظاهر بالألم، وعدم تقدير الطفل التوحدي للمخاطر التي قد يتعرض لها، بالرغم مما قد يلحق به من أذى.
- (8) ظهور الطفل التوحدي بمظهر يختلف عن الأطفال الآخرين، مع سرعة الانفعال عندما يتدخل شخص ما في شؤونه، ويثور فجأة، خاصة عند الأطفال التوحديين الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات.

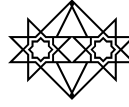
(9) الاستجابة بشكل غير طبيعي لبعض المثيرات من قبل الطفل التوحدي، وكأنه مصاب بالصمم، في حين قد يستجيب لبعض الأصوات بشكل مبالغ فيه. ويمكن اختصار الأعراض للنقاط الآتية والتي لا يشترط في أن تكون مجتمعة في طفل واحد والمعدل في الأعراض هو وجود ما يقل عن 5 نقاط على الأقل في الطفل الخاضع للتشخيص:

- (1) مقاومة التغيير.
- (2) الهلوسة أثناء النوم.
- (3) الإصرار على الروتين.
- (4) الصعوبة في فهم الانفعالات.
- (5) فقدان الاستجابة للآخرين.
- (6) ضعف القدرة العقلية العامة.
- (7) ترديد الكلمات دون فهم لمعناها.
- (8) قصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي.
- (9) معاناة الطفل التوحدي من صعوبات في النمو اللغوي.

المؤشرات العامة السلوكية الدالة التي يتفرد بها طفل التوحد

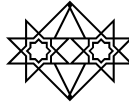
- (1) أن الأطفال التوحديين لا يحبون أن يحتضنهم أحداً.
- (2) أنهم في بعض الأحيان يبدون كأنهم لا يسمعون.
- (3) أن الأطفال التوحديين لا يهتمون غالباً بمن حولهم.
- (4) أنهم قد لا يظهرون تألمهم إذا أصيبوا.
- (5) أنهم يرتبطون بالأشياء ارتباطاً غير طبيعي.
- (6) أن الأطفال التوحديين لا يحبون اللعب بالكرة؛ في حين يمكن أن نجد لديهم مهارة عالية في ترتيب المكعبات أو غيرها من المهارات.
- (7) أن الأطفال التوحديين يقاومون الأساليب التقليدية في التعلم.
- (8) أنهم يحبون العزلة عن الغرباء و المعارف.
- (9) أنهم قد ينضمون إلى الآخرين تحت الإلحاح فقط.
- (10) أن بعض الأطفال التوحديين قد يملكون قدرات معينة مكن قبيل الرسم، والسباحة والعزف على الآلات الموسيقية.
- (11) أن بعضهم قد يكتسب بعض الكلمات بيد أنهم سرعان ما ينسوها.
- (12) أنهم لا يحبون التجديد، بل يحبون أن تبقى الأشياء في مكانها.
- (13) أنهم لا ينظرون في عيون الآخرين أثناء التحدث معهم.
- (14) أن الأطفال التوحديين يستخدمون الأشياء دون إدراكهم لوظائفها.
- (15) أنهم يفكرون و يتكلمون باستمرار عن شيء واحد فقط.
- (16) أن الأطفال التوحديين قد يضحكون أو يقهقهون دونما سبب.
- (17) أنهم يظهرون تفاعلاً من جانب واحد.
- (18) أنهم لا يدركون الأخطار بشكل عام.
- (19) أنهم يرددون الكلام دون فهم لمعناه فيما يسمى المصاداه.

(20) تكرار الحركات دون هدف أو نهاية معينة.



الباب الثاني

قياس التوحد وتشخيصه



سمات أطفال التوحد بحسب تصنيف Haward & Orlansky

أشار هوارد واورلنسكي 1980 Haward & Orlansky إلى السمات التي يتصف بها الأطفال عند الإصابة بالتوحد وهي¹:

- 1- العجز الجسمي الظاهر: وقد يترتب عن ذلك شكوك الأم بأن طفلها أصم أو كفيف.
 - 2- البرود العاطفي الشديد: حيث يفتقد الطفل عدم الاستجابة لمشاعر العطف والانتفاء من الآخرين، ويعتقد الأهل أن الطفل يعزف عن صحبة الآخرين ولا يهتم بأن يكون وحيداً.
 - 3- تكرار السلوك النمطي: مثل سلوك اهتزاز الجسم إلى الأمام وإلى الخلف أثناء الجلوس والدوران حول النفس، وترديد كلمات محددة أو جمل معينة لفترة طويلة من الوقت.
 - 4- سلوك إيذاء الذات ونوبات الغضب: وصعوبة تعامل الأهل مع الأنماط السلوكية الشاذة كأن يعض الطفل جسده حتى ينزف، أو يضرب رأسه بالحائط، أو بقطع أثاث حادة حتى يتورم الرأس ويصبح لونه أسوداً أو أزرقاً.
 - 5- الكلام النمطي: الأطفال عند التوحد يتصفون بالبكم، فهم لا يتكلمون ولكن يهتممون ويكون التكرار النمطي للكلام مباشراً وقد يحدث متأخراً.
 - 6- قصور السلوك: أي التأخر في نمو السلوك، فقد يكون العمر الزمني للطفل عند التوحد خمس سنوات، بينما سلوكه يتماثل مع سلوك الطفل العادي ذي السنة الواحدة من العمر. وهو يفتقد الاستقلالية Independancy بل يعتمد على الآخرين في طعامه، أو ارتداء ملابسه.
- * التوحد والعوق العقلي:

¹ التوحد ماهيته / أسبابه / أساليب التعامل معه / وحدة البحوث والتطوير / أكاديمية التربية الخاصة الرياض.

التدقيق في ملاحظة سلوك التوحد، يمكن تمييزه عن العوق العقلي، حيث تتشابه السمات السلوكية بينهما، وفيما يلي إيضاح للسمات الخاصة بكل منها:

التوحد والعوق

- 1- يفقد الطفل التعلق بالآخرين، حتى عند وجود نسبة الذكاء متوسطة لديه.
- 2- الطفل المعوق ينتمي ويتعلق بالآخرين، ولديه وعي اجتماعي نسبي.
- 3- الطفل عند التوحد غير قادر على التعبير اللفظي ولديه قدرة محددة للإدراك الحركي والبصري.

- 4- الطفل المعوق عقلياً يفقد القدرة على التغيير اللفظي والإدراك الحركي والبصري

- 5- صعوبة الاستخدام اللغوي، وإن وجدت اللغة فهي غير عادية.
- 6- الاستخدام اللغوي والتواصل مع الآخرين محدود للغاية.
- 7- العجز الجسمي والعيوب الجسمية أقل.
- 8- العيوب والعجز الجسمي نسبته أعلى عند الإعاقة العقلية.
- 9- السلوك النمطي ظاهر. والحركات الكبيرة مثل التأرجح يتم في صورة نمطية.
- 10- يختلف السلوك النمطي باختلاف الإعاقة العقلية.

المظاهر العامة للتوحد

تبدأ ملاحظة الأعراض في السنة الثانية والنصف من عمر الطفل (30 - 36) والمعروف أن التوحد له ثلاث أعراض رئيسية

1 - ضعف العلاقات الاجتماعية.

2 - ضعف الاهتمام في الناحية اللغوية.

3 - الاهتمامات والنشاطات المتكررة.

ويمكن تقسيم الأعراض العامة التي يظهرها الأفراد التوحدين إلى خمسة مجالات رئيسية هي:

5 - 1 - التفاعل الاجتماعي:

أ - عدم التواصل البصري مع الآخرين:

هو سلوك تكيفي غاية في الأهمية كونه يسهل الحياة اليومية للأفراد، حيث يتم من خلاله استنتاج أفكار الآخرين ورغباتهم ومشاعرهم ومدى انتباههم، وبالتالي فهو ضروري جداً في تطوير نظرية الأفكار التي تشير إلى إمكانية التنبؤ بسلوك الآخرين من خلال مشاركتهم في المعتقدات والرغبات والانتباه¹.

ودرس عام 1983 Donnelfan,Yoder,Mirnda أشكال ونماذج الاتصال العيني لأطفال التوحد ووجدوا أن أطفال التوحد ينزعون إلى التحديق ليس لجذب اهتمام الآخرين، وهم قلما ينظرون إلى الأشياء والآخرين بشكل مباشر، وتختلف نظرتهن عن الأطفال الطبيعيين، فهم يصرفون وقتاً طويلاً في الجلوس بهدوء دون أي تفاعل اجتماعي أو مشاركة مع الآخرين وقد يتصرفون بشكل غريب وغير عادي في الاتصال مع الأشياء مثل (المندبل، اللعبة)²

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 12.

² الجليبي، سوسن شاكر (2005): التوحد الطفولي (أسبابه، خصائصه، تشخيصه، علاجه)، ط 1، مؤسسة علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق ص30.

فقد يتجاهل الطفل التوحيدي الأشياء التي هي عادة ما يحب الأطفال رؤيتها، ويهر في ضوء معين أو بريق أو ورقة أو شيء يلف ويدور، وعندما يكون الأطفال صغاراً قد ينظرون إلى الأشخاص والأشياء بالمظهر العام وليس عن طريق التفاصيل الدقيقة، وهذا يقود إلى احتمال أن الأطفال يستخدمون جزءاً من النظر أو العين للنظر إلى الحركة أو المظهر العام، ومن المثير أن نعرف أن بعض الأطفال التوحيدين ينزلون الدرج أو يركبون الدراجة بدون أن يظهر أنهم يرون إلى أين يسيرون، وكذلك قد يجدون طريقهم في الظلام بسهولة كما في النور، وقد أوضح العديد من الأطباء النفسيين أن الأطفال التوحيدين عكس الأطفال العاديين فهم لا يركزون نظرهم على الأشياء أو الأشخاص لمدة طويلة ولكن يعطون نظرة سريعة ثم يحولون نظرهم، وهذا يعطي الانطباع أن الطفل التوحيدي يتحاشى عمداً النظر إلى وجوه الأشخاص وخاصة العين، ويظهر الطفل التوحيدي اهتمام متأخر بالصور ولكنه عندما يبدأ يهتم بالصور فهو يهتم بجزء محدد منها¹.

ب - اللعب:

يتعلم الطفل الطبيعي عن العالم حوله من خلال اللعب، بطريقة الاكتشاف والإحساس بالأشياء المختلفة فينمي اللغة والفهم للعالم من حوله، ثم يبدأ في استعمال الألعاب لترمز لما حوله من أشياء حقيقية².

يختلف لعب الأطفال التوحيدين عن لعب غيرهم من الأطفال حيث يعانون من مشكلة في اللعب الرمزي والأفكار التمثيلية، وفي التخيل كما أن لعبهم يفتقر إلى الابتكار والتجديد، وعدد ألعابهم أقل وأقصر وقتاً من المعتاد، وطريقتهم في اللعب غير عادية تتمثل في الاستخدام العدواني للألعاب وظهور الاستثارة الذاتية.

¹ السعد، سميرة عبد اللطيف (1992): معاناتي و التوحد، منشورات مركز الكويت للتوعية بالتوحد ص34.

² السعد، سميرة عبد اللطيف (1992): معاناتي و التوحد، منشورات مركز الكويت للتوعية بالتوحد ص38.

ويضيفون على الألعاب الصفات الحيوية ولا يميزون اختلافها عن الناس فقد يستمرون بإطعامها، ووضعها في الفراش للنوم، ويضيفون عليها الحواس مثل الذوق واللمس والشم والحوية والتسليم والاهتزاز ويتعاملون معها بطريقة واقعية جداً وبعيدة عن الخيال ويشعرون بالقلق والارتباك من هذه الألعاب وكأنها أشياء حقيقية رغم تقدمهم بالعمر الزمني¹.

وقد تكون اللغة هي العائق الأول لقدراته على النمو كما في اللعب أيضاً فيبقى الطفل التوحدي فترة و بسبب ضعف اللغة والتخيل لا يستطيع الأطفال التوحيديون الاندماج في اللعب مع الأطفال الآخرين².

ج - عدم فهم المشاعر:

يظهر الأفراد التوحديين عدم الاكتراث بمشاعر الآخرين نتيجة الصعوبات التي يواجهونها في فهم وتفسير التعبيرات المتمثلة في الإيماءات ونبرات الصوت وطريقة الجلوس، إضافة أن قدرتهم على تحمل انفعالات الآخرين أقل من المتوقع، ويعانون من صعوبات واضحة في التعبير عن مشاعرهم تتمثل بعدم مقدرتهم على إبداء التعبيرات الوجهية المناسبة لحالاتهم الانفعالية والتعبير عن المشاعر بطريقة مبالغ فيها وغير متوقعة³.

ويلاحظ على طفل التوحد ضعف في العلاقات الاجتماعية مع أمه..أبيه أهله والغرباء. بمعنى أن الطفل لا يسلم على أحد.. لا يفرح عندما يرى أمه أو أبوه.. لا ينظر إلى الشخص الذي يكلمه... لا يستمتع بوجود الآخرين و لا يشاركونهم اهتماماتهم...و لا يحب أن يشاركوه ألعابه.. ويحب أن يلعب لوحده... و لا يحب أن يختلط بالأطفال الآخرين. وأيضاً لا يستطيع أن يعرف مشاعر الآخرين أو يتعامل

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 12.

² السعد، سميرة عبد اللطيف (1992): معاناتي و التوحد، منشورات مركز الكويت للتوعية بالتوحد.

³ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 12.

معها بصورة صحيحة (مثل أن يرى أمه تبكي أو حزينة فهو لا يتفاعل مع الموقف بصورة طبيعية مثل بقية الأطفال) ويقضي وقتاً أقل مع الآخرين، ويبدى اهتماماً أقل بتكوين صداقات مع الآخرين، وتكون استجابته أقل للإشارات الاجتماعية مثل الابتسامة أو النظر للعيون¹.

ومن خصائص الطفل التوحدي عدم القدرة على تكوين علاقات اجتماعية والاحتفاظ بها فالطفل التوحدي ينسحب من جميع أشكال التفاعل والتواصل الاجتماعي، مما يؤدي لظهور العديد من المشكلات والصعوبات الواضحة في إقامة علاقة مع الآخرين، وتستمر الصعوبات والمشكلات لمرحلة الرشد².

د - اللغة:

يكون تطور اللغة بطيئاً، وقد لا تتطور بناتاً، ويتم استخدام الكلمات بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين، حيث ترتبط الكلمات بمعانٍ غير معتادة لهذه الكلمات، ويكون التواصل عن طريق الإشارات بدلاً من الكلمات، ويكون الانتباه والتركيز لمدة قصيرة، ويشمل خلل التواصل المهارات اللفظية وغير اللفظية، فقد تغيب اللغة كلياً وقد تنمو ولكن دون نضج وبتركيب لغوي ركيك مع ترديد الكلام مثل إعادة آخر كلمة من الجملة التي سمعها والاستعمال الخاطئ للضمائر حيث يستعمل الطفل ضمير "أنت" عندما يود أن يقول "أنا" فمثلاً لا يقول "أنا أريد أن أشرب" بل يستعمل اسمه فيقول "على يريد أن يشرب" وعدم القدرة على تسمية الأشياء وعدم القدرة على استعمال المصطلحات المجردة، ويكون للطفل نطق

¹ أبو العزائم، محمود جمال (2003): اضطراب الذاتوية، الصفحة النفسية، موقع د. محمود جمال أبو العزائم.

² الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 12.

خاص به يعرف معناه فقط من يخبرون ماضي الطفل، وقد أسماها كانر مجازاً
Metaphorical language ويكون الكلام على وتيرة واحدة¹

كما أن هناك كثير من الملامح غير السوية عند بدء الحديث لدى أطفال التوحد فقد
يردد الطفل ما يسمعه تواتراً وفي نفس اللحظة وكأنه صدى لما يقال وتعرف بظاهرة (المصاداة
Echolalia) والحديث التلغرافي والخلط في ترتيب الكلمات، أما التواصل غير اللفظي مثل
تعبيرات الوجه والإيماءات فغائبة أو نادرة².

وتتطور اللغة التعبيرية بنسبة ضئيلة لدى الأطفال الذين يعانون من التوحد، وقد
أظهرت الدراسات بأن 50% من هؤلاء الأطفال لم يطوروا أصلاً اللغة التعبيرية الوظيفية،
ومما يجدر ذكره فإنه في حال ظهور اللغة لدى الطفل فإنها غالباً ما تستخدم للطلب أو
التعبير عن بعض الرغبات وليس لأهداف التفاعل الاجتماعي أو ما يدعم هذا الجانب،
وغالباً ما تعود أسباب هذه المشكلة إلى الصعوبات التواصلية الاجتماعية لدى الأطفال
الذين يعانون من التوحد.

وقد ناقش عدد من الباحثين مؤخراً المشكلات الأساسية في التواصل عل أنها تمثل
العجز الأساسي في التوحد، أما المشكلات السلوكية فإنها تمثل العناصر الثانوية لهذه الحالة.
وتظهر نتائج بعض الباحثين على أنه عندما يتم تعليم الأطفال المشاركة في
سلوكيات مناسبة، فإن سلوكيات غير مناسبة من مثل العدوانية وإيذاء الذات
وبعض الاستثارات الذاتية تزداد بعدم وجود تدخلات علاجية خاصة، كما أظهرت
دراسات أخرى هذه العلاقة العكسية وذلك عندما يتم تعليم الأطفال بعض
الاستجابات الوظيفية التواصلية المماثلة، وقد تبين أن هناك إمكانية لتقليل أو منع
هذه السلوكيات الفوضوية المتمثلة في عدم الانتباه أو النزوع نحو التملص من

¹ أبو العزائم، محمود جمال (2003): اضطراب الذاتوية، الصفحة النفسية، موقع د. محمود جمال أبو
العزائم.

² الجليبي، سوسن شاكر (2005): التوحد الطفولي (أسبابه، خصائصه، تشخيصه، علاجه)، ط 1، مؤسسة
علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق ص34.

المهام، وذلك لدى تعليم سلوكيات تواصلية وظيفية مماثلة، فعلى سبيل المثال، من الممكن تعليم استخدام عبارة (هل هذا صحيح) لإثارة انتباه المدرس أو عبارة (أحتاج للمساعدة) للحصول على مساعدة المدرس لإنجاز مهمة صعبة¹.

يعاني جميع الأفراد التوحديين بلا استثناء من مشكلات في التواصل سواءً أكان لفظياً أو غير لفظي ويمكن تلخيص مشكلات التواصل اللفظي بما يلي:

1 - (50 %) أفراد غير ناطقين حيث لا يطورون الكلام، ويظهرون البكم والصمم لبعض الكلمات.

2 - (25 %) يطورون لغة بشكل غير طبيعي وغير وظيفي.

3 - (25 %) يطورون مهارات اللغة الطبيعية مع ظهور بعض المشكلات في ذلك².

ويتجلى اضطراب الاتصال عند الطفل التوحدي:

أ - الاتصال المتمركز حول الذات.

ب - اضطراب اللغة اللفظية.

ج - ظهور وسائل الاتصال غير اللفظية وتنقسم إلى:

1 - اللغة الجسدية (البدنية)

2 - أفعال ووسائل أخرى للاتصال³.

ونستطيع في نهاية هذا العرض التفصيلي لنواحي القصور الاجتماعي عند الطفل التوحدي أن نلخص سمات الطفل التوحدي كما صنفها جيلسون حيث يرى أن الطفل التوحدي لا يتطور اجتماعياً بخطى توازي نموه العقلي رغم قصور

¹ كوجل، روبرت - كوجل، لن (تدريس الأطفال المصابين بالتوحد (استراتيجيات التفاعل الإيجابية و تحسين فرص التعلم)، ترجمة أ.د. عبد العزيز السرطاوي، وزارة التربية و التعليم دولة الممارات العربية المتحدة، دبي ص50.

² الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 15.

³ شقير، زينب محمود (2000): اضطرابات اللغة و التواصل، ط1، دار النهضة المصرية، القاهرة.

التطور العقلي لديه، وهو يرى ثلاث جوانب لاختلال الأداء الوظيفي الاجتماعي للطفل التوحيدي إلى جانب اختلال الوعي الاجتماعي لديه وهي:

1- عدم قدرته على فهم أن الآخرين يختلفون عنه في وجهات النظر والخطط و الأفكار والمشاعر.

2- عدم قدرته على التنبؤ بما يمكن أن يفعله في المواقف الاجتماعية المختلفة.

3- العجز أو القصور الاجتماعي.

كما صنف المشكلات التي ترتبط باختلال الأداء الوظيفي الاجتماعي إلى ثلاث فئات:

أ - التجنب الاجتماعي.

ب - اللامبالاة الاجتماعية.

ج - الفظاظة الاجتماعية¹.

5 - 2 - مجال النشاطات والاهتمامات:

أ- ثبات الأشياء و الانشغال بها (السلوك الروتيني):

يطور الأطفال المصابون بالتوحد انشغالاً مفرطاً بأشياء محددة أو بنشاطات معينة أو بالحفاظ على الروتين أو عدم الغير في البيئة، وقد يكون لديهم أشياء يتفاعلون معها بطريقة خاصة، من مثل ترتيب السيارات الصغيرة تبعاً للحجم أو اللون، وإن محاولات إقحام الطفل مع ألعاب أخرى لكسر تلك النمطية أو النظام قد ينتج عنه نوبة غضب أو عدوانية.

ب - السلوك النمطي:

يتميز التوحيدي بالسلوك النمطي Stereotype ويعني تكرار نفس السلوك بشكل مستمر بدون أن يشعر بالملل أو التعب، ولذلك نجده يلعب ويقلب ويحرك

¹ محمد، عادل عبد الله (2002): الأطفال التوحيديون، دار الرشاد، القاهرة، ص33.

يديه وأصابعه أمام عينيه باستمرار دون هدف أو معنى، أو قد يستمر في تحريك جسمه إلى الأمام والخلف بشكل مستمر، أو ترديد بعض الكلمات عديمة المعنى بدون إدراك أو وعي لما يقوله أو أنه يحمل نفس اللعبة دائماً ويحملها ويرميها إلى الأعلى ثم يمسكها ويرميها مرة أخرى، وقد يقوم ببعض الحركات اللاإرادية غير المسيطر عليها مثل شد الذراعين أو الرأس أو المشي على أطراف الأصابع¹.

ج - السلوك التخريبي وإيذاء الذات:

تحتل نماذج التفسير والمعالجة التي تراعي عوامل مختلفة بالاهتمام المتزايد، وتذهب النماذج الاجتماعية البيولوجية إلى أن الألم عبارة عن ارتكاس على عدة مستويات تلعب فيها العوامل الجسدية والنفسية التالية دوراً في:

- الارتكاس الذاتي - اللفظي للألم.

- الارتكاس السلوكي الحركي للألم.

- الارتكاسات العضوية الفيزيولوجية للألم.

5 - 3 - الخصائص المعرفية:

يتميز الأفراد التوحديين بعدد من الخصائص المعرفية المتباينة من فرد لآخر ولعل من أبرز هذه الصفات:

أ - القدرات العقلية:

تعتبر ما نسبته (70 - 75 %) من الأفراد التوحديين معاقين عقلياً وتتراوح درجة الإعاقة من البسيطة إلى الشديدة جداً بينما تمثل النسبة المتبقية درجات ذكاء تزيد عن (70) وبالمتوسط ينجز الأفراد التوحديين في الجانب الأدائي لاختبارات الذكاء أفضل من الجانب اللفظي مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبة الكبيرة في تطبيق اختبارات الذكاء على الأفراد التوحديين.

¹ الراوي، فضيلة توفيق، حماد، أمال صالح (1992): التوحد والإعاقة الغامضة، الدوحة، قطر، ص25.

وتظهر نسبة بسيطة جداً من الأطفال التوحديين مواهب غير عادية في وقت مبكر¹.

و التوحيديون غالباً ما يتفوقون في التنظيم ويسجلون علامات أدنى من الذكور العاديين في امتحانات تتضمن توقع مشاعر الناس وتفسير تعابير وجوههم، لكن عندما يطلب من أحدهم إيجاد مثلث داخل تصميم معقد أو توقع حركة عصا معلقة بعجلة، يحققون نتيجة مشابهة للذكور العاديين إن لم تكن أفضل².

ب - الانتباه والدافعية:

ويبدو هذا السلوك في عدم الاهتمام أو الاكتراث للمثيرات المختلفة التي تحدث من حولهم في البيئة، فقد لا يهتمون بالحوافز أو المكافآت المختلفة التي تقدم لهم في حال قيامهم بسلوك مناسب، فهم لا يبدو أن أي نوع من أنواع الدافعية لأي شيء من حولهم³.

ويفتقد الطفل التوحيدي إلى الدافعية للقيام بالمهام التي تطلب منه وذلك لانشغاله في السلوكيات النمطية والروتينية، ويبدو أن الطفل التوحيدي لا توجد لديه الدوافع الموجودة عند غيره من الأطفال مثل الحاجة إلى الانسجام والتوافق والكسب الشخصي والرغبة في المنافسة والفوز وتقليد الآخرين مما يجعل المعززات المألوفة أقل فاعلية مع الأطفال التوحيديين.

ويعاني جميع الأفراد التوحيديين من اضطرابات في الانتباه متغيرة في الشكل والدرجة، فكثير منهم يعاني من الحركة الزائدة والتشتت والانتقال من موضوع لآخر

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 15.

² كاوي، جيفري (2003): البنات و الصبيان و داء التوحد، نيوز ويك العربية، العدد 170، 16 سبتمبر، دار الوطن، الكويت ص50.

³ الراوي، فضيلة توفيق، حماد، أمال صالح (1992): التوحد الإعاقة الغامضة، الدوحة، قطر، ص21.

قبل الاندماج في الموضوع الأول، وبعضهم لديه فترة انتباه طويلة للمواضيع التي تهمهم فقط.

وقد يظهر بعض الأطفال التوحدين خاصية الانتقائية الزائدة للمثيرات (Overselctivity Stimulus) والتي وصفها لوفاس وزملائه (Lovaas et al) في عام 1971 وهي تركيز الفرد على جزء واحد وبسيط من الشكل (ربما جزء غير مهم) وعدم التركيز على الأجزاء الأخرى للشكل (ربما أكثر أهمية) مثل التركيز في زقمة شخص المقابل وعدم التركيز في ملامح وتعابير وجهه¹.

ج - المزاج والمشاعر (اضطراب الوجدان):

خلال العام الأول من عمر الطفل يعيش الطفل البشري الطبيعي حالات وجدانية بدائية، فطرية ومتقلبة كما أن المعايشات الوجدانية في هذه السن تكون قصيرة الأمد ولكنها لا تؤدي إلى ردود فعل واسعة وشاملة.

وفي مرحلة لاحقة من حياة الطفل تمتد لعمر 3 - 4 سنوات يبدأ الطفل بفهم واستيعاب معنى الانفعال والتفاعل².

أما عند طفل التوحد فنلاحظ اضطراب في الوجدان يتظاهر ببعض السلوكيات مثل التقلب الوجداني (أي الضحك والبكاء دون سبب واضح) والغياب الظاهري للتفاعلات العاطفية ونقص الخوف من مخاطر حقيقية والخوف المفرط كاستجابة لموضوعات غير مؤذية أو أحداث القلق العام والتوتر.

ومن أهم الخصائص التي تلاحظ على أطفال التوحد هو عدم استجابتهم لمحاولة الحب أو العناق أو إظهار مشاعر العطف، ويذهب الوالدان إلى أن طفلهما

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 15.

² النابلسي، محمد أحمد (1989): أصول و مبادئ الفحص النفسي، ط1، جروس برس، بيروت، ص 76.

لا يعرف أحد ولا يهتم أن يكون وحيداً أو في صحبة الآخرين، فضلاً عن القصور والإخفاق في تطوير علاقات انفعالية وعاطفية مع الآخرين¹.

د - القدرات الحس حركية:

يظهر الأطفال التوحديين قدرات حس حركية أفضل من بقية قدراتهم الأخرى إلا أن لديهم تأخر وتباين في هذا المجال، ويتمثل هذا التباين في أن بعض الأطفال التوحديين لديهم قدرة على إيجاد الأصابع المخفية أو التعامل مع الألعاب الصغيرة جداً بينما هناك بعض الأطفال التوحديين يمضون متأخرين وبشكل أخرق ويسيل لعبهم باستمرار.

هـ الذاكرة:

يعاني جميع الأفراد التوحديين من مشكلات كبيرة في الذاكرة فهم وإن كانوا قادرين على تذكر الأحداث والتفاصيل البصرية إلا أنهم يحتاجون إلى تلميحات (ملقنات) لمساعدتهم على عملية التذكر والاستدعاء.

و - التنبؤ:

يعاني الأطفال التوحديين من صعوبات بالغة في التنبؤ بالأحداث والوقائع اللاحقة لذلك يشعرون بالارتباط والتوتر وحالة من الفوضى نتيجة عدم قدرتهم على معرفة المستقبل وتنخفض هذه الحالة عند معرفتهم بالخطوات اللاحقة.

5 - 4 - الخصائص الحسية:

يظهر الأفراد التوحديين تأخراً في اكتساب الخبرات الحسية كما يظهرون أشكالاً غير متناسقة من الاستجابات الحسية حيث تتباين من مستوى النشاط المنخفض جداً إلى مستوى النشاط المرتفع جداً والعديد منهم لا ينتبهون لأكثر من قناة حسية واحدة في نفس الوقت، ويظهر الطفل التوحدي وكأنه يعاني من مشاكل

¹ الجليبي، سوسن شاكر (2005): التوحد الطفولي (أسبابه، خصائصه، تشخيصه، علاجه)، ط 1، مؤسسة علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق ص32.

سمعية أو بصرية أو لسمية ولكنه يظهر في الوقت نفسه استجابات سريعة ويقظة لبعض المثيرات مثل الصوت الخافت أو الضوء المفاجئ مما ينافي وجود إعاقة سمعية أو بصرية لديه¹

ومن أبرز خصائص الأطفال التوحدين الحسية ما يلي:

أ - المثيرات الصوتية:

يظهر بعض الأطفال التوحدين حساسية سمعية حيث يسمع اصواتاً حقيقية لا يسمعوها الآخرون، مما قد تسبب له إزعاجاً وإدراكاً شديداً كما قد يبدو الطفل التوحدي كالأصم ففي الوقت الذي لا يستجيب فيه للأصوات المرتفعة جداً نجده يتألم وينزعج لبعض الأصوات الروتينية المعتادة مثل: نباح كلب، تشغيل محرك السيارة أو صوت جرس الهاتف أو صراخ أحد الأطفال أو تحريك المقاعد بالصف أو البيت أو صوت أمواج البحر، أو حفيف أوراق الشجر، أو تساقط المطر على السقف².

ب - المثيرات البصرية:

قد يبدو بعض الأفراد التوحدين أنهم لا يرون بعض المثيرات البصرية وبعضهم يخاف من رؤية بعض الألوان أو بعض أشكال الإنارة وأحياناً يحدث العكس حيث يوجد لدى بعض الأفراد حساسية بصرية تتمثل برؤية أشكال حقيقية لا يراها الآخرون³.

تتمثل هذه الأشكال بالتفاصيل الدقيقة للأشياء والتي لا ينتبه لها الشخص العادي، لهذا نجد أن الظروف المحيطة بالطفل إذا كانت صعبة أو سريعة التغير

¹ الراوي، فضيلة توفيق، حماد، أمال صالح (1992): التوحد الإعاقة الغامضة، الدوحة، قطر، ص25.
² الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 17
³ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 17.

كمحل ألعاب مزدحم هذا قد يسبب انزعاج الطفل التوحيدي وبداية لغضبه وبكائه. (السعد 1992، 34)

ج - المثبرات اللمسية والذوقية والشمية:

يلاحظ آباء الأطفال التوحيدين أنهم يفحصون العالم من حولهم عن طريق حواسهم من الشم واللمس والذوق ولكنهم يفعلون ذلك في وقت متأخر عن أقرانهم من الأطفال تجدهم يحبون لمس الخشب الناعم - البلاستيك - الفرو الناعم... الخ. الأطفال ممكن أن يتعرفوا على غيرهم بهذه الحواس، فقد يحبون شم يد والديهم وفحص وجه والديهم بلمسة خفيفة كما يظهر التوحيديون الصغار أحيانا أنهم غير حساسين للبرد أو للألم¹.

تعتبر خاصية اللمس من أكثر الخصائص تبايناً ففي الوقت الذي يوجد لدى بعض الأطفال التوحيدين حساسية جلدية كبيرة تجعله يتعد عندما يحاول أحد الأشخاص لمسه أو معانقته نجد بعضهم كأنه لا يشعر بالألم وقد لا يبكي على الرغم من تعرضه لأذى شديد جداً².

ونلاحظ لدى الأطفال التوحيدين قصور في وسائل الإدراك البصري واللمسي والشمي والذوقي فهم يميلون إلى الخلط بين الشكل والأرضية ويكاد يوزع نظره على الأشياء دون تركيز فقد يرى أشياء أطراف مجاله النظري وقد لا يستطيع التفرقة بين درجات الحرارة أو طعم الأشياء وقد يجد صعوبة في التوفيق بين الحركة والصوت³.

¹ السعد، سميرة عبد اللطيف (1992): معاناتي و التوحد، منشورات مركز الكويت للتوعية بالتوحد ص35.
² الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 17.
³ الجلبي، سوسن شاكر (2005): التوحد الطفولي (أسبابه، خصائصه، تشخيصه، علاجه)، ط 1، مؤسسة علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق ص33.

وبعد هذا العرض الشامل تقريباً لصفات التوحد نعرض فيمايلي لأهم الملامح الأساسية في التوحد كما وضعتها وزارة الصحة في سورية و تحت رعاية منظمة الصحة العالمية في دليل الصحة النفسية للأطباء والعاملين في هذا المجال فحددت هذه الملامح بما يلي:

- 1- يبدأ غالباً قرابة السنة الثالثة من العمر وقد يكون التطور حتى هذه السن طبيعياً أو غير طبيعي.
- 2- ضعف وتأخر النمو في التفاعل والتواصل الاجتماعي أي عدم استجابة الطفل وعدم تفاعله مع الآخرين حتى أبويه وتجنبهم بشكل فاعل، فهو لا ينظر إليهم على الإطلاق بل يبدو كأنه يركز بصره على نقطة تبعد عدة أمتال.
- 3- تأكيد وسواسي على عدم التغيير وتكرار الفعاليات والاهتمامات بالأشياء الجامدة، ويظهرون العديد من التصرفات الطقوسية المتكررة (فتح الباب وإغلاقه باستمرار لعدة ساعات، تشغيل الضوء وإطفائه لعدة ساعات، تقليب أوراق مجلة لعدة ساعات).
- 4- إن كل الأطفال المصابين بالتوحد تقريباً يظهرون سروراً واهتماماً باللعب بالماء
- 5- يتعاملون مع الناس وكأنهم أشياء جامدة (يستخدم ذراع أمه كعصا لجلب أشياءه
- 6- لغة هؤلاء الأطفال غريبة (صداء لفظي، يتكلم عن نفسه وكأنه شخص آخر، بعضهم لا يتكلم أبداً، تطور شاذ لطبقة الصوت).
- 7- قدرات غير معقولة (طفل بعمر خمس سنوات يقرأ صحيفة دون أخطاء مع أنه لا يفهم ما يقرأ)
- 8- الدور الخيالي في اللعب كثيراً ما يكون غائباً، وعادة يكونون وحيدون خارج محيطهم، ولا يحبون مشاركة الآخرين من أقرانهم¹.

¹ بايزيد، محمد نبيل (2001): دليل الصحة النفسية للأطباء و العاملين في الرعاية الصحية الأولية، وزارة الصحة، دمشق ص18.

الفئات التي يمكن أن تصاب بالتوحد(الأوتيزم)؟

التوحد(الأوتيزم) أحد الاضطرابات النمائية واسعة الانتشار pervasive developmental disorders (PDD)، والتي يشار إليها الآن باستخدام توصيف جديد هو اضطرابات التوحد واسع النطاق أو واسع المجال (ASD) (autism spectrum disorders).. يمكن أن يصيب الأفراد من مختلف الجنسيات والخلفيات العرقية والمستويات الاقتصادية الاجتماعية. وتشير التقديرات الحالية أن حوالي 400,000 فرد في الولايات المتحدة مصابون بالتوحد(الأوتيزم)، وتزيد الإصابة به في الذكور عن الإناث بنسبة 3 أو 4 - 1 بنين إلى بنات. ويحدث التوحد (الأوتيزم) لدى كل الأفراد على مختلف مستويات الذكاء. فنجدهم أن حوالي 75% من الأطفال التوحدين يمتلكون ذكاءً منخفضاً أقل من المتوسط، بينما يوجد حوالي 10% منهم يظهرون ذكاءً نوعياً مرتفعاً في مجال محدد كالرياضيات مثلاً.

كيف تنمو اللغة والكلام لدى الأطفال التوحدين(الأوتيزم)؟

تعد الثلاث سنوات الأولى من حياة الطفل هي أكثر سنوات الحياة تأثيراً في نمو اللغة والكلام وهي فترة تعرف بسرعة نمو الدماغ ونضجه، فيكتسب الطفل مهارات اللغة والكلام والتي تتمثل من خلال العالم الغني من حوله بالأصوات والمناظر، كما تنمو هذه المهارات أيضاً نتيجة الاستماع إلى اللغة والكلام من الآخرين. ويستهدف نمو وتطور مهارات اللغة والكلام في هذه المرحلة تحقيق التواصل أو التفاعل مع العالم الخارجي.

وتظهر أولى العلامات الدالة على التواصل بعد أيام قليلة من حياة الطفل عندما يتعلم الطفل أن بكاءه يجعل الآخرين يسرعون لإطعامه، أو لإراحته، أو لمرافقته. ويبدأ الأطفال الرضع في التعرف على الأصوات الهامة مثل أصوات أمهاتهم. ويبدؤون في ترتيب الأصوات أو (الفونيمات) "أو تجميعها لتكوين كلمات لغتهم. وقد أظهرت الأبحاث أن بحلول الـ 6 شهور الأولى من العمر يستطيع معظم الأطفال التعرف على الأصوات الأساسية في لغتهم.

كما تنضح مكانيزات أو الأجزاء المسئولة عن الكلام مثل (الفك، الشفاه، اللسان، والحنجرة) كما ينضح الصوت، ويصبح الرضيع قادراً على السيطرة على الأصوات. وهذا السلوك يبدأ في الشهور القليلة الأولى من حياة الأطفال في الفترة المعروفة بفترة المناغاة أو الهديل "cooing"، كما يشعر الطفل بالسُرور والسعادة في هذه الفترة عندما يكرر الأصوات. وبحلول الشهور الـ 6 الأولى من العمر يبدأ الأطفال في تكرار المقاطع الصوتية مثل "با، با، با، با" وسرعان ما تتحول إلى أصوات عديمة المعنى يغلب عليها إيقاع الكلام الطبيعي ونغمته بيد أنها لا تحتوى على كلمات ذات معنى حقيقي. وعند نهاية سَنَتِهِم الأولى، يكون معظم الأطفال قادرين على نطق بعض الكلمات. بالرغم من أنهم لا يفهمون معنى هذه الكلمات. لكنهم قد يفهمون معناه فيما بعد نتيجة استجابة المحيطين لهذه الكلمات.

وبوصول الطفل سن الـ 18 شهراً يكون معظمهم قادرين على نطق ما يقرب من 8-10 كلمات. وبوصولهم سن سنتين يكون لديهم القدرة على وضع الكلمات معاً لتكون جملاً مثل "مزيداً من الحليب" "more milk". وخلال هذه الفترة سرعان ما يتعلم الأطفال ان الكلمات هي رموز أو تمثيل للموضوعات، والأحداث، والأفكار. وفي هذه السن أيضاً يظهرون القدرة على التمثيل أو اللعب الادعائي، وبوصولهم لسن 3، 4، 5 سنوات تزداد الحصيلّة اللغوية لديهم، ويبدأ الطفل أو الطفلة في إتقان والتمكن من قواعد لغته الأصلية. وهذه القواعد تتضمن الجانب الصوتي phonology (أصوات الكلام speech sounds) الجانب الصرفي morphology (تشكيل الكلمات word formation) الجانب النحوي syntax (تشكيل الجمل sentence formation) الجانب الدلالي semantics (معنى الكلمات والجمل word and sentence meaning) العروض prosody (نغمة وإيقاع الكلمات intonation and rhythm of speech) والجانب البرجماتي pragmatics (استخدام اللغة بفعالية pragmatics).

اضطرابات التواصل الشائعة لدى الأطفال التوحدين

(1) - تأخر النمو اللغوي

- يستطيع الرضع المناغاة، أو أنهم يبدأون بها في سنتهم الأولى ثم يتوقفون، وعادة عدم قدرة الطفل على اكتساب اللغة حتى سن السادسة من العمر فتستمر لديه عدم المقدرة على التواصل.

- عندما تظهر لغة الطفل يكون شكل هذه اللغة غير طبيعي وبها الكثير من العيوب كالترديدية في الحديث (وهي ترديد الكلمات والجمل بطريقة غير ذات معنى) وقد تكون الكلمات والجمل مفيدة كترديد إعلانات التلفزيون. وقد أثبتت الدراسات أنها مرحلة بين التواصل اللفظي وغير اللفظي ويمكن استخدامها في تنشيط الفعاليات.

- بعض الأطفال يكون لديهم عكس الضمائر (أنت بدلاً من أنا) ونسخ ما يقوله الآخرون (كاللبغاء).

- وقد يكون هناك اضطراب في إخراج الصوت واللغة، فبعض الأطفال يتحدثون بنبرة بطيئة ثابتة بدون تغيير حدة الصوت أو إظهار أي انفعالات، وقد يكون هناك مشاكل في المحادثة والتي غالباً ما تتحسن مع النمو، وآخرون قد يكون لديهم الحديث المتقطع.

2- شيوع المشكلات اللغوية

شيوع المشكلات اللغوية يعتقد الكثير من المختصين أن المشكلات اللغوية من أكثر وأهم المشكلات المميزة للتوحيدين، فهناك 50% من التوحدين لا يستطيعون التعبير اللغوي المفهوم، وعندما يستطيعون الكلام تكون لديهم بعض المشكلات في التواصل اللغوي، وهذه المشكلات العامة هي التي تحدد تطور الطفل التوحدي وتحسنه، ومنها:

1. تأخر النطق أو انعدامه.

2. فقد المكتسبات اللغوية.

3. تكرار الكلام التريديد لما يقوله الآخرون كالبيغاء.
4. سوء التعبير الحركي اللفظي.
5. شيوع كلمات وجمل بدون معنى.
6. عدم القدرة على تسمية الأشياء.
7. إعادة الكلمة أو الجملة عدة مرات.
8. عدم نمو لغة مفهومة حتى لو استطاع النطق.
9. عدم القدرة على التواصل اللغوي مع الآخرين.
10. الإسقاط: وهي نطق الجمل والعبارات ناقصة.
11. عدم القدرة على التعبير عن نفسه، والتواصل مع الآخرين.
12. عدم القدرة على التعلم والتدريب اللفظي.¹

(3) - ضعف فهم اللغة

- الإدراك اللغوي لدى هؤلاء الأطفال فيه اضطراب بدرجات مختلفة، فإذا كان التوحد مصحوب بتخلف فكري فعادة ما يكون لدي الطفل كمية ضئيلة من اللغة المفهومة، والآخرون الذين لديهم اضطراب أقل قد يتابعون التعليمات المصحوبة بالإشارة، أما مَنْ كانت إصابتهم طفيفة فقد يكون لديهم صعوبة في الاختصارات واللغة الدقيقة، كما أنهم لا يستطيعون فهم تعبيرات المزاح والسخرية.
- يواجه الأطفال التوحيديون مشكلات في تذكر تسلسل الكلمات - ولذلك يمكن كتابة التعليمات على الورق إذا كان الطفل يستطيع القراءة.
- تعلم الأسماء أكثر سهولة من تعلم الأفعال: فالطفل يستطيع تكوين صورة للاسم في مخيلته، بينما من الصعب عليه عمل ذلك بالنسبة لغير الأسماء - لذا: يُنصح بأن تُعرض الكلمات بصورة واضحة للطفل.

¹ طلعت حمزة الوزنة (2004م)، التوحد بين التشخيص والعلاج، ط/1

(4) - ضعف التواصل

(أ) - التواصل اللفظي

- تؤثر الإعاقة لدى الأطفال التوحديين على مهارات التواصل اللفظي: فهم يوصفون بأن لديهم قصوراً كلياً في نمو اللغة المنطوقة، إذ أنهم لا يتكلمون، وتصبح لديهم إعاقة في إقامة محادثات مع الآخرين.

- وعندما لا يتطور الكلام لديهم فإن الخصائص الكلامية مثل طبقة الصوت ؛ والتنغيم؛ ومعدل الصوت ؛ وإيقاع ونبرة الصوت تكون شاذة.

- توصف لغة التواصل لديهم بأنها تكرارية أو غطية مثل تكرار كلمات أو جمل مرتبطة بالمعنى.

- يتميزون بأن لغتهم لها خصوصية غريبة، فلا يفهمها إلا الأشخاص الذين يألّفون أسلوب تواصلهم فقط، وهم غير قادرين على فهم الأسئلة البسيطة، ويكونوا غير قادرين على دمج الكلمات مع الإيماءات لفهم الحديث.

(ب) - ففي الطفولة المبكرة، قد يشيرون للآخرين أو يجذبونهم باليد إلى الأشياء التي يرغبونها بدون أي تعبيرات على الوجه، وقد يحركون رؤوسهم أو أيديهم عند الحديث، وعادة لا يشاركون في الألعاب التي تحتاج إلى تقليد ومحاكاة، كما أنهم لا يقلدون ما يعمله والديهم كأقرانهم.

- وفي المرحلة الوسطى والمتأخرة: لا يستخدم هؤلاء الأطفال عادة الإشارة حتى عندما يفهمون إشارة الآخرين، البعض منهم قد يستخدم الإشارة ولكن عادة ما تكون متكررة.

وهؤلاء الأطفال عادة ما يظهرون المتعة والخوف أو الغضب، ولكن قد لا يظهرون سوى طرفي الانفعالات، كما أنهم لا يظهرون التعبيرات الانفعالية على الوجه التي تظهر الانفعالات الدقيقة. - التواصل غير اللفظي.¹

(5) - الصمت الاختياري

هي حالة نادرة جداً، حيث يكون الطفل التوحدي كالأصم الأبكم، فهو لا يعير الآخرين والأصوات أي انتباه، ولا ينطق بأي كلمة في أي وقت، قياس السمع لديه طبيعي، ولكنه لا يرغب في التواصل مع الآخرين.

اضطرابات التواصل:

تأخذ اضطرابات التواصل شكلين أساسيين هما اضطرابات اللغة واضطرابات الكلام.

اضطرابات اللغة:

تتمثل اضطرابات اللغة في ضعف أو غياب القدرة على التعبير عن الأفكار أو عن تفسيرها وفقاً لنظام رمزي مقبول بهدف التواصل. وهي تشمل:

1- الاضطرابات اللغوية النمائية.

2- الاضطرابات اللغوية التعليمية.

3- الحبسة الكلامية (الأفيزيا)

اضطرابات الكلام

أما اضطرابات الكلام فهي تتمثل في ضعف القدرة الفسيولوجية على تشكيل الأصوات بشكل سليم ومن ثم استخدام الكلام بشكل فعال. وهي تصنف ضمن ثلاث فئات رئيسية وهي:

أ. اضطرابات اللفظ وتشمل الإبدال والإضافة والحذف والتشويه.

¹ سيمون كوهين و باتريك بولتن (2000م)، حقائق عن التوحد، ترجمة عبدالله إبراهيم الحمدان، ط1، الرياض: أكاديمية التربية الخاصة.

- ب. اضطرابات الطلاقة أو الانسياب الكلامي وتشمل التأثأة أو الكلام بسرعة فائقة.
- ت. اضطرابات الصوت وتشمل الخنة الانفية والبعة الشديدة.
- ث. الاضطرابات الفمية - الوجهية الناجمة عن تشوهات في الشفتين (مثل الشفة الأرنبية) أو الحلق (شق الحلق) أو الأنف أو الفم.¹
- الأسباب:**

- وثة أسباب عديدة لاضطرابات التواصل ومنها:
- أ. الأسباب البيولوجية (عصبية أو جينية أو كروموسومية أو أيضية).
- ب. الأسباب النمائية. وتتمثل في أشكال مختلفة من التأخر في نضج الجهاز العصبي
- ج. الأسباب البيئية. وتتمثل في العوامل البيئية والثقافية والأسرية المضطربة مثل الحرمان وعدم توفر الإثارة الكافية والتسمم
- د. الأسباب النفسية والتعليمية. وتتمثل في التعلم الخاطئ وفي توقع الفشل وأنماط التواصل غير السليمة والاضطرابات النفسية الداخلية
- هـ. الأسباب الوظيفية: وتتمثل في الاستخدام الخاطئ للحوال الصوتية والأجهزة الداعمة للكلام.

الكشف المبكر عن الاضطرابات الكلامية واللغوية

يمثل استخدام الطفل اليومي للغة لأغراض التواصل والتفاعل الاجتماعي أفضل معيار للحكم على كلامه ولغته.

وعليه فإن المعلمين وأولياء الأمور يستطيعون القيام بأدوار بالغة الأهمية في الكشف المبكر عن الاضطرابات الكلامية واللغوية لدى الأطفال. وفي المدارس، يمكن تنفيذ إجراءات كشفية منظمة ودورية على أيدي اختصاصي اضطرابات

¹ ابراهيم عبدالله الزريقات (2004 م)، التوحد الخصائص والعلاج، ط1، عمان: دار الفكر.

الكلام. وبما أن مدارسنا لا يعمل فيها هؤلاء الاختصاصيون فإن الكشف المبكر عن الاضطرابات الكلامية واللغة مسؤولية المعلم. ولا يعني ذلك أن يقوم المعلم بدور التشخيص، فما هو مطلوب منه طلب مساعدة أهل الاختصاص أو تحويل الأطفال إليهم في حالة توقع مشكلات كلامية أو لغوية لديهم.

وفيما يلي قائمة بأهم المؤشرات على الاضطرابات الكلامية واللغوية:

- (1) عدم وضوح الكلام أو اللغة.
- (2) تكلم الطفل بطريقة مختلفة تماماً عن الأطفال الآخرين.
- (3) إظهار الطفل لأعماط جسمية غير عادية عندما يتكلم كأن يحرك بطرق ملفته للنظر فمه أو لسانه أو يديه أو رأسه.
- (4) ظهور بعض الملامح على أن الطفل يشعر بالحرج وعدم الارتياح عندما يتكلم.
- (5) عدم ملاءمة نوعية الصوت مثل التكلم من الأنف أو بحة الصوت وغير ذلك.¹

التوحد واضطراب التواصل:

حيث أن اضطرابات اللغة والكلام والجوانب المعرفية مظاهر أساسية في التوحد، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تشابه بين التوحد والاضطرابات اللغوية، وبسبب هذا التشابه فإنه يتم الخلط أحياناً بين التوحد وهذه الاضطرابات 0 اضطرابات اللغة الاستقبالية وجد أنها تتشابه مع اضطرابات اللغة التي يظهرها الأطفال التوحديين، نتائج الدراسات في هذا المجال أشارت إلى أنه مع وجود تشابه بين التوحد واضطرابات اللغة الاستقبالية فإنه يمكن التمييز بين الاضطرابين الأطفال من ذوي الاضطرابات اللغوية الاستقبالية يحاولون التواصل بالإيماءات وبتعبيرات الوجه للتعويض عن مشكلة الكلام، بينما الأطفال

¹ سيمون كوهين و باتريك بولتن (2000م)، حقائق عن التوحد، ترجمة عبدالله إبراهيم الحمدان، ط1، الرياض: أكاديمية التربية الخاصة.

التوحيدين فإنهم لا يظهرون تعبيرات انفعالية مناسبة أو رسائل غير لفظية مصاحبة، قد تظهر المجموعتان إعادة الكلام ولكن الأطفال التوحيدين يظهرون إعادة كلام وخاصة إعادة الكلام المتأخر أكثر، يفشل الأطفال التوحيدين في استخدام اللغة كوسيلة اتصال ولكن الأطفال في اضطرابات اللغة يتعلمون فهم مفاهيم اللغة الأساسية والرموز غير المحكية ويحاولون التواصل مع الآخرين، وبناءً عليه فإن القدرة أو القابلية على التعلم والتعامل مع الرموز تعتبر الفارق الرئيسي بين المجموعتين.¹

- كيف يمكن علاج اضطرابات اللغة والكلام في التوحد؟

عندما يشك الطبيب في وجود التوحد أو أي عجز نمائي آخر عند الطفل فإنه يحيله إلى فريق من المتخصصين؛ يتضمن أخصائي علاج اضطرابات اللغة والكلام، والذي يقوم بعمل تقييم شامل لقدرة الطفل على التواصل ويقومك بتصميم وإدارة برنامج علاج خاص بهذا الطفل.

لا توجد طريقة علاج يمكن ان تحسن بنجاح التواصل لدى كل الأفراد التوحيدين. ومن الأفضل ان يبدأ التدخل مبكراً أثناء سنوات ما قبل المدرسة، كما يجب أن يكون البرنامج مخطط ومصمم بصورة فردية، ويجب أن يستهدف كلاً من السلوك والتواصل، ويتضمن كذلك الآباء أو مقدمي الرعاية الأساسيين. ويجب أن يستهدف العلاج تحسين التواصل الوظيفي، فبالنسبة للبعض، قد يكون التركيز على التواصل في مواقف واقعية بينما يمكن ان نركز مع آخرين على التواصل الإشاري، بينما يمكن ان نستخدم مع آخرين نظام التواصل الرمزي مثل لوحة الصور. كما يجب أن تتضمن الخطة العلاجية فترات تقييم دقيق ومتعمق من قبل متخصص في تقييم وعلاج اضطرابات اللغة والكلام، كما قد يشترك المعالجون الآخرون لتدريب الفرد على خفض السلوك غير المرغوب فيه الذي قد يؤثر على تطور مهارات التواصل.

¹ كتاب المدخل إلى التربية الخاصة د/ يوسف القريوتي د/ عبد العزيز السراطوي د/ جميل الصمادي

وفيما يتعلق بالبرامج العلاجية التي يجب أن تقدم للأطفال التوحدين نجد أن هناك بعض المتخصصين يرحبون بتنظيم برامج علاجية سلوكية تقوم على تعديل السلوك، بينما يرى آخرون أن العلاج المنزلي أو بالمنزل يجب أن يكون هو القاعدة أو الأساس لأنه يعتمد على تدريب هؤلاء الأطفال على التصرف في مواقف حقيقية. بينما يؤيد البعض المداخل الأخرى كالعلاج بالموسيقى والعلاج المعتمد على التكامل الحسي، والذي يعمل على تحسين قدرة الطفل على الاستجابة للمثيرات الحسية وهو يبدو مفيد جداً لبعض الأطفال التوحدين لتنمية قدرتهم على الاستجابة للمثيرات الخارجية.¹

كما أن استخدام بعض الأدوية قد يحسن من قدرة الطفل على الانتباه لفترات أطول أو قد تساعد على خفض بعض السلوكيات غير المرغوب فيها مثل خفقان اليد، لكن الاستعمال طويل المدى لهذه الأدوية قد يكون له آثار جانبية خطيرة لذا يجب أن تعطى هذه الأدوية تحت إشراف مباشر من قبل الطبيب المختص. ولا توجد أدوية حتى الآن يمكنها أن تعمل على تحسين التواصل لدى هؤلاء الأفراد autistic. كما يمكن استخدام الفيتامينات والأطعمة الخاصة وكذلك العلاج بالتحليل النفسي لكن حتى الآن لم يثبت البحث مدى فعاليتها.

التوحد واضطرابات السمع والبصر:

الانسحاب الاجتماعي، والانزعاج من تغيير الروتين، وسلوكيات أخرى يمكن أن تظهر من قبل أطفال صم وهو يشبه السلوك الذي يظهره الأطفال المتوحدين، هذه السلوك تعتبر ثانوية بالنسبة للصم، ونتيجة لاضطرابهم ولكنها أولية وأساسية في حالة الأطفال المتوحدين، معظم المتوحدون ليسوا صماً، وإذا شك بالطفل بأنه يعاني من التوحد فإنه يجب أن يتم فحص سمعه لاستبعاد إصابته بالصمم.

¹ كتاب المدخل إلى التربية الخاصة د/ يوسف القريوتي د/ عبد العزيز السراطوي د/ جميل الصمادي

الأطفال المكفوفون أو ضعاف البصر يمكن أن يظهروا استثارة ذاتية وحركات نمطية تشبه ما يقوم به الأطفال التوحديين، وأكثر من ذلك فإن اضطراب التوحد في الاستجابة إلى المؤثرات البصرية يمكن أن تشير إلى التوحد في أول انطباع .

تعريف مفهوم التشخيص وأهميته

يدل مصطلح " تشخيص " على تحديد سبب أو أسباب مرض أو سلوكيات خارجة عن إطار الحدود الطبيعية. وعندما يُحدد السبب فهو غالباً ما يوصف بإسم أو عبارة معينة مثل " التوحد أو التأخر العقلي أو صعوبات التعلم.... " فتحديد المسمى التشخيصي يساعدنا كأهل ومختصين في عدة أمور منها ¹:

- العثور على المعلومات الخاصة بالمرض أو الاضطراب من خلال الكتب، المقالات، المختصين وشبكة الانترنت.
- تحديد التوقعات لمدى تحسن الاضطراب.
- تحديد التوقعات لسلوكيات الشخص بناءً على تشخيصه.
- تحديد السبب أو الاسباب وراء السلوك غير السوي للشخص.
- تحديد العلاج مثل وضع الخطط التعليمية والتربوية الملائمة لحالة الشخص.

¹ الشامي، وفاء. 2004، سمات التوحد، تطورها وكيفية التعامل معها، مركز جدة، السعودية، ص19.

كيف يتم تشخيص من يعانون التوحد؟؟؟

لا توجد دلالات بيولوجية تظهر على جميع المصابين بالتوحد، فإنه بالتالي لا يوجد فحص طبي لتشخيص التوحد. بل ان المعايير لتشخيص التوحد تعتمد على الجانب السلوكي فقط.. وبالتالي يتم تشخيص الأفراد الذين يعانون من التوحد عندما تظهر عليهم سلوكيات مطابقة لمعايير تشخيص التوحد. أي إذا كان الطفل يعاني تأخرا شديدا في إكتساب مهارة الكلام وقصورا إجتماعيا ملحوظا وكان يفتقد القدرة على التخيل واللعب التمثيلي، شُخصت حالته بالتوحد. والواقع أن الامر ليس سهلا حيث أن التوصل الى التحقق من وجود هذه السمات السلوكية يتطلب البحث مع والدي الطفل في جميع تفاصيل مراحل نمو الطفل، وإجراء بعض الإختبارات للاستدلال على وجود اضطراب التوحد كمقياس درجة التوحد الطفولي أو الاختبارات النفسية العامة أو بملاحظة السلوك بشكل عام.

دور الطبيب في تشخيص التوحد

إن الطبيب هو غالبا أول من يلجأ إليه الأهل عندما يقلقون بشأن تطور الطفل. وإستنادا الى الأعراض السلوكية الى جانب التّقصي والإستماع بدقة الى المعلومات التي يزوده بها والدا الطفل عن تاريخ تطوره ونموه وسلوكه، يقوم الطبيب بتحويل الطفل الى اختصاصي السمع للكشف عن سمعه، ومن ثم تحويله الى اختصاصي نفسي لإجراء الاختبارات المناسبة وتحديد التشخيص الرسمي للطفل.

اختبار سالي آن: يرى الطفل دمية اسمها "سالي" تراقب دمية أخرى اسمها "آن" و هي تضع كرة في السلة، تغادر "آن" الغرفة و تقوم "سالي" بنقل الكرة من السلة إلى الصندوق و عندما تعود "آن" يطرح على الطفل سؤال: أين ستبحث "آن" عن الكرة؟ في السلة أم في الصندوق؟ يستنتج معظم الأطفال أن "آن" ستبحث في السلة لأنها لا تعرف أن الكرة الزجاجة قد تم إخفاؤها، لكن الطفل التوحدي سيبحث في المكان المخبأ فيه الكرة مع إجابات مختلفة كما أنهم يستطيعون تفسير ما حدث بإجابات عفوية و بشكل صحيح على خلاف الأطفال العاديين. يرى «

كوهن - « Cohan أن نظرية العقل تتطلب نظاماً تمثيلاً يساعد على إعداد رسم بياني أو خريطة للحالة العاطفية للآخرين، بطريقة مختلفة عن طريقة التقاط مشاعرهم مباشرة. حيث يمكن رسم النوايا من خلال خريطة للتمثيل العاطفي تمثل 05 أبعاد - كأن الحالة العاطفية تشبه الكرة الأرضية- مترابطة يبرز جانبها من موقف ناظرها، إلا أن الناظر لا يستطيع أن يرى بعض الأبعاد الـ 05 المتمثلة في: "الهدف الموجه، النية، الدافع، الشعور، الهدف المحدد. " تؤدي مثل هذه المشاركات الدافعية و العواطف إلى حالة الإدراك الحسي بالنسبة للآخرين و هذا يعتبر العلامة الدالة في " نظرية العقل"، ورغم من أن نقص نظرية العقل يمكن أن يكون مسؤولاً عن بعض الإعاقات الاجتماعية النمطية في التوحد إلا أنه لا يسبب هذه السلوكيات¹

أدوات تشخيص وقياس التوحد

إن اضطراب التوحد يغطي مجالاً واسعاً من مستوى القدرات النمائية بحيث تشتمل على جميع مستويات الأداء العقلي الذكاء كما أن هذا الاضطراب يتضمن العديد من الأعراض بدرجات متفاوتة ومهارات تواصل مختلفة ومستويات متباينة للكفاية الذاتية إن هذا التباين في أعراض و صفات التوحد ضمن مجموعة الأطفال التوحدين تعتبر تحدياً كبيراً لأدوات وأساليب التشخيص والمقيمين الإكلينيكين ومن هنا تأتي أهمية معرفة أسس التشخيص والقياس وضوابطه والاعتبارات التي من الضروري أن يتبناها ويراعيها المهنيين القائمين على تشخيص وقياس الأطفال التوحدين ويوجد عدد من أدوات قياس وتشخيص التوحد منها:

1- قائمة تشخيص للأطفال المضطربين سلوكياً (مقياس رملا ند).

2- أداة تقدير السلوك للأطفال التوحدين والعاديين.

3- قائمة سلوك التوحد.

¹ محمد صالح الإمام و فؤاد عبد الجوالدة، التوحد و نظرية العقل. الطبعة الأولى (2010)، دار الثقافة للنشر و التوزيع - عمان - الأردن.

4- مقياس تقدير التوحد الطفولي.

5- نظام ملاحظة السلوك.

6- جدول الملاحظات التشخيصية للتوحد.

7- قائمة أوصاف التوحد.

8- مقابلة تشخيص التوحد.

فالمقياس الأول هو اختيار من متعدد عبارة عن استبانة للوالدين تركز على الأداء الوظيفي للطفل والنمو المبكر و استبانة تركز على استعادة الأحداث الماضية وسوف الحق بالبحث نموذج مصور لهذا المقياس.

أما المقياس الثاني فهو عبارة عن ثمانية مقاييس يجاب عليها من الملاحظة مباشرة وتتطلب مقدرين مدربين وتم تعريف كل سلوك إجرائيا كنظام تسجيل.

أما المقياس الثالث فهو مصمم للاستخدام في المدارس العادية.

أما المقياس الرابع فهو نظام تقدير عبارة عن محكات سلوكية محددة جداً تتطلب تدريباً قليلاً للاستخدام معدلة للاستخدام مع المراهقين والكبار.

أما المقياس الخامس فهو عبارة عن ملاحظة مباشرة تتطلب تدريباً للملاحظ تم تحديد السلوكيات بشكل موضوعي ثم تحليل الدرجات الخام عن طريق الحاسب الآلي.

والمقياس السادس عبارة عن نظام ملاحظة مقنن وفق ما يحدث في الواقع مع الحالة يكون الفاحص شخص مشارك ملاحظ.

والمقياس السابع عبارة عن قائمة تستخدم من قبل الوالدين تشتمل على عدد كبير من الفقرات السلوكية.

والمقياس الثامن عبارة عن أداة تبحث في الأحداث الماضية بالاعتماد على المقابلة تبدأ من العمر 5 سنوات حتى المراهقة المبكرة.

أما أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تشخيص وقياس الأطفال التوحدين فهي كالتالي:

1- يكون التشخيص من خلال فريق تشخيص متعدد التخصصات ويمكن أن يشتمل الفريق على الأخصائي النفسي، أخصائي الأعصاب، طبيب الأطفال، أخصائي العلاج الطبيعي، أخصائي العلاج المهني، أخصائي التواصل، وطب نفس الأطفال و معلم التربية الخاصة وغيرهم ويعتبر قياس مجالات مثل المجال النفسي والتواصل والسلوكي من أكثر المجالات التي تركز عليها إجراءات قياس الطفل التوحيدي.

2- أن تشتمل إجراءات التشخيص والقياس للأطفال التوحدين على مجالات نمائية ووظيفية متعددة وذلك راجع إلى طبيعة الإعاقة لديهم ولهذا فإن الوضع يتطلب قياس قدراتهم الحالية مثل المهارات الإدراكية والتواصلية والأداء السلوكي مثل الاستجابة للتعليمات تشتت الانتباه والسلوكيات المزعجة والتكيف الوظيفي مثل مهارات السلوك التكيفي في المواقف الحياتية اليومية.

3- أن يتم تبني النموذج النمائي في إجراءات القياس خاصة وأن أغلبية الأطفال التوحدين لديهم تخلف عقلي ومن الضروري أن تفسر الدرجات التي يحصلون عليها في المقاييس المختلفة ومستوى الأداء في المجالات المتعددة في ضوء مستواهم النمائي والإدراكي وذلك للحصول على تفسير وظيفي واقعي.

4- أن يراعى الاختلاف بين المواقف أثناء إجراءات التشخيص والقياس حيث طبيعة موقف معين ومتطلباته والمثيرات المحيطة به ودرجة تنظيمه ومدى الألفة له من قبل الأطفال التوحدين والأشخاص المتواجدين في ذلك الموقف يختلف عن مواقف أخرى قد يلاحظ فيها الأطفال ويتم تقييمهم كما أن سلوك الطفل يختلف من موقف إلى آخر تبعاً لاختلاف المتغيرات أنفة الذكر.

5- ضرورة مراعاة التكيف الوظيفي وذلك لان فهم وتفسير نتائج القياس للمهارات المختلفة يتطلب ربطها بطبيعة ومضمون تكيف الطفل مع متطلبات المواقف الحياتية اليومية الحقيقية ولهذا فانه يتوجب على المقيم أو الملاحظ أن يتأكد من أن القياس شامل ومتعمق للسلوك التكيفي للطفل ومدى قدرته على ترجمة الإمكانيات والقدرات لديه إلى سلوك ثابت ومناسب لتنمية الكفاية الذاتية لدية في المواقف الطبيعية كما يتوجب على الملاحظ كذلك مراعاة مدى تأثير نتائج التشخيص والقياس على تكيف الطفل المستمر وتعليمه والإفادة من ذلك في الرابط بين نتائج القياس وتصميم برنامج التدخل الملائم له.

6- أن يتم استخدام أفضل وسائل التشخيص والقياس للأداء الوظيفي للطفل التوحيدي بناء على المعرفة العلمية والخبرة والحكم الإكلينيكي للمهني المختص ومع التأكيد على أهمية ملائمتها لخصائص واحتياجات الطفل الفردية وبما أن مشكلات الانتباه والسلوك قد تكون عقبة في طريق إجراءات التقييم للطفل فانه من الضروري استخدام الأساليب التي تساعد على جذب انتباه الطفل وتعاونه مع المقيم ويمكن استخدام المعززات الغذائية والمادية والاجتماعية الفعالة والمناسبة للطفل لتحقيق ذلك كما يتوجب على المهني مراعاة أن يقدم مهام وأنشطة المقياس أو الأداء بما يتلاءم مع خصائص الطفل وأسلوب الأداء لديه مثل تنظيم البيئة وتهيئته للتحويل من مهمة إلى أخرى واستحداث روتين معين لإتباعه والتوجيهات الحازمة الواضحة وعلى المقيم أن ينتبه إلى تأثير التفاعل الاجتماعي ومتطلباته على أداء الطفل إنشاء إجراءات التشخيص والقياس فكلما زادت متطلبات أداء المهمة أو النشاط الاجتماعي كلما اثر ذلك سلباً على أدائه ولهذا فانه من الضروري مساعدة الطفل لجعله يركز انتباهه أكثر على العناصر المادية للأنشطة والمهام التي يطلب منه أدائه بدلا من التركيز على التفاعل الاجتماعي مع المقيم أو المقيمين الأطفال التوحيدين يلاحظ عليهم أحيانا اختلاف في مستوى أدائهم لنفس المهمة أو النشاط من موقف إلى آخر ولهذا فان مراعاة

تعدد المواقف التي يقيم فيها قد تساعد على معرفة مستوى الأداء الحقيقي لديه في المجالات المختلفة للتشخيص والقياس.

7- أن تشترك أسرة الطفل التوحيدي في إجراءات تشخيص وتقييم طفلها وإن يتم دعمها لملاحظة الطفل وتقييمه جنباً إلى جنب مع المختصين ليتم بناء برنامج تربوي متكامل.

8- ويتوجب على المهنيين تفسير نتائج الاختبارات والمقاييس لأسرة الطفل وتخصيص وقت خاص وكاف لمناقشة تلك النتائج والاستماع إلى همومهم والصعوبات التي يواجهونها مع طفلهم في بعض المواقف وبرامج التدخل المتوفرة للطفل ويفضل أن يحضر هذه المرحلة من التشخيص والقياس أحد المهنيين المختصين في برامج التدخل المبكر الملائمة للطفل لمناقشة النتائج والتوصيات العلمية وكيفية تفعيل تلك التوصيات إلى واقع ملموس لخدمة الطفل وأسرته وإشعار الأسرة بأن خدمة طفلهم لا تتوقف عند حد تشخيصه بأنه توحيدي.

9- اشتمال التقرير النهائي للتقييم على النتائج التي توصل إليها كل عضو من أعضاء فريق التشخيص والقياس المتعدد التخصصات بتفاصيلها وإن يصاغ التقرير بأسلوب يسهل فهمه وتوصيات يمكن تطبيقها وتفعيلها ومرتبطة بتكيفه مع متطلبات الحياة اليومية وتعلمه ويفضل أن يكون التواصل مستمر بين أعضاء الفريق أثناء عملية التشخيص والقياس وقبل التوصل إلى النتائج النهائية لتلافي عدم تنسيق الجهود أو تكرارها كما أنه من الضروري دمج النتائج في التقرير النهائي ومناقشتها في ضوء ما يترتب عليها من إجراءات وظيفية لكل مجال من مجالات التشخيص والقياس ولإعطاء الأسرة والعاملين مع الطفل صورة متكاملة عن جوانب القوة والضعف لديه.

ثانيا: الجهات المسؤولة عن تشخيص التوحد:

فريق العمل ودور كلا منهم في التشخيص:

لقد أكدت الأبحاث الحديثة أنه لا بد من وجود فريق عمل متكامل لتشخيص حاله الطفل التوحدي أي لا ينجح طرف واحد فقط في وضع التشخيص بمفرده ويحتوى فريق العمل على كلا من:

(أ) الطبيب النفسي ودوره في التشخيص:

إن المهمة الرئيسية للطبيب عموما هي التأكد من سلامة التشخيص فيجب على الطبيب معرفه التاريخ المرضي للطفل وسلوكه منذ البداية ومدى مطابقة نمط سلوكه مع توحّد الطفل المبكر ثم يُمضي في التحقق مما اذا كان الطفل مصابا بأي نوع من الاضطرابات التي شخّصت خطأ على أنها اضطراب التوحّدية.

(ب) طبيب اللغة والتخاطب:

يكون أخصائي التخاطب واحد من فريق العمل المهمين لتقييم عمر الطفل اللغوي وذلك في ضوء الملاحظة المباشرة للطفل فانه يلاحظ ويقم الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه ويقوم أخصائي التخاطب بتحديد عمر الطفل اللغوي وبذلك نستطيع أن نضع نقطه البداية في خطه العلاج لتعليم الطفل المهارات اللغوية.

(ج) طبيب السمع:

يعتبر طبيب السمع من أهم أعضاء الفريق التشخيصي وأول من يجب عرض الحالة عليه لكي يحدد إذا كان الطفل يسمع أولا لان من أهم الأشياء التي تلفت نظر أباء الأطفال التوحديين أن الطفل يظهر أمامهم كأنه طفل أصم حيث لا يسمع من يناديه. ولكن يستجيب لأصوات معينه فقط من إعلانات التلفزيون وصوت الثلاجة عند فتحها فبالتالي يصاب أبائهم بالحيرة فيعرضوا أطفالهم على أطباء السمع وذلك لتقييم حده السمع لديهم.

(د) طبيب الأعصاب والوراثة:

يكون طبيب الأعصاب مسئولاً عن الدراسات الذهنية مثل اختبار النشاط الكهربائي بالمخ والاختبار الذي يختبر هياكل المخ أما طبيب الوراثة فيقوم بتفسير وعمل الدراسات الكروموزومية والبحث عن الأخطاء الميلادية والتي قد تكون سبب في وجود أعراض عديدة عند الطفل التوحد.

وعادة لا يكون أطباء الأعصاب والوراثة جزءاً مباشراً في فريق التقييم ولكن يتم استخدامهم كمستشارين خاصيين يكملون البيانات الهامة عن الطفل التوحد ويتبادلون الحديث مع باقي أعضاء الفريق لوضع أسس تشخيصية وعلاجية.

(هـ) الوالدين:

الحوار مع الوالدين فإن إقامة الحوار المتكامل والصريح عندما ينتبه الوالدان بأن طفلهم معاق وغير طبيعي من شأنه أن يرسخ انطباعات إيجابية في ردود أفعالهم واتجاهاتهم نحو مشكله طفلهم في المستقبل.

فمعظم الآباء يفضلون أن يعرفوا اسم الاضطراب الذي يعاني منه طفلهم وهذا أمر غاية في الفائدة للوالدين وللأبن حيث أنهما الأقدر على بذل المجهود لمساعدة أبنهما.

(و) المدرسون:

إن المدرس عضو واحد في الفريق الذي يهتم ويعنى بمساعدة الطفل التوحد فعلياً أن يعمل ويتعاون مع الأطباء كما أن مهمة المدرسة هي تلقين الطفل التوحد السلوك الاجتماعي المعقول من خلال تدريبه على بعض المهارات التي يستطيع من خلالها الاعتماد على نفسه في المأكل والملبس وأن يظل نظيفاً وذلك باستخدام مناهج التدريس والتقنيات الحديثة.

المقاييس المستخدمة في اختبارات التوحد

هناك عدد من المصادر لتشخيص التوحد ونذكر منه

1- الدليل التشخيصي للأمراض النفسية من الجمعية الأمريكية للطب النفسي :DSMIV

ويعتمد هذا الدليل على الآلية التالية

أ \ إحراز عدد 6 نقاط أو أكثر بشكل إجمالي

1. ضعف في العلاقات الاجتماعية (اثنان على الأقل)

- ضعف شديد في استعمال التواصل الغير اللغوي مثل النظر بالعين و تعابير الوجه

وحركات الجسم المستعملة في العلاقات الاجتماعية

- عدم القدرة على اكتساب صداقات مع أقرانه

- ليس لديه الرغبة في مشاركة الآخرين ما يفعلونهم أو ما يفعله

- ضعف في التبادل العاطفي والاجتماعي مع الآخرين

2. ضعف في التواصل (واحد على الأقل)

- عدم النطق أو تأخر في اكتساب القدرة على الكلام

- ليس لديهم رغبة في ابتداء أو استمرار الحديث

- ترديد بعض الكلمات بصفة متكررة \ أو استعمال كلمات غريبة

- عدم القدرة على اللعب التخيلي او التقليد الاجتماعي

3. نشاطات وأفعال متكررة (واحد على الأقل)

-انشغاله بنشاط أو نشاطين متكررة ومحددة سواء كان بشكل مكثف او ان تكون

غريبة

- متمسك بروتين أو طقوس معينة

- حركات متكررة عضلية سواء في رفرفة بالأصابع أو اليدين \ أو دوران حول نفسه..الخ
متعلق ببعض الأشياء

ب- أن يكون هناك تأخر في العلاقات الاجتماعية أو اللغة أو اللعب التخيلي قبل أن يبلغ
الطفل السنة الثالثة

ج- وأن هذا الاضطراب ليس متعلق باضطراب ريت أو التفكيكي

2- المقابلة التشخيصية للتوحد

يوجه للوالدين يستغرق مدة تتراوح بين 90 إلى 120 دقيقة....

تتكون من عدد كبير من الأسئلة حوالي 97 سؤال وتركز هذه الأسئلة على ثلاث أقسام
مهمة: التجاوب الاجتماعي \ التواصل \ والسلوكيات والاهتمامات المتكررة
وهذه الأسئلة تقوم بتقييم الطفل في الوقت الحالي كما تهتم بعض الأسئلة بمراحل
التطور لديه في الماضي..وكلها تدور حول الأقسام الثلاث المذكورة أعلاه

ADI - R المقابلة التشخيصية للتوحد

من المقابلات التي تستعمل في المراكز المتخصصة في تقييم اضطراب التوحد
بشكل كبير وهى من المقابلات المشهورة التي تطبق في التشخيص..وأىضا في
الأبحاث...ويحتاج من يطبقها إلى تدريب خاص على كيفية استعمالها وحساب او
تحليل الإجابات

3- مقياس كارز..هذا المقياس معروف في جامعة نورث كارولينا وقام به شوبلر
مكتشف برنامج تيتش المشهور

وهو مكون من خمسة عشر فقرة من الممكن تطبيقها من خلال توجيه الأسئلة إلى
الوالدين أو أثناء المراقبة الإكلينيكية للطفل خلال اختبار بيب (وهو اختبار خاص بتقييم
قدرة الطفل التعليمية...أيضا تابع لمركز تيتش بنورث كارولينا)

ولمن يجب ان يأخذ فكرة عامة عن الفقرات التي يتضمنها اختبار كارز هي التعامل مع الناس \ التقليد \ التفاعل العاطفي \ حركات الجسم \ التعامل مع الأشياء \ التأقلم مع التغيير \ التفاعل النظري \ التفاعل السمعي \ تفاعل واستعمال حاسة الشم واللمس والتذوق \ الخوف او العصبية \ التواصل اللغوي \ التواصل الغير لغوي \ مستوى النشاط \ مستوى تفاعل القدرات الذهنية \ الانطباع العام.

هذا المقياس يحتاج تطبيقه إلى تدريب عملي فكل فقرة أعلاه لها درجات تتراوح من واحد إلى أربعة...والنتيجة النهائية هي حصول الطفل على درجات إجمالية تقسم الأطفال إلى توحّد شديد \ توحّد خفيف إلى متوسط \ لا يوجد توحّد

4- اختبار ادوس:

المراقبة لسلوكيات الطفل مهمة جدا في تشخيص التوحّد ومن المقابلات المشهورة المتخصصة في الملاحظة والتي تستعمل في المراكز المتخصصة..هو اختبار ادوس و هو عبارة عن مراقبة الطفل وسلوكياته في غرفة مخصصة عن طريق تقديم بعض ألعاب محددة له (الخاصة بالاختبار) وتسجيل تفاعل الطفل مع كل لعبة وقدرته على التواصل مع المختبر وتفاعله الاجتماعي وطريقة لعبه فمثلا ملاحظة الطفل في الأمور التالية: التواصل البصري \ مشاركة الاهتمام \ حركات الوجه \ المبادرة التلقائية \ محاولة جذب الانتباه \ التفاعل مع نشاط مشترك.. محاولة استعمال الإشارة.....وغيرها من الفقرات الهامة بعد ذلك تحسب النقاط التي حصل عليها الطفل وتوزع بشكل معين في الاستمارة الخاصة

و يحدد الطفل التوحدي من غير التوحدي وكذلك الطفل الذي لديه الاضطراب النمائي الغير محدد PDD-NOS

اختبار ادوس يقدم حسب قدرات الطفل على الكلام...فالطفل الذي لا يستطيع أن يتواصل باللغة اختباره مختلف عن الطفل الذي بإمكانه التحدث بجمل قصيرة...كذلك هناك اختبار يقدم للأطفال الذين يتكلمون بطلاقة...وللمراهقين و البالغين

مدة هذا الاختبار حوالي 30 دقيقة

الشخص الذي يطبق هذا الاختبار يحتاج أيضا إلى تدريب خاص في كيفية تطبيقه... وبعض المراكز تقوم بتسجيل الطفل على شريط فيديو أثناء تطبيق هذا الاختبار...حتى يتسنى لهم مراجعة النقاط التي سجلها الطفل بشكل أدق.

طبعا جميع هذه الاختبارات ليست مقننة للبيئة العربية ... لذا من المفضل تطبيق مقاييس واختبارات متعددة على الطفل بالإضافة إلى الملاحظة والكشف الإكلينيكي...حتى يتم التأكد من الأعراض

ومن هنا نرى أنه عند حضور الطفل مع والديه إلى العيادة لتقييم حالته....تحتاج المقابلة إلى وقت طويل قد يصل إلى الساعتين...وذلك بسبب كثافة الأسئلة الموجه الى الوالدين عن طريق المقاييس الخاصة التي قد يستغرق بعضها ساعة كاملة...كذلك وقت إضافي لملاحظة الطفل وسلوكياته في الغرفة الخاصة...كما أن بعض الحالات تحتاج إلى زيارة مرة أخرى للتأكد من بعض السلوكيات

وفي بعض المراكز في الخارج يستغرق تقييم الطفل الواحد نهار كامل...وذلك لان الطفل يقيم من عدد من التخصصات الأخرى كما ذكرنا فبالإضافة إلى الطبيب هناك الأخصائي النفسي وأخصائي التخاطب وأخصائي البرامج التعليمية.

الفحوصات المخبرية

من المهم أن نعرف انه لا يوجد أي تحليل أو أشعة يثبت لنا أو يجزم أن الطفل مصاب بالتوحد

ومعظم الاختبارات والتحليل المطلوبة من أهل الطفل هي لاستبعاد أمراض أخرى مصاحبة..أو مشابه للتوحد

فمثلا اختبار تقييم السمع من الضروريات الأساسية في كل طفل لديه ضعف في التواصل اللغوي... فمن المهم استبعاد ضعف السمع لديه... حتى لو كان الأهل مقتنعون أن قدرة السمع لدى طفلهم سليمة.... وكثيرا ما تؤكد لي الأمهات عند طلبي لهذا الفحص... أن طفلها يسمع... فهو يسمع نداءها في بعض الأحيان.. ولكن أحيانا لا يرد ولكن مع ذلك نحتاج إلى تقييم قدرة الطفل السمعية لاستبعاد أي ضعف حتى لو كان بسيط... فلو وجد هذا الضعف يصحح بالسماعات الطبية... ويحسن قدرة الطفل على الكلام

وهناك عدد من الفحوصات الأولية للسمع والتي قد يستخدمها أخصائي السمعيات ولكن هي عبارة عن مسح أولي. ولكن اختبار السمع عن طريق الكمبيوتر من الاختبارات الفعالة والذي يكشف أي ضعف لدى الطفل فهو يقيم السمع للأطفال في السنوات الأولى.. ولا يحتاج إلى تواصل لغوي أو تعاون من الطفل أثناء تأدية الاختبار أيضا من الفحوصات الهامة التخطيط الكهربائي للمخ...

EEG

وهو أيضا لاستبعاد أمراض أخرى مصاحبة.. مثل بعض أمراض الصرع التي تأتي أعراضها بضعف في النطق

MRI

وهو ما يسمى للرنين المغناطيس للمخ... وأهمية هذا الاختبار هو استبعاد وجود أي أورام في المخ.. لا قدر الله

أما بالنسبة لتحاليل الدم فهناك الروتين منها مثل الصورة الكاملة للدم... وتحاليل وظائف الكبد والكلى والأملاح

كذلك تحليل الغدة الدرقية... والاحماض الامينية في الدم... وهذه الاختبارات بعضها يطبق بشكل روتيني عند الولادة في بعض البلاد المتقدمة

طبعا الأحماض الامينية أهميتها لاستبعاد الأمراض الاستقلالية والتي تؤثر على النمو لدى الأطفال... مثل مرض الفينيل كيتون يوريا..وغيره

كذلك بالنسبة لاختبار الغدة الدرقية...فلو كان هناك نقص في الهرمون الخاص (الثايروكسن) فانه يعطي للطفل على شكل ادوية...وينقذ الطفل من إعاقاة التخلف العقلي أيضا من التحاليل في بعض الحالات تحليل الكروموزومات او الصبغات الوراثية وكذلك متلازمة فراجا يل.

هذه التحاليل الأساسية التي يحتاجها الطبيب لاستبعاد أمراض مصاحبة أو أخرى مشابهة للتوحد.

هناك بعض التحاليل الأخرى والتي تعتمد على النظريات التي ذكرناها سابقا..وهما أن هذه النظريات مازالت تحت الأبحاث...فالتحاليل المصاحبة لها لا تعتبر من الأساسيات...ولكن الكثير من الأهالي يحبون تطبيق الحمية الغذائية...لذا نقوم بطلب تحليل الببايد في البول ولكن هذا التحليل مكلف ماديا لأنه لا يتم في المختبرات المحلية..ونحتاج أرسله إلى المعمل في الخارج

كذلك هناك من الأهالي من يحب الكشف عن نسبة المعادن الثقيلة في الدم بالنسبة لطفله ... أو تحاليل المناعة...أو تحاليل الفطريات...وهكذا بعد أن حصلنا على كشف طبي كامل...وتقييم الطفل هو توحد ام لا من الناحية الطبية

نحتاج من يقوم بالكشف على قدرات الطفل العقلية..وذلك يكون عن طريق الأخصائي النفسي

أدوات تساعد في تشخيص التوحد

توصل عدد من المختصين إلى أدوات تساعد في تشخيص التوحد مثل قوائم الشطب وغيرها، وأهم تلك المقاييس ما يلي:

1. قائمة شطب سلوك التوحدين.

Checklist for Autism in Toddler (CHAT)

2. مقياس تقدير الأطفال التوحدين.

Childhood Autism Rating Scale (CARS)

3. مقابلة والدي التوحدين

Parents Interview for Autism (PIA)

4. قائمة جليام لتقدير سلوك التوحدين

Gilliam Autism Rating Scale (GARS)

5. قائمة تقدير مظاهر السلوك للأطفال التوحدين وغير الأسوياء

Behavior Rating Instrument for Autistic and other Atypical Children (BRIAC)، (يحيى، 2000)

عند تشخيص الأطفال التوحدين، فإنه من المهم إعداد تقييم عام لحالة الطفل وقدراته الوظيفية والقصور النمائي لديه ومستوى اللغة والتفاعل الاجتماعي مع المحيطين، كما أنه من الضروري جمع معلومات مختلفة عن الطفل للوصول إلى تشخيص دقيق عن الطفل، وأهم هذه المعلومات ما يلي:

أ_ دراسة حالة الطفل

تحتوي دراسة الحالة علة وصف لتاريخ الحالة، وتشتمل على فترة الحمل وفترة الولادة وفترة ما بعد الولادة وفترة النمو الحالية، إضافة إلى أساليب طبية متبعة مع الطفل والعقاقير التي يتناولها الطفل أن وجدت، ويذكر في تاريخ الحالة معلومات شخصية عن الآباء.

ب_ التاريخ الوراثي للحالة

يحتوي التاريخ الوراثي على وصف كامل للتاريخ الوراثي للحالة الأسرية، وإذا ما كانت هناك حالات توحد أخرى في العائلة إضافة إلى الأمراض الوراثية في العائلة.

ج- التقييم السلوكي

يحتوي على وصف للأعراض السلوكية التي يظهرها الطفل وهل يحتاج الطفل إلى تعديل سلوك وما هي الأساليب المتبعة في تعديل سلوك الطفل (Brany,1996)

نموذج الكشف عن التوحد

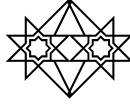
يتم التشخيص بناء:

- 1- على مجموعة من الأسئلة من اللائحة التالية تغطي مناطق ثلاثة من تطور الطفل
- 2- تعتمد من قبل اخصائي النمو والتطور
- 3- أن يكون عمر الطفل اقل من ثلاث سنوات
- 4- تم استثناء متلازمة رت ومتلازمة اسبرجر

	السؤال	نعم	قليلا	لا
1	هل يحب طفلك العناق والجلوس في الحضان			
2	هل يهتم بالأطفال من سنه ونفس عمره			
3	هل يحب المرح والقفز على الأثاث			
4	هل يميل إلى العناد (لا يرد على التلفون، لا يلبي النداء)			
5	هل يؤشر باصبعه الى شيء يريده أو يهمله مثل لعبة معينة			

	السؤال	نعم	قليلا	لا
6	هل يلعب بالعبه الصغيره مثل سيارة دون رميها وإحداث العطل بها			
7	هل ينظر بالعين لك للحظة أو لحظات			
8	هل يظهر حساسية بالغه من بعض المثيرات مثل أصوات معينة (يضع اصبعه بأذنه حتى لا يسمعها)			
9	هل يتفاعل مع تعابير وجهك مثل الابتسامه أو الضحك			
10	هل يقلد بعض تصرفاتك مثل بعض التعابير بحركات الوجه			
11	هل يستجيب لاسمه عند مناداته			
12	إذا نظرت الى لعبة أو شيء ما في الغرفة هل ينظر اليها ايضا ويركز عليها			
13	هل اصبح يفضل العزلة والوحدة			
14	هل يحاول جلب انتباهك لبعض نشاطاته واهتماماته			
15	هل خطر ببالك ان يكون طفلك اصم أو ابهم			
16	هل يفهم ما يقوله الاخرون ويتجاوب			
17	هل يكون احيانا شارد الذهن أو يتجول دون هدف			

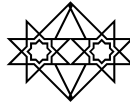
لا	قليلا	نعم	السؤال	
			هل يتفحص تعابير وجهك ان تمت مواجهته بشيء عمله أو نقله	18
			هل يحب الارتباط بلعبة معينة او شيء آخر بشكل ملفت	19
			هل يميل الى النظر الى شيء في الغرفة أو لعبة لفترة طويلة	20
			هل يظهر نوبات غضب	21
			هل يمانع تغيير وضع العابه أو الاغراض في غرفته	22
			هل يميل الى ترداد ما تقولينه له بشكل ملفت	23
			هل يظهر عليه علامات المتعة في اللعب مع اخوته أو الآخرين	24
			هل يستعمل كلمات مفهومة ولها معنى	25



الباب الثالث

البرامج العلاجية والتربوية

لأطفال التوحد



العلاج بالأدوية

وهو أسلوب قديم ما يزال يعمل به لغاية الآن، ويهدف إلى التقليل من الأعراض المرافقة للتوحد، وليس الشفاء منهم كما تختلف فاعلية الدواء نفسه وتأثيره في الأفراد التوحدين لتعدد أسباب التوحد ولاحتمالية وجود خلل بيوكيميائي في الدماغ.

ويستخدم الأفراد التوحديون الأدوية نفسها التي تستخدمها الفئات الأخرى، وأشهرها : أدوية الفصام؛ والاكتئاب؛ والتشنج؛ والقلق؛ ومهدئات الأعصاب؛ ومضادات السبروتونين؛ ومضادات الأفيون . وتشترك هذه الأدوية في الكثير من آثارها الجانبية الواحدة التي من أبرزها : إمكانية الإدمان عليها؛ والنعاس، والغثيان؛ وعدم انتظام دقات القلب؛ وانقباض الأمعاء؛ والارتعاش؛ ونقص كريات الدم البيضاء؛ وبعض المشاكل في وظيفة الكبد؛ وفقدان الشهية.

استخدام العلاج الدوائي للتوحدين

من المعروف أنه ليس هناك علاج يشفي من التوحد !! فالتوحد يستمر مدى الحياة ولكن هناك بعض العقاقير التي تستخدم لتقليل بعض الأعراض الغير مرغوب فيها والشفاء الجزئي والتحسين عادة ما يحدث في حالة شخص يبدأ بالتحدث أو يتسم أو يبين عاطفة أو يتعلم ... الخ، وبرغم هذا فعادة ما يستمر التوحد طيلة الحياة، وكما ذكرت سابقا فان التدخل المبكر وبرامج تعديل السلوك وبرامج التربية الخاصة تساعد على تحسين المصاب بالتوحد بالإضافة إلى الحماية الغذائية الخالية من الكازيين والجلوتين وبعض الملاحق الغذائية.

إن استخدام أي نوع من العلاج للناس التوحدين مسألة مثيرة للجدل !!! فهناك فريق يرى أن إعطاء أي نوع من الدواء للناس العاجزين عن التعبير عن موافقتهم لا مبرر له على الإطلاق وأما الفريق الآخر فإنه وجد ثقة ملحوظة في أن أي دواء يقدمه الطبيب يجب أن يكون نافعاً. وكالمعتاد توجد الحقيقية في مكان ما بين هذين الرأيين، ولكن من الصعب تقديم إجابات قاطعة عن أدوية معينة على كل حال، هناك مبادئ معينة يجب وضعها في الاعتبار قبل استعمال الأدوية

القوية. ويشمل هذا التقرير دراسة موجزة لمجموعات الأدوية الرئيسة التي يستخدمها الأشخاص التوحيديون، ولكن قبل النظر في فائدة أدوية معينة فإن هناك جوانب معينة لها ذات أهمية لاختيار المادة الكيميائية

الآثار الجانبية

ينبغي أن نتوقع دائماً بعض أنواع الآثار الجانبية. ويكاد يصح القول بأنه لا يوجد دواء بدون آثار جانبية. وللأسف فإن هذا صحيح خاصة عندما ندرس الأدوية التي تؤثر على المخ خاصة وأن مفعولها غير محدد عادة. ويجب أن يكون الطبيب الذي يصف الدواء ومن يقومون بالرعاية منبهين لأي تغيير قد يحدث في السلوك أو الأداء. ونظراً لأن المرضى الذين يتعاطون الدواء غير قادرين على التعبير عن هذه الآثار فإن من مسئوليتنا الحذر الدائم من هذه الأدوية

الاختلاف في الاستجابة للعلاج

قد يكون التوحد نتيجة لأسباب مختلفة وأن تنوع الشذوذ البيولوجي قد يتسبب في الشذوذ النفسي والسلوكي. لذا يستحيل الجزم بالدواء الذي سيكون أو لا يكون فعالاً لشخص معين. وحتى الآن لا يوجد دواء اتضح أنه مفيد لكل الناس الذين يعانون من التوحد توجد الكثير من الأدلة الحديثة على وجود أنواع من الشذوذ في العمليات الكيميائية - الحيوية للناس المصابين بالتوحد. ويتوقع فقط أن تكون استجابتهم للأدوية مختلفة من تلك الملاحظة لدى الناس العاديين. ولا تعني حقيقة أن الدواء يؤثر بطريقة معينة لدى الناس العاديين بالضرورة أن نفس الأثر سيحدث لدى الناس الذين يعانون من التوحد.

تحديد الجرعات والتقيد بالتعليمات

هناك مشكلة أخرى هي أن الآثار تختلف كثيراً تبعاً للجرعات المستخدمة. فالجرعة الأكبر قد لا تكون لها بالضرورة فاعلية أكبر. فقد تكون نتائج الجرعة الأكبر عكس تلك الملاحظة عند تناول جرعة أقل. وأن دراسة آثار الكحول ستساعد

في توضيح الأمر. إن الغالبية العظمى من الأدوية خاصة تلك المستخدمة في المنازل لا تستعمل طبقاً لرغبات وتعليمات الأطباء. وتتغير الآثار بصورة كبيرة جداً إذا لم يتم تناول الأدوية في مواعيدها الصحيحة أو إذا تم تجاهل التعليمات الخاصة بتناولها مع الطعام أو بدونه. وإن أحدى الممارسات الخطرة جداً تتمثل في تناول الحبوب والكبسولات دون ماء (أو أي سائل آخر) لتسهيل انسيابها إلى المعدة حيث تتحلل وتفرغ محتوياتها

المريئ الموصول من الحلقوم إلى المعدة ليس مثل أنبوب صلب. إذا يجب تناول 100 ملل (نصف كبسولة) من السوائل مع تناول أي دواء لأنه قد يبقى في المريئ ويسبب تلفاً لبطانته.

إن مهمة الطبيب صعبة جداً في تحديد الدواء المناسب لحاجة الفرد المصاب بالتوحد وقد يحتاج إلى تجريب أنواع من الأدوية والجرعات قبل تحديد الرجيم الفاعل والمناسب. وعلى من يقومون بالرعاية أن يقدموا ملاحظاته للطبيب إذا كانت له أية فرصة في المساعدة. وإذا لم يكن للدواء أي مفعول فينبغي عدم استعماله ولكن إذا أمكن تحسين حياة الشخص المصاب بالتوحد أو تسهيلها باستخدام الدواء فيجب ألا يرفضون تلك المساعدة بسبب هاجس غير مبرر من جانب من يقوم برعاية المريض يعتقد فيه أن كل الأدوية مؤذية.

تستخدم الأدوية الفاعلة للسيطرة على بعض المشكلات المصاحبة للتوحد كالصرع مثلاً، ولكن يجب التسليم بأن محاولات تحقيق تحسن سريع في علاج التوحد قد ظهر فشلها. وزعم البعض تحقيق شيء من النجاح في معالجة مجموعات معينة من الأعراض حيث تم تطوير أدوية مضادة لها واستعمالها. يوجد عدد ضخم من الأدوية المستعملة - وإن استعمال الكثير منها يكشف عن عدم حصولنا على أكثر من نتائج تجميلية في معظم الحالات.

الأدوية

يتكون المخ من بلايين الخلايا neurones (نيرونات) التي تتصل مع بعضها بواسطة الفروع، وهذه الخلايا في الحقيقة لا تلامس بعضها البعض، حيث توجد

فجوات دقيقة وتستخدم المواد الكيماوية في الاتصال بين هذه النيرونات حيث تنقل النبض بين الخلايا عبر هذه الفجوات. ويستخدم المخ عددا من المواد الكيماوية لهذا الغرض (الدوبامين والنورادرينالي ن والسيروتونين وقابا مثلاً) (Serotonin, and Gaba Dopamine, Noradrenaline) وعند هذه الفجوات تعزز الأغلبية العظمى من الأدوية المستخدمة في التوحد آثارها.

الأدوية التي تستعمل للنظام الدوبامينرجي (Dopaminergic)

إن الأدوية العصبية مثل الكلوريرومازين (Largactil) والثيرودازين (Melleril) هي أمثلة لعدد كبير من الأدوية التي تعمل على الأنظمة الدوبامينرجية (Dopaminergic). وقد طورت هذه الأدوية أولاً للعمل ضد الإضطرابات النفسية مثل الشيزوفرنيا وفي بعض الحالات أثبتت أنها مفيدة جداً ومساعدة للمرضى فهي تعمل بالإغلاق الجزئي بواسطة الدوبامين (Dopamine) وكذلك الحال بالنسبة للشيزوفرنيا حيث يستخدم مزيد من البث الدوبامينرجي، واستعمالها منطقي. ويصعب تبرير استخدامها في التوحد كما يصعب الحصول على فوائد لها. وقد يكون البث الدوبامينرجي في التوحد قد قلص في كل الحالات وأن استخدام الأدوية التي تقلصه أكثر غير منطقي. وقد تكون هناك حالات يمكن فيها تبرير استخدام هذه الأدوية. فمثلاً عند الاضطراب السلوكي قد تساعد هذه الأدوية في تهدئة الشخص، ولكن في التوحد لا تكون النتائج دائماً كافية لتبرير استخدامها.

توجد في تلك الأدوية مشكلات حقيقية تماماً تتعلق بآثارها الجانبية. وقد تكون ذات نوع هرمي زائد حيث يوجد فيها أنواع من الحركات التي لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها مثل عدم القدرة على السكون أو الرجفة وفي بعض الحالات الإغماء التصلبي. وتتم السيطرة على هذه الآثار الجانبية عادة باستعمال أدوية أخرى مثل الأورفينادارين

وهناك خطر كبير جداً من استعمال هذه الأدوية العصبية لفترات طويلة من الزمن. قد تظهر آثار مثل ضعف الحركة الاختيارية وقد تكون هذه الأعراض دائمة. وأن الآلية الدقيقة لهذه الآثار الجانبية غير معروفة ولكن الحركات التي لا

يمكن التحكم فيها خاصة بروز اللسان وحركات الجسم المميزة يمكن التحكم فيها فقط باستعمال جرعات زائدة من الدواء. وعند معالجة الناس بهذه الأدوية لبعض الوقت فإن ظهور هذه الأعراض يعوق محاولات تقليل الجرعات من الصعب تبرير الاستمرار في استعمال تلك الأدوية بسبب ما تحتويه من آثار جانبية خطيرة، وإن عدم قدرتها على علاج التوحد يحول دون استخدامها إلا لفترات زمنية قصيرة وعند الضرورة القصوى.

توجد مجموعة من أدوية الشد العصبي الشاذة والهامة جداً والتي يكون استعمالها أكثر تبريراً. وسيختلف أثر استخدام الأدوية مثل هالوبريدول (Haldol, Serenace) سيريناس، هالدول) وسلبريد (Dolmatil) مع تركيز الاستعمال. وهي تثير البث الدوبامينرجي (Dopaminergic) عند إعطائها بجرعات منخفضة ولكنها تزيد عند إعطائها بجرعات عالية. وقد كتب كتاب معينون عن النتائج المفيدة لهذه الجرعات المنخفضة ولكن يجب تحديد الجرعة المناسبة لكل مادة معينة.

الأدوية الفاعلة مع النظام السيروتونرجي (serotonergic)

أوضح عدد من العاملين أن مستويات السيروتونين (Serotonin) المعروف أيضاً بـ 5- هيدروكسي - تريبتامين أو (HT-5) في الدم أعلى عند نسبة 35% - 40% من الناس المصابين بالتوحد من الناس العاديين. ويقود هذا إلى الاقتراح القائل بأن دواء التخسيس فينفلورامين (Ponderax) المعروف بأنه يقلل هذا المستويات قد يكون مفيداً للناس المصابين بالتوحد وقد كانت النتائج المبكرة واعدة جداً ولكن التجارب اللاحقة قد أدت في مجملها إلى نتائج مخيبة للآمال. وقد يكون الفينفلورامين (Fenfluramine) مفيداً لنسبة من الناس المصابين بالتوحد عندما تفرز نهايات الأعصاب السيروتونين (serotonin) فإن كثيراً منه يعاد امتصاصه واستخدامه مرة أخرى. وأن العديد من الأدوية المضادة للكآبة تعمل على منع أو إزالة إعادة هذا الامتصاص وينتج عن ذلك بقاء سيروتونين أكثر في الفجوة لتنبه طرف العصب المستقبل. وهذه الأدوية تعمل بفعالية لزيادة السريان في هذه

الأجهزة. وفي ذات الوقت قد يحدث تخفيض لكمية السيروتونين التي تفرزها نهايات الأعصاب، وقد ينتج عن هذا انخفاض في حجم السريان (الانتقال) بين الأطراف العصبية. لذا يكون من الصعب التكهن ما إذا كان استخدام الأدوية المضادة للكآبة سيكون مفيدا أم لا أم أنه سيزيد حالة التوحد إلى مستوى أسوأ. ومع أن الأدوية التي تعطي لبعض الناس مثل كلوميبرامين (Anafranil) أو الفلوكسيتين (Prozac) مفيدة في تقليل الكآبة والعدوانية ولكنها قد تفاقم الموقف وواضح أن آثار تلك الأدوية قد تستغرق عدة أسابيع قبل أن تتضح.

الأدوية التي تؤثر على نظام قابا (GABA)

إن الأدوية مثل الفاليوم تعمل على تنبيه نظام قابا (GABA) وتستخدم عادة لتقليل مستويات القلق. وبناءً عليه فإنها تبدو من النظرة الأولى مناسبة للأشخاص الذين لديهم ذاتية التركيز وإن إحدى تأثيرات تلك الأدوية هي تثبيط الانتقال في الأنظمة دوبيامينية الفعل وعلى كل حال يمكن تقليل هذا الانتقال. إن دراسة النتائج باستخدام تلك الأدوية سوف تبدو لتأييد النظرة بأنها ذات فائدة قليلة. وهذا ليس للقول بأنه ليست بها فائدة في مواقف طارئة محددة غير أنها تبدو لتحسين وتلطيف ذاتية الذاكرة بأية حال.

الأدوية التي تؤثر على النظام النوراديرينرجي (Noradrenergic)

تستخدم مجموعة الأدوية المعروفة مجتمعة باسم مانعات بيتا (Beta Blockers) عادة لخفض ضغط الدم ولكن قد تكون لها تأثيرات على المخ أيضا. وهي تستخدم عادة لتقليل آثار التوتر واستخدمت كذلك في الولايات المتحدة خاصة لمساعدة الناس الذين يعانون من التوحد. ومع أنه من الصعب العثور على دليل لحالة تحسن واضحة فإنه يمكن النظر في استخدامها. وقد تكون هناك أسباب وجيهة لعدم تشجيع استخدام تلك الأدوية. استخدمت أدوية مثل أمفيتامين (Amphetamines) التي تحفز هذا النظام للسيطرة على النشاط المفرط وعدم القدرة على التركيز والانتباه. وإن أي تحسن في

هذه الأعراض المقصودة ضئيل لأبعد الحدود ومصحوب بزيادة في السلوك المتكرر الذي لا يتغير. ولا تجد إلا القليل من المؤيدين لها في أوساط الأطباء البريطانيين

الأدوية التي تزيل نظام الأفيون المخدر Opioid System

تنص نظرية الأفيون الزائد أنه يوجد لسبب أو آخر ارتفاع في مستويات مركبات أوبيويد (" Endorphins ") في الجسم لدى الأشخاص المصابين بالتوحد وقد يكون استخدام دواء مضاد للاندورفين (Endorphin) مثل النالتريكسون على أساس نظري مناسباً. وإن نالتريكسون (Naltrexone) هو واحد من تلك الأدوية المشار إليها سابقاً والتي تعتبر فيها الجرعة خطيرة وأن الجرعات التي استخدمت في التجارب السابقة كانت كبيرة جداً حيث لم تلاحظ أية فوائد منها. وقد كشفت أحدث التجارب التي تستخدم جرعات ضئيلة جداً عن نتائج مفيدة فيما يتعلق بالقدرة على الاندماج الاجتماعي وتقليل سلوك تجريح الذات لدى نسبة من الناس المصابين بالتوحد. ولا تزال التجارب الإكلينيكية مستمرة بانتظار النتائج. وكما هو الحال بالنسبة لبعض الأدوية فقد استخدمت مركبات الليثيوم (Lithium) أولاً في السيطرة على بعض أعراض الشيزوفرينيا (انفصام الشخصية) وجرى اختبارها لاحقاً للناس المصابين بالتوحد. ويبدو أن التقارير تشير إلى فائدة محتملة في بعض الحالات التي يعاني فيها المريض من العدوانية خاصة إذا كانت مصحوبة بسلوك غطي أو مفرط في النشاط. إضافة لذلك فقد تكون لليثيوم (Lithium) فائدة في تلطيف تأرجح الحالة النفسية أو التذبذب المتكرر في السلوك الذي يعاني منه بعض الناس المصابين بالتوحد. يتفاوت الناس بدرجة كبيرة في استجابتهم لليثيوم، وبصفة خاصة فإن الجرعات المطلوبة قد تتفاوت بصورة كبيرة حيث أنه من الضروري للطبيب أن يراقب كمية الليثيوم في الدم للتأكد من الكميات المثالية لكل مريض.

كاربامازيبين

إن كاربامازيبين (" Tegretol ") له آثار عديدة ولكنه يوصف عادة للسيطرة على حالة الصرع. كما يبدو أنه يقلل من تذبذب الحالة النفسية المشار إليه أعلاه

وينبغي دراسته حيث توجد مشكلة. توجد العديد من الأدوية التي أعطيت للناس المصابين بالتوحد ولكن في الوقت الذي حدث فيه بعض النجاحات في معالجة أنواع معينة من السلوك فإنهم لا يزالون غير قادرين على إنتاج دواء يحسن من الأعراض الرئيسة للتوحد بصورة ملحوظة وخلال فترة زمنية. وفي نفس الوقت توجد العديد من المنتجات التي ينبغي دراستها لحالات معينة ولكن نظرا للتنوع الضخم في استجابات الأفراد والاختلافات في الجرعات المطلوبة يتعذر التكهّن بالنتائج. ويتعين إيجاد علاقة ما بين الطبيب والشخص التوحيدي مما يتطلب ضرورة الاتصال الحقيقي بينهما حتى يكون الدواء ناجحا في استخدامه مع الشخص التوحيدي. وعلى المرضى ومن يقومون برعايتهم أن يكونوا مدركين لفوائد العلاج (الدواء) وأضراره المحتملة وأن يتشاوروا مع الطبيب كلما توفر ذلك

العلاج الغذائي

ينطلق هذا الأسلوب من عدم قدرة بعض الأفراد التوحيدين على الهضم الكامل لبروتين الجلوتين الموجود في القمح، وبروتين الكازين الموجود في الحليب مما يؤدي إلى ظهور الببتايد غير المهضوم جيداً، وبذلك يصبح له تأثير تخديري يشبه تأثير الأفيون والمورفين . لذلك يتم تزويد الطفل ب:

أ. مادة السيرنيد (Seren Aid (TM) وهو إنزيم متعدد صمم لمساعدة الجسم على زيادة هضم الببتيدات (المهضومة جزئياً) الناتجة عن بروتين الكازين الموجود في الحليب و الجلوتين الموجود في القمح، إذ يقوم بتكسير الببتيد إلى جزيئات أصغر، ومن ثم يقلل من امتصاص الكازومورفين والجلوتومورفين الناتجين عن الببتيدات المهضومة جزئياً .وبذلك يصبح هضم الطعام أسهل مما يزيد من الاستجابة الحسية، وينمي الوظائف المعرفية، ويعزز السلوك المعرفي عند الطفل.

ب. الطعام الخالي من بروتين الجلوتين والكازين، وهذا الأمر في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى قرار جريء وشجاع من جانب جميع الأشخاص المسؤولين عن حياة الطفل.

وعلى الرغم من عدم وجود أية دراسات بحثية مدونة تشير إلى إمكانية حدوث تأثيرات سلبية في حالة تطبيق البرنامج بشكل علمي ومدرّس، وبإشراف اختصاصيين مهرة، إلا أنه لا توجد في الوقت نفسه دراسات تتمتع بالضبط والدقة تشير إلى فائدة جميع الأفراد التوحديين من هذا الأسلوب.

الحمية الغذائية تساعد الأطفال التوحديين

الحمية الغذائية الخالية من الكازيين والجلوتين (Casein and Gluten Free Diet) التي ثبتت فعاليتها في مساعدة الأطفال التوحديين، ذلك لأن عدم تحمل التوحديين لمادة الكازيين (الجبين) والجلوتين (الغروين) هي إحدى النظريات التي تفسر التوحد وهي مرتبطة بنظريات أخرى ذات علاقة مؤثرة، خاصة ما حدث في اضطرابات داخل المعدة والدماغ لدى المصاب التوحدي وهذه النظريات هي: نظرية زيادة الأفيون المخدر لدى التوحديين (Opioid Excess) ونظرية منفضية أو تسريب الأمعاء (Intestinal Permeability) ونظرية عملية الكبرته (Free Sulphate) وهناك العديد من الدراسات التي توضح ترابط هذه النظريات بالتوحد، فنظرية زيادة الأفيون المخدر لدى التوحديين هي إحدى النظريات المعقدة التي وضعها البروفيسور (جاك بانكسيب) من جامعة جرين بولينج عام 1979م. الكازيين (الجبين) (Casein: هو البروتين الأساسي في الحليب ويوجد أيضاً في مشتقات الحليب. أما الجلوتين (الغروين) (Gluten) هو مادة لزجة تتكون أثناء العجن للحنطة ويوجد في الشوفان والشعير والجاودار. (Bran & Barley, Oat, Wheat) وهو البروتين الموجود في الحنطة ومشتقاتها. بالنسبة لأطفال التوحد فإنهم لا يقومون بهضم هذه البروتينات في عملية الاستقلابات، ولذلك تكون هذه البروتينات مضرّة لهم. وقد أضاف إليها كل من الدكتور ريتشيلد عام 1981م، والدكتور بول شاتوك، مدير وحدة أبحاث التوحد بجامعة سندرلاند في بريطانيا عام 1991م. وتنص هذه النظرية أن لدى التوحديين زيادة في مادة الأفيون المخدر (Excess opioid) (دون استخدام الأفيون !!!) ولإيضاح ذلك هناك ثلاث مستقبلات تتعامل مع المخدر في المخ وهي (دلتا و ميو وكابا) فإذا زاد المخدر عند الطفل تنتج عنه تصرفات لا تحمد عقباها، وسنتطرق لذلك لاحقاً في سياق هذه الكتاب. إذاً

كيف تحدث زيادة الأفيون لدى التوحدين؟ وما هو مصدرها؟ وكيف يزيد المخدر عندما يصل إلى المخ؟ وما هي نتائج هذه الزيادة؟ ولقد تمت دراسات خاصة بتحليل عينات بول 5000 حالة توحد ووجد أن هناك مركبات مورفينية أو شبه أفيونية مخدرة لدى أكثر من 80% من التوحدين، إذا ما هي هذه المواد المخدرة؟ هذه المواد هي:- كازو مورفين (Casomorphin) و جليوتومورفين (Glutemorphin) ومصدر هذه المواد الشبه أفيونية هو الحليب حيث يكون بيتايد يسمى الكازومورفين والحنطة والشعير والشوفان والجاودار Wheat / Oat / Bran / Barley حيث تكون بيتايد يسمى الجليوتومورفين. وهذه المواد عبارة عن بروتينات نتجت عن عدم هضم الكازين والجلوتين بطريقة فعالة لدى التوحدين وبالتالي أصبحت ذات مفعول أفيوني مخدر وقد وجدت في قراءات تحاليل بول المصابين بالتوحد. كما وجدت هذه المركبات في الدم، ويفسر ذلك نظرية منفذية أو تسريب الأمعاء (Intestinal Permeability) أو اصابة التوحدين بمتلازمة الأمعاء المسربة Leaky Gut Syndrom وهو ما أجمع عليه الباحثون والعلماء، العالم الين فريدمان (Alen Fredman) من شركة جونسون أند جونسون أكد وجود هذه المواد الشبه مورفينية أو ذات الطابع الأفيوني وأضاف بأن هناك مركبين آخرين وجدا في قراءات تحاليل بول الأطفال التوحدين هما: ديلتورفين.(موجودة فقط تحت الجلد في ضفدع السهم السام في أمريكا الجنوبية). و الديرمورفين. (موجودة فقط تحت الجلد في ضفدع السهم السام في أمريكا الجنوبية). هذه المادتين المورفينية تفوق قوتها الهيروين والمورفين المخدر ب 2000 مرة !!!، وحيث أن جميع هذه المواد الشبه مورفينية قد تسربت عن طريق الأمعاء المرشحة Leaky Gut والتي ربما كان السبب وراء تسريب هذه الأمعاء هو قصور أو عجز في الانزيمات والذي بدوره يضعف الطبقة المبطنية لجدار المعدة، وهذا يفسر نظرية عملية الكبرته لدى التوحدين) فتدخل هذه المركبات الأفيونية المخدرة إلى المخ وتخرق الحاجز الدموي الدماغي وتتعامل مع مستقبلات المخ فيصبح المصاب التوحدي مشبع بالأفيون المخدر، وهذا أيضاً يفسر نظرية زيادة الأفيون لدى التوحدين حيث أن هذه المواد المخدرة إما أنها تسبب التوحد أو تزيد من أعراض التوحد. وعند مقارنة

هذا الوضع مع من يتعاطى المخدرات أو يعتاد على التعاطي أي يصبح مدمناً نلاحظ عليه المظاهر التالية:-

- عدم الشعور بالألم.
- فرط الحركة أو الخمول.
- السلوكيات الشاذة.
- عدم التركيز أو شرود الذهن.
- الكلام بطريقة غير سوية مع اختلال في نبرات الصوت.
- الروتين النمطي والسلوك المتكرر.
- الانطواء على الذات.
- اضطراب في عادات النوم.

ومعظم هذه المظاهر تنطبق على المصابين بالتوحد وتكون واضحة في التوحد التقليدي Classic Autism والتوحيدين من ذوي الكفاءة الأقل (Low Functioning)، ولذلك يجب على أسرة المصاب التوحيدي أو من يقومون برعايته مراعاة التغذية التي تعتمد على المواد المشار إليها وتجنب إطعام أبنائهم وبناتهم التوحيدين هذه البروتينات الضارة. وربما يتساءل الأهل وتتساءل الأسرة بأن هناك توحيدين يأكلون هذه البروتينات ولم تسبب لهم أي ردود أفعال Reactions أو لم تزد في أعراض التوحد لديهم؟ أن الرد على ذلك يشير بأن هناك توحيدين لم يؤثر عليهم (الببتايد الأفيوني) "Opioid Peptides" لأن تسريب الأمعاء (Intestinal Permeability) لهذه المواد لديهم قليل جداً وبالتالي الكمية التي توجد في الدم من الكازومورفين والجلوتيومورفين لا أهمية لها ولا تأثير لها على المخ. إذاً كيف تتم الرعاية الأسرية؟ وما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها؟ وهل هناك فترة حرجة للطفل التوحيدي؟ وما هي مظاهر التحسن لدى الطفل التوحيدي؟ أن ما يجب عمله من قبل الأسرة هو: تحليل بول للمصاب التوحد وهو اختياري Urine Peptides Test، وإعلام من يتعامل مع التوحيدي سواءً في المنزل أو المدرسة أو كل فرد يتعامل مع التوحيدي، بأنه سيخضع لحمية خالية من الكازين والجلوتين مع

الشرح ليهم عما ذكر أنفاً. و مراقبة وتدوين سلوكيات المصاب التوحدي قبل بدء الحمية وأثناء الحمية.

وقد يتساءل الآباء والأمهات هل يتم البدء بهذه الطريقة مرة واحدة أو على مراحل؟ الواقع إن البداية تتم عن طريق إزالة الحليب ومشتقاته من الطعام الخاص بالطفل التوحدي فإذا لوحظ التحسن لا تقدم الحنطة والشعير والشوفان والجاودار في غذاء الطفل التوحدي. ويتساءل بعض أولياء الأمور هل سيستمر ابني مدى حياته على الحمية؟ نعم ويجب أن تكون الحمية صارمة جداً دون تهاون بدواعي الشفقة والرحمة على الطفل حيث ستكون هناك آثاراً سلبية في حالة الإخلال بالحمية وتعتبر المرحلة الحرجة من 14 إلى 21 يوماً من بداية الحمية، حيث تشير تجارب أولياء الأمور إلى حدوث نكسة لأبنائهم التوحدين تتلخص بما يلي:-

- التعلق والعاطفة المتزايدة.

- البكاء والأذنين.

- الخمول والكسل.

- ازدياد مرات التبول والتبرز.

- الألم والتألم

ويعزي الباحثون حدوث هذه النكسة إلى انقطاع مادة البيبتايد الأفيوني (Opioid Peptides) عن الجسم، وتعتبر هذه العلامات ايجابية للغاية، ولذلك يجب الاستمرار في الحمية. ولإيضاح ذلك فإن الكازيين يمكن إزالته من الجسم خلال أسبوعين، بينما إزالة الجلوتين تحتاج فترة تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة أشهر قبل أن يتم التخلص منها نهائياً في الجسم، وعوداً إلى النكسة نجد أنها علامة جيدة، وحيثما تم ذكر ذلك سابقاً فإن إبعاد هذه المواد المخدرة، تعتبر بمثابة العلاج لإنسان (مدمن) ذلك إن التوحدي عندما يكون قريباً جداً من والديه أو من يقومون برعايته للبحث عن الكازيين والجلوتين اللذين تم إبعادهما عنه لتحسين حالته، فإنه في حالة الإخلال أيضاً بالحمية، ستكون هناك ردود أفعال عكسية

مرحلية تنتهي ما بين 12 - 36 ساعة، حسب الكمية التي تناولها الطفل من الجلوتين أو الكازيين إذا تم التعرف على مصدرها وضبط الحمية من جديد، وتتلخص ردود الأفعال في

- النشاط المفرط
- السلوك العدواني.
- سلوك الهلوسة.
- أحياناً الطفح الجلدي.

تربية الأطفال التوحديين ومشكلات التواصل المشابهة

طور الدكتور " إريك شوبلر " برنامج علاج وتربية الأطفال التوحديين ومشكلات التواصل المشابهة (تيتش) في عام 1972. وقد كان أول برنامج تربوي مختص بتعليم الأشخاص التوحديين، يقوم برنامج تيتش على أسس تأخذ بعين الاعتبار صفات التوحد الاساسية وطرق تعليم الأشخاص التوحديين التي ثبتت فعاليتها في دراسات علمية موثقة. وتعتبر أهم ركيزة للبرنامج هي تعليم الاشخاص التوحديين من خلال نقاط قوتهم والتي تكمن في إدراكهم البصري وتعويضهم عن نقاط الضعف لديهم والتي هي فهم اللغة والبيئة ويتم ذلك من خلال تنظيم البيئة واستخدام معينات بصرية

مثل: الصور والكلمات المكتوبة. بالإضافة الى تعليم التلاميذ يهتم برنامج تيتش بتدريب المختصين والاسر ممن يتعاملون مع أشخاص توحديين إذ تقام دورات تدريبية في جميع أنحاء العالم.

الهدف الأساسي من برنامج تيتش هو تجنب الأشخاص التوحديين الدخول أو البقاء في مصحات نفسية لمعالجة الأمراض العقلية ويتم ذلك من خلال تعليمهم مهارات لغوية إجتماعية وتحضيرهم للتعامل والتكيف والعمل في بيئة المنزل والمدرسة والمجتمع بشكل عام.

مبادئ وطرق التعليم

التعليم المنظم

تتسم البيئة التعليمية لبرامج تيتش بطابع مميز، فهي مليئة بمعينات ودلائل بصرية مثل الصور والكلمات المكتوبة والمواد بهدف تمكين الطالب من التكيف مع البيئة فالشخص الذي يعاني من التوحد قد يبدي السلوكيات التالية:

- القلق والتوتر في بيئات إعتيادية مما يعيق تعلم التلميذ وتقدمه.
 - التعلق بالروتين.
 - صعوبات في فهم بداية ونهاية الأنشطة وتسلسل الأحداث اليومية بشكل عام.
 - صعوبات في الانتقال من نشاط الى آخر أو من مكان لآخر.
 - صعوبات في فهم الكلام.
 - صعوبات في فهم الأماكن والمساحات في البيئة.
 - تفضيل التعلم من خلال الادراك البصري تعويضاً عن اللغة الملفوظة.
- فلهذا لمعالجة هذه الصعوبات التي يغلب ظهورها في بيئات تعليمية إعتيادية، طور الدكتور أريك شوبلر مفهوم التعليم المنظم (Structured teaching) للأشخاص التوحدين. بناءً على هذه الدراسة أصبح التعليم المنظم "دمغة" أو طابعاً مميزاً لبرنامج تيتش.

هنالك خمس ركائز للتعليم المنظم:

1. تكوين روتين محدد.
2. تنظيم المساحات.
3. الجداول اليومية.
4. تنظيم العمل.
5. التعليم البصري.

(1) تكوين روتين محدد:

يشمل الروتين الجوانب التالية:

1. تسلسل الأحداث خلال اليوم.
 2. تسلسل الأحداث خلال الأسبوع.
 3. كيفية البدء بنشاط ما.
 4. خطوات النشاط.
 5. الانتقال الى النشاط التالي.
 6. متى سيقع النشاط.
 7. مقدار المدة التي يستغرقها كل نشاط.
 8. ما يتعلق بالنشاط من مواد واشخاص وكيفية عرضه.
 9. الأمكنة التي ستمارس فيها النشاطات.
- بما أن الشخص التوحدي يجد صعوبة في فهم تسلسل الأحداث خلال اليوم بأكمله لهذا يقوم المسؤولون تعليم الأشخاص ذوي التوحد بتوضيح تسلسل الأحداث اليومية في المنزل أو المدرسة للتلاميذ من خلال إتباع روتين معين يشمل العناصر التي ذكرت أعلاه.

(2) تنظيم المساحات:

إن بعض الأشخاص التوحديين يجدون صعوبة في فهم المساحات في البيئة، ينبغي تنظيمها بشكل يفهمها التلميذ من خلال تحديد بداية ونهاية المسارات مثل: مساحة اللعب الحر ومساحة الانظار ومساحة الكرسي والمساحة الخاصة بالتلميذ يجب التنويه الى أنه ليس جميع التوحديين يواجهون مثل هذه الصعوبة إلا أن هنالك دلائل تشير الى وجود مثل هذه الصعوبات. فإن لاحظ المختصون الامور التالية فقد يدل هذا على إحتياج التلميذ لتنظيم المساحات في البيئة:

1. يكثر تجوله دون اتجاه معين فيبدو وكأنه في حالة ضياع.
2. يكثر تعثره على الأشياء والوقوع على الأرض.

3. يعاني تأخرا ذهنيا شديدا أو أنه لا زال صغير السن.
 4. يصعب عليه التنقل من مكان نشاط الى آخر فقد يتوقف في مكانه أو يتجه الى المكان الغير مطلوب.
 5. يستمر في غلق وفتح الأبواب بشكل متكرر.
- في التعامل مع هؤلاء التلاميذ يمكن تحديد مساحات العمل من خلال تنظيم الأثاث وأرفف الكتب أو العمل والملصقات والسجاجيد. وعلى سبيل المثال:
- يمكن وضع شريط لاصق على الأرض لتحديد مساحة أماكن الأنشطة كاللعب الحر أو الحلقة الصباحية وغير ذلك. وبالإضافة الى ذلك يمكن وضع سجادة بحجم مكان النشاط. أما في حالة عدم إستخدام نفس المساحة لأكثر من نشاط واحد، فيفضل إستخدام إشارة لتدل التلميذ على النشاط الذي سيقوم بأدائه. مثلا إذا كانت مساحة اللعب الحر ستُستخدم أيضا لنشاط الحلقة الصباحية فقد يضع المعلم سجاجيد صغيرة بحجم 50×50 سم ليجلس عليها التلميذ في حلقة الصباح ويخفيها في فترة اللعب الحر ليجعل من هذه السجاجيد إشارة تساعد التلميذ على التمييز بين نشاط الحلقة ونشاط اللعب الحر.
 - - يمكن وضع أرفف أو حواجز لتحديد باقي أماكن الأنشطة.
 - - يمكن مساعدة التلميذ على التمييز من نشاط وآخر من خلال ألوان عناصر الأثاث فمثلا: قد يتم إختيار كرسي وطاولة باللون الأزرق لإكمال الأنشطة الفردية (التي يقوم بها التلميذ مع معلمه) وباللون الأصفر لإكمال الأنشطة المستقلة (التي يقوم بها التلميذ بإنفراد دون مساعدة) وفي مثل هذه الأحوال ينبغي أن تعكس صور الجداول ألوان الأدوات المستخدمة لكل نشاط. وهكذا ستكون صور النشاط المستقل في الجدول عبارة عن كرسي وطاولة باللون الأصفر وصور النشاط الفردي في الجدول عبارة عن كرسي وطاولة باللون الأزرق.

(3) الجداول اليومية:

نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون التوحد في فهم الوقت وتسلسل الأحداث اليومية كان من الضروري استخدام جداول فردية تدلهم على تسلسل الأحداث اليومية. هذه الجداول تساعد على تنظيم وقتهم وفهم البيئة، ومعرفة الأحداث اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية. وحين يعرفون تسلسل الأحداث ويتمكنون من التنبؤ بما سيحدث خلال يومهم تنخفض درجة التوتر لديهم مما يساعدهم الى حد كبير على التعلم.

(4) تنظيم العمل:

يصعب على الأطفال التوحدين فهم بداية ونهاية كل نشاط. ولمعالجة مثل هذه الصعوبة، ينبغي العمل بشكل يوضح للتلميذ ما يلي:

- ما هو مطلوب ؟
- كم هي كمية العمل ؟
- كيف يعرف الطفل أن العمل إنتهى ؟
- ما هو النشاط الذي سيلي ؟

هنالك عدة طرق للقيام بمثل هذا التنظيم من بينها استخدام السلات. يكون التلميذ جالسا على الكرسي وأمامه طاولة العمل. يضع المعلم أرففا من السلات على يمين التلميذ وأرففا أخرى من السلات على يساره بالقرب من طاولة العمل، على أن يكون التلميذ قادرا على رؤية هذه السلات وما في داخلها. ويضع المعلم في كل سلة على يمين التلميذ نشاطا ينبغي على التلميذ أن يعمل عليه. وعند الإنتهاء من النشاط يطلب المعلم من التلميذ أن يضعه في إحدى السلات التي على يساره. مثل هذا الاجراء يدل التلميذ على كمية العمل التي ينبغي إنهاؤها من خلال رؤية الأنشطة الموضوعة في السلال التي على يمينه، ويدله ذلك على وقت الإنتهاء منها (فهو يضعها في السلال التي على يساره وعندما ينتهي منها). ويمكن كذلك تنظيم هذه العملية بشكل أدق من خلال وضع بطاقات بألوان مختلفة على الطاولة التي يستعد التلميذ لأن يعمل عليها. قد يتراوح عدد البطاقات من 2-5، بعدد سلات

العمل. يلي هذه البطاقات بطاقة تدل التلميذ على ما سيقوم به بعد أن ينتهي من الأنشطة. وفي معظم الأحيان يكون المطلوب من التلاميذ التوجه الى جداولهم. وبالتالي يضع المعلم صورة الجدول كدلالة للتلميذ على أن عليه التوجه الى جدولته بعد الإنتهاء من النشاط. فيما يلي خطوات توضح إحدى طرق تدريب التلميذ على إتباع روتين تنظيم العمل:

1. تلصق جميع البطاقات على طاولة العمل بالفلكرو، بما في ذلك البطاقات الملونة وصورة جدول التلميذ مثلا: نفترض ان عدد السلال عل يمين التلميذ هو ثلاث سلال. قد نضع كرتا بحجم 5×3 أو أكبر باللون الأصفر في أعلى طاولة العمل، يلي ذلك بطاقة باللون الأحمر، وتحتها أخرى باللون الأزرق ويلي ذلك بطاقة صورة الجدول.
2. نضع بطاقات مطابقة لها في سلات العمل على يمين التلميذ وبنفس الترتيب فنضع على طرف السلة الأولى وليس بداخلها كيسا بلاستيكا فيه بطاقة صفراء وفي السلة الثانية كيسا بلاستيكا فيه بطاقة حمراء، وفي السلة الثالثة والاخيرة كيسا بلاستيكا فيه بطاقة زرقاء.
3. يقوم التلميذ بأخذ أول بطاقة من طاولة العمل ويضعه في الكيس البلاستيكي الذي فيه البطاقة المطابقة للتي في السلة الأولى (أي البطاقة الصفراء في هذا المثال).
4. يقوم التلميذ بإنجاز النشاط الذي في السلة الأولى، وعند الإنتهاء منه، يضعه في السلة التي على يساره.
5. يقوم التلميذ بأخذ البطاقة الثانية من طاولة العمل ويضعها على البطاقة المطابقة لها (أي في السلة الثانية من سلال العمل).
6. يقوم بإنجاز النشاط الذي في السلة، وعند الإنتهاء منه يضعه في السلة التي على يساره. ويستمر في العمل هكذا الى أن يتم الأنشطة.
7. يأخذ بطاقة الجدول ويتجه به الى جدولته.

(5) التعليم البصري:

المقصود بالتعليمات البصرية إرشادات من خلال استخدام دلائل بصرية كالصور والكلمات المكتوبة. وعلى سبيل المثال، كي يتعلم التلميذ خطوات غسل اليدين، يقوم المعلم بعرض عدد من الصور، تدل كل صورة منها على خطوة من خطوات العمل. تلتصق هذه الصور فوق المغسلة التي يقوم التلميذ بإستخدامها.

برنامج التكامل الحسي

طورت هذا الأسلوب المعالجة الوظيفية أيرز (Ayers) عام 1972م، منطلقة من افتراض أن بعض الأفراد التوحديين وذوي الإعاقات الأخرى لديهم اضطراب في التكامل الحسي، نتيجة عدم قدرة الدماغ على دمج المثيرات البيئية القادمة من الحواس المختلفة، وفي العادة يحدث دمج المثيرات بصورة أوتوماتيكية، وبشكل غير واع، ودون جهد خلال الطفولة المبكرة

ويتمثل اضطراب التكامل الحسي عند الأطفال التوحديين في: صعوبة التناسق الحركي الدقيق، والسقوط على الوجه دون مد اليدين؛ والصراخ عند غسيل أو تمشيط الشعر، أو الاستحمام، وارتداء الملابس، إضافة إلى مشكلات في تناسق حركات العينين. ويهدف هذا الأسلوب إلى إيجاد ارتباطات جديدة بين الأعصاب عن طريق تطوير الأنظمة العصبية لتكون قادرة على تنظيم ومعالجة المثيرات البيئية القادمة من المدخلات الحسية المختلفة

الإجراءات النظرية لهذه المهارة: ويستخدم البرنامج عدداً م...ن طرق التدريب والتمرينات المختلفة التي تحقق المتعة للطفل عن طريق:

- تدريب اللمس: يتكون النظام اللمسي عند الإنسان من نظامين فرعيين: أحدها يعمل في الأحوال العادية، ويحدد مكان حدوث اللمس، وماهية الشيء الملموس. والآخر يعمل عند الإحساس بالخطر، ويؤدي لاستجابات الهروب، أو الخوف، أو القتال.

ويعاني بعض الأفراد التوحديين من اضطرابات في الجهاز الحسي، إذ تتم ترجمة الاتصال اللمسي العادي على أنه خطر، وبذلك يكون الجسم في حالة استنفار دائم مما قد يؤدي إلى الفرز والهروب عند الملامسة، وتجنب اتساخ اليدين بالصمغ، والرمل، والطين، وطلاء الأصابع، والدهان

- تدريب الحس الدهليزي: ويعني تطوير الجهاز الدهليزي المسؤول عن الإحساس بالجاذبية، والتوازن، والتناسق الحركي المتمثل في القدرة على استخدام جانبي الجسم عند ركوب الدراجة، والوثب، والقفز فوق الجبال، والعزف على البيانو.

- تدريب الحس المرتبط بموقع الجسم المتمثل في توقع الخطوة المقبلة، والوقت، والقوة، والسرعة الضرورية لأداء سلوك حركي معين مثل: الإشارات الضرورية للجلوس على الكرسي، وإدراك موقع القدم عند سحبها للخلف، أو مدى الارتفاع الضروري لليد لتمشيط الشعر.

ويشير بعض الباحثين إلى تحقيق الطفل المتعة من هذه الأنشطة، وإلى ظهور تحسن في سلوكه. وعلى الرغم من ذلك لا توجد في هذا المجال دراسات علمية موثقة استخدمت المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، إضافة إلى قصور في تعميم نتائج البرنامج، إذ لم يكن يظهر التحسن إلا في جلسات العلاج فقط، نظراً لقصر مدة البرنامج.

برامج التكامل السمعي

ينطلق هذا الأسلوب من أن بعض الأفراد التوحديين لديهم حساسية سمعية تجاه بعض المثيرات السمعية، وطور جاي بيرند (Guy Bernad) هذا الأسلوب في فرنسا خلال الستينات ثم انتقل هذا البرنامج إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991، ونشر آنذاك كتاب بعنوان "شفاء الطفل التوحدي بعد (10) ساعات من التدخل" وتتمحور خطوات البرنامج فيما يلي:

1. تحديد العتبة السمعية، ورسم تخطيط سمعي للطفل، وفي حالة ظهور حساسية سمعية عند الطفل فإنه يخضع الطفل للبرنامج العلاجي.
 2. البرنامج العلاجي، يتكون من عشر ساعات تدريبية موزعة على عشرين جلسة مدة كل جلسة نصف ساعة، لفترة تتراوح بين (10-20) يوماً، ويشتمل على الاستماع لموسيقى معدلة يزال منها الأصوات المسببة للحساسية باستخدام جهاز الكمبيوتر.
 3. استمرارية التخطيط السمعي أثناء كل جلسة وبعدها.
 4. إعادة البرنامج كاملاً بعد مضي (4-12) شهراً.
- ويشير بعض الباحثين إلى فائدة التدريب السمعي بزيادة الانتباه، والتقليل من عدم الاستقرار والخمول، وزيادة اللغة التعبيرية، وتحسن الاستيعاب.
- وواجه هذا الأسلوب انتقادات عديدة من أبرزها: طريقة قياس السمع من خلال استجابات الدماغ على التمييز في الحساسية السمعية بين الأفراد التوحديين وبين الأفراد غير التوحديين، إضافة إلى صعوبة إجراء القياس السمعي السلوكي؛ نظراً للسلوكيات المرافقة للتوحد، وطرح أسئلة عديدة حول جودة الأجهزة المستخدمة، ومدى شدة الأصوات التي تصدر عنها¹.

¹ Herin, L. Juan and Simpson, Richard L(1998), Intervention for children and youth with autism: Prudent choice in a world of exaggerated claims and empty promises. Part 1: Intervention and treatment option review, (cover story),Focus on Autism & other Developmental Disabilities, 13(4), 194-202.

العلاج بالموسيقى (Music Therapy)

يشير بعض الباحثين إلى مجموعة من الفوائد المترتبة على استخدام هذا الأسلوب من العلاج تتمثل في زيادة مدة الجلوس على الكرسي؛ وتسهيل اشتراك الطفل في مجموعات اللعب ومجموعات العمل؛ وتطوير الكلام؛ وتقليل السلوك النمطي وزيادة التواصل البصري باعتباره تعزيزاً للطفل عند قيامه بالسلوك المطلوب، بينما يشير باحثون آخرون إلى أن استخدام الموسيقى قد يؤدي إلى تعزيز الانسحاب، والعزلة الاجتماعية؛ ويشابه تأثيرها تأثير التنويم المغناطيسي؛ وتؤدي إلى زيادة الروتين؛ وضعف التواصل البصري مع الأشخاص. ويتطلب تطبيق هذا البرنامج وجود شخص مؤهل¹.

وللإيقاع الموسيقي اثرا في مساعدة الاطفال ذوي التوحد على التواصل واقامة العلاقات مع الاخرين وبالتالي اندماجهم وتقبلهم في المجتمع،ويمكن ان تساعد الموسيقى في تدريس الاطفال وتحسين علاقاتهم مع ذويهم وزيادة نسبة النمو والتعلم وهذا كله عن طريق خلق جو ايجابي يتم تجهيز الطفل ذي التوحد لتطوير وسائل التواصل لديه وتسهيل عملية انتقاله لمراحل تعليمية جديدة²

¹ Herin, L. Juan and Simpson, Richard L(1998), Intervention for children and youth with autism: Prudent choice in a world of exaggerated claims and empty promises. Part 1: Intervention and treatment option review, (cover story),Focus on Autism & other Developmental Disabilities, 13(4), 194-202.

² Brown,(1994). The National Autistic Society – Music Therapy www.nas.org.uk

نظام التواصل المعتمد على تبادل الصور

وطور هذا البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 في برنامج ديلور للتوحد عن طريق اختصاصي النطق (Bondy) وزوجته فروست (Frost) ثم انتقلت هذه الطريقة إلى بريطانيا عام 1997 بواسطة سو باكر (Sue Baker)، وتهدف إلى تعليم الأطفال التوحدين التواصل الفعال عن طريق وسائل بديلة ومعززة، تتضمن الإيماءات، والرموز المختصرة، والصور، بدرجات متفاوتة بين طفل وآخر، ويصحب ذلك استخدام النطق أو عدمه وتتميز هذه الطريقة بالاعتماد على مبادرة الطفل للتواصل، وليس كونها استجابة لمبادرة الآخرين.

نظام بكس PECS

طريقة pecs من طرق التواصل الغير لفظي مع الأطفال الصغار و الأطفال المعاقين الذين يجدون صعوبة في التواصل اللفظي مع الآخرين....
و سنعرض بشكل موجز هذه الطريقة لتوضيحها:

المرحلة الأولى: التبادل الحركي

الهدف في هذه المرحلة أن يلتقط الطفل الصورة المرغوب فيها ويتجه نحو المدرس ويضعها في يده.

نبدأ هذه المرحلة بتقييم المعززات بالنسبة للطفل لكي يكون المدرب على وعي مسبق بالأشياء المفضلة جداً لدى الطفل. ويتم بهذه الطريقة:

1. وضع العديد من المعززات (الأشياء المفضلة) أمام الطفل مثل (البطاطس- بونبون- بيبسي) ونلاحظ أي الأشياء يحاول الطفل الحصول عليها عدة مرات. ولكن نتأكد أن هذا الشيء مفضل عن غيره يجب أن يختاره الطفل ضمن الأشياء على الأقل ثلاث مرات متتالية مع تغيير مكانه ضمن المعززات الأخرى في كل مرة.
2. وضع جدول لترتيب الأشياء المفضلة عند الطفل من مأكولات... لعب... أدوات.
3. يتم تصنيف الأشياء في درجات مفضلة جداً / مفضلة فقط / غير مفضلة.

المرحلة الثانية: التلقائية في الأداء

الهدف هنا أن يتجه الطفل إلى اللوحة المعلم عليه الصور ويخلع الصورة منها ثم يتجه إلى المدرس ويسلمه الصورة في يده.

-نضع أحد الصور لشيء مفضل على لوحة يسهل انتزاع الصورة منها أو إعادتها لها. وذلك باستخدام (الفيلكرو) لاصق الأحذية.

-تعليم الطفل سحب الصورة، يتم في هذه المرحلة المساعدة البدنية لتعليم الطفل أن يذهب للوحة الصور ويسحب بيده الصورة ثم يعود ليعطيها للمدرس.

- لا يجوز أن نقول (لا) بل نعطي الطفل الصورة الصحيحة التي يرى أنها المرغوب فيها ثم إعطاءه الشيء المرغوب فيه فور إعطاءه الصورة.

- تعليم الطفل أن يذهب للمدرب لطلب الشيء: نقوم بتوسيع المسافة بين الطفل والمدرّب تدريجياً وفي هذه المرحلة تكون الصورة أو اللوحة المعلقة دائماً قريبة من الطفل والمدرّب يبتعد تدريجياً.

المرحلة الثالثة: التمييز بين الصور

الهدف هنا أن يدرّب الطفل على الذهاب إلى لوحة الصور ويختار صورة مناسبة من بين عدة صور ثم يذهب ويعطيها للمدرس.

- يجلس الطفل والمدرّب على منضدة يواجه كل منهما الآخر حيث يكون لديهم صور عديدة لأشياء مرغوب فيها وأشياء غير مرغوب فيها أو غير مفضلة.

-التمييز بين الشيء المرغوب والغير مرغوب فيه:

في هذه المرحلة نقوم بترتيب موقف معين بحيث نتأكد من حاجة الطفل لشيء معين الآن. ونقوم بتقديم لوحة الصور في صورتين أحدهما المرغوب فيها والأخرى لشيء غير مرغوب فيه فإذا قام الطفل باختيار الشيء المرغوب فيه فيجب على المدرس أن يمدحه بسرعة (ويعطيه الشيء المرغوب فيه)، أما إذا اختار الطفل الشيء الغير مرغوب فيه فيقوم المدرّب بإعطائه له دون أي تعليق لفظي.

المرحلة الرابعة: بناء الجملة

الهدف في هذه المرحلة أن يطلب الطفل أشياء موجودة وأشياء غير موجودة مستخدماً جملة متعددة الكلمات.

- ويذهب إلى الكتالوج ويختار الصورة المعبرة عن (أنا أريد...) ثم وضعها على شريط. واختار الصورة للشيء الذي يرغب فيه ويضعها بجانب هذه العبارة على الشريط، ثم يقوم الطفل بإعطاء الشريط إلى المدرس. وفي نهاية هذه المرحلة يكون لدى الطفل من 5- 20 صورة من خلال التواجد مع عدد كبير من المدرسين.

المرحلة الخامسة: الاستجابة للسؤال ماذا تريد؟

- ويحتاج الطفل بعض المساعدة من المدرب حتى يتعود على الذهاب للوحة التي بها الصور أو إحضار الكتالوج عندما يسمع السؤال. ماذا تريد؟
- يذهب المدرب مع الطفل إلى لوحة الصور ويشير بيده إلى كارت (أنا أريد) ويردد في نفس الوقت (ماذا تريد أنت؟) ويعطي الطفل الفرصة في نزع صورة عبارة (أنا أريد كرة) وإعطائها للمدرب.

المرحلة السادسة: التعميم والاستجابة التلقائية

في هذه المرحلة يستجيب الطفل للعديد من الأسئلة المختلفة مثل:

-ماذا تريد؟

-ماذا ترى؟

-ماذا تفعل؟..... وهكذا.

-نستخدم في هذه المرحلة كروت أو صور معبرة عن (أنا أريد - أنا أرى- أنا أفعل- أنا عندي...) ونضع مع ذلك صور أخرى.

طريقة لوفاس¹

وتسمى كذلك بالعلاج السلوكي أو علاج التحليل السلوكي وتعتبر واحدة من طرق العلاج السلوكي ولعلها تكون الأشهر حيث تقوم النظرية السلوكية على أساس انه يمكن التحكم بالسلوك بدراسة البيئة التي يحدث بها والتحكم في العوامل المثيرة لهذا السلوك حيث يعتبر كل سلوك عبارة عن استجابة لمؤثر ما.

ومبتكر هذه الطريقة هو «لوفاس» استاذ الطب النفسي في جامعة لوس انجليس وهذا العلاج السلوكي قائم على نظرية السلوكية والاستجابة الشرطية في علم النفس.

حيث تتم مكافأة الطفل على كل سلوك جيد أو على عدم ارتكاب السلوك السيئ كما يتم عقاب «كقول قف أو عدم اعطائه شيئاً يحبه» على كل سلوك سيئ وطريقة لوفاس هذه تعتمد على استخدام الاستجابة الشرطية بشكل مكثف حيث يجب ألا تقل مدة العلاج السلوكي عن 40 ساعة في الاسبوع ولمدة غير محددة. وفي التجارب التي قام بها لوفاس وزملاؤه كان سن الاطفال صغيرة وقد تم انتقاؤهم بطريقة معينة وغير عشوائية وقد كانت النتائج ايجابية حيث استمر العلاج المكثف لمدة سنتين. هذا وتقوم العديد من المراكز باتباع اجزاء من هذه الطريقة، وتعتبر

¹ دكتور «إيفار لوفاس» (Lvar Lovaas) هو دكتور نفسياني وبروفيسور في جامعة كاليفورنيا بـلوس انجليس «يوس.ال.أي» (Angeles:UCLA university of California at Los) ابتداءً «لوفاس» رحلته في تعليم الأشخاص التوحدين في أواخر عقد الخمسينات من القرن العشرين وقد بنى كل تجاربه على نظرية تعديل السلوك والتي تعتبر مدرسة من مدارس علم النفس المتعددة أن إعطاء تفسير واف وكامل لهذه النظرية يتطلب مئات من الصفحات وفي توضيح مبسط نقول أن الفلسفة الأساسية التي تنبثق منها هذه النظرية هي أن سلوك الإنسان مكتسب وظاهر وقابل للقياس كما يحكمه ضوابط تحدث قبل السلوك أو بعده وبناء على هذا فإن التحكم في الأحداث التي تثير السلوك أو نتائج السلوك وهو ما يحدث بعد أن يصدر الفرد سلوكاً ما كان من شأنه أن يؤثر على نسبة ظهور ذلك السلوك فالسلوك الذي يتبعه شيء أو حدث محبب إلى الشخص يزيد ظهوره بينما تنخفض نسبة السلوك الذي تتبعه عواقب سيئة و لهذه النظرية تطبيقات وإجراءات دقيقة جداً قام لوفاس بتطبيقها مع الأشخاص التوحدين.

هذه الطريقة مكلفة جداً نظراً لارتفاع تكاليف العلاج خاصة مع هذا العدد الكبير من الساعات المخصصة للعلاج. كما أن كثيراً من الأطفال الذين يؤدون بشكل جيد في العيادة قد لا يستخدمون المهارات التي اكتسبوها في حياتهم العادية.¹

التعاقد السلوكي:

أول من تحدث عن التعاقد السلوكي في عمليات العلاج وتعديل السلوك هو لوييد هوم (L. Homme)، وذلك في كتابه التعاقد السلوكي في غرفة الصف. والتعاقد السلوكي هو عبارة عن اتفاقية مكتوبة توضح العلاقة بين مهمة الفرد المتعالج، والمكافأة التي يحصل عليها بسبب ذلك. وباختصار هي اتفاق بين طرفين تحدد شروطه عن طريق التفاوض، ويتعهد الطرف الأول (المريض أو الطفل) بتأدية مجموعة متسلسلة من السلوكيات (Behavioural Chain) أو من الحلقات (Links) تؤدي إلى هدف محدد تحليل المهمة (Task analysis)، والطرف الآخر (المعالج) يتعهد بتعزيز هذا السلوك حسب الشروط المتفق عليها بين (المعلم والتلميذ)، (الأهل والطفل)، (المعالج والمريض).... ويتضمن العقد وصفاً كاملاً للسلوك الحالي، ووصفاً واضحاً ودقيقاً للسلوك المستهدف، وكيفية تقديم التعزيز، وطريقة إيصال المعزز، ومعايير التقييم (إتقان عملية التعلم أو التدريب في أداء السلوك المرغوب فيه)، والاتفاقية تتضمن كما ذكرنا خطوات متسلسلة ومتراكبة تؤدي إلى تحقيق السلوك المطلوب، مع مراعاة ظروف الفرد (الطفل) وقدراته، ويفيد هذا الإجراء في تنمية مهارة الإنجاز، والحصول على المكافأة عوضاً عن الطاعة، وتنمية الاستقلالية (إذا أنهيت كذا وكذا من الأعمال أو الخطوات فإنك ستنال كذا وكذا من معززات أو مكافآت...)، ويشترط في الاتفاقية أن تكون جدية، مع عدم التساهل في تنفيذها، وهي تصلح للراشدين ولكبّار الأطفال، وكذلك لحالات الإرشاد الزواجي، والإرشاد الأسري.²

¹ www.autismsupportnetwork.com/news

² <https://www.tbcb.net/health/28112/السلوكي-العلاج-لوفاس-في-التوحد-طريقة-لوفاس>

قياس عدد مرات حدوث السلوك غير السوي، وتحديد الخط القاعدي: (Baseline) أشرنا سابقاً في حديثنا عن العلاج الطبي - الدوائي لحالات التوحد إلى ضرورة قيام المعالج، أو الطبيب، أو الاختصاصي بتحديد الخط القاعدي لعدد مرات تكرار السلوك المضطرب لدى الطفل، وذلك لمعرفة شدة الأعراض قبل العلاج وبعده، ومن ثم الوقوف على مدى فاعلية العلاج، وعادة يتم تسجيل عدد مرات حدوث السلوك في فترة زمنية محددة، وبالاعتماد على الملاحظة (observation) المباشرة أو غير المباشرة التي تعتمد على التصوير والأفلام وغير ذلك. ولا بد من تدريب الملاحظين لهذا الغرض (observer training)، والتأكد من من ثبات الملاحظة، وتحديد مصادر الخطأ فيها، ويتم ملاحظة السلوك المستهدف وعدد مرات حدوثه، وشدته، ومدته (The duration)، والملاحظات حوله... ومن أجل أن تكون الملاحظة ثابتة وموضوعية يفضل اختيار أكثر من شخص واحد للملاحظة؛ وذلك من أجل تحقيق الصدق والثبات والموضوعية، ولأن الملاحظ إنسان، واحتمال الخطأ وارد لديه، ويجب مقارنة نتائج ملاحظة الشخص الأول بنتائج ملاحظة الشخص الثاني، ومعرفة نسبة الاتفاق بينهما.

وحسب العالم (Cooper, J. O) فإن نسبة الاتفاق بين الملاحظين إذا بلغت نحو (80%) فأكثر اعتبرت الدلالة قوية وثابتة، أما إذا كانت النسبة أقل فهذا يعني أن تعريف السلوك المستهدف لم يكن واضحاً لدى الملاحظين، أو أن الملاحظ بحاجة إلى تدريب، ومن ثم ضرورة إعادة النظر. ويجب عند الملاحظة الانتباه إلى ردود فعل الفرد (الطفل) المراد قياس سلوكه بوجود الملاحظين، ودرجة وضوح الملاحظة، ولأن السلوك كلما كان واضحاً لا يستطيع الفرد إخفاء هذا السلوك، كما يجب إخفاء هوية الشخص الملاحظ، والالتزام بملاحظة سلوك محدد دون غيره. وبعد ذلك يتم تحديد الخط القاعدي (Baseline) الذي يعطينا فكرة عن مدى فاعلية العلاج، ويتم عادة قياس السلوك المستهدف عدة مرات وخلال فترات زمنية محددة، والاستمرار في ذلك حتى يصبح السلوك (وكما يشير الخط البياني)

شبه ثابت نسبياً، ويكون السلوك قد استقر في تكراره، وعندها يقف المعالج عن محاولات العلاج،

ويكون هناك دليل على أن التغير الذي حدث في السلوك هو وظيفة المتغير المستقل (Variable Independent)

وليس أي متغير تابع، وطريقة العلاج هي المسؤولة عن التغير في السلوك (انظر الأشكال التالية للخط القاعدي).

مثلاً: تمّ ملاحظة سلوك عدم الاستجابة لنداء الآخرين بالاسم (باسم الطفل) محددة، وهو عدد مرات حدوثه بالدقيقة الواحدة، ويساوي عدد مرات تكرار السلوك مقسوماً على مدة الملاحظة. مثلاً إذا حدث السلوك عشر مرات في مدة (20) دقيقة، يكون معدل حدوث السلوك هو (20/10) ويساوي (0.5) نصف استجابة في الدقيقة الواحدة، ونسبة حدوث السلوك تساوي مدة السلوك مقسوماً على مدة الملاحظة مضروباً بمئة، ويمكن تقسيم الملاحظة إلى فترات؛ كل نصف ساعة مثلاً؛ أي يتم تحديد السلوك عند انتهاء الفاصل الزمني. وقد اتبع (لوفاس) طريقة مكافأة الطفل عن كل سلوك مرغوب فيه، أو على عدم ارتكاب السلوك السيئ، كما يتم عقاب الطفل (والحزم) وقول المعالج (قف، لا)، وعدم إعطاء الطفل أي شيء يحبه إذا قام بالسلوك السلبي. والعقاب يكون إيجابياً إذا تمّ تقديم شيء منفّر للطفل بعد قيامه بالسلوك غير المرغوب فيه، أو يكون سلبياً إذا تم إزالة معزز إيجابي أو حرمان من امتياز ما، مع ملاحظة أن الدراسات حول العقوبة تؤكد أن العقوبة تؤدي إلى كف الاستجابة أو السلوك (Inhibition)، ولكن السلوك يعود ثانية بعد زوال العقوبة، كما أن العقوبة لا تؤدي إلى تغيير السلوك، وكان (لوفاس) يعتمد في علاجاته لحالات التوحد على عملية تشكيل السلوك والنمذجة، وتستغرق عملية العلاج نحو (40) ساعة أسبوعياً، ولمدة نحو سنتين وبطريقة مكثفة ومكلفة مادياً.

تشكيل السلوك في علاج حالات التوحد

يرى لوفاس أن طريقة تشكيل السلوك تعتمد على عملية الإشراف الإجرائي وعلى تجارب العالم سكر في استخدام الصندوق لتشكيل سلوك الحمام. وقد أشار سكر إلى أن الإشراف الإجرائي تؤثر فيه مجموعة عوامل هي: الدافعية لدى الفرد (Motivation) والتي هي طاقة أو حالة داخلية تدفع الفرد نحو القيام بسلوك ما للحصول على شيء ما، ثم عامل الانفعال والاستثارة الداخلية والشعور مثل حالة البكاء عند الخسارة، أو عند العقوبة، ثم عامل التعزيز الإيجابي والعقاب وحالة الكف والانطفاء للسلوك أو الاستجابة. وفي عملية تشكيل السلوك يتم تعزيز الاستجابات الصحيحة، التي تقترب تدريجياً من السلوك النهائي المستهدف، ويتم عدم التعزيز في حالة الانحراف عن السلوك، وعملية التشكيل تسهل عملية التعلم لدى الأطفال وخاصة المتخلفين عقلياً، والفصامين، ومضطربي السلوك. مثال: (السلوك المستهدف هو دمج الطفل مع الآخرين للعب معهم)، وفي هذه الحالة يتم وضع برنامج بسيط مكون من مجموعة من الاستجابات تقترب تدريجياً من السلوك النهائي المستهدف. ويتم تعزيز كل خطوة في البرنامج إلى أن يتمكن منها الطفل، ثم الانتقال إلى الخطوة التالية، بحيث يتم تعزيز الخطوة الأولى والثانية معاً، ثم الخطوة الأولى والثانية والثالثة معاً، وهكذا إلى أن يتم تعزيز كل خطوات البرنامج مرة واحدة وبعد الأداء الصحيح من الطفل، وبشكل يعتمد على أسلوب التقرب التدريجي (Successive approximation).

مثال على هذا البرنامج: (التشجيع على مهارة اللعب):

- نقل الطفل إلى مكان فيه عدد من اللاعبين الصغار (الأقران).
- النظر إلى اللاعبين من بعيد.
- النظر إلى اللاعبين من قريب.
- التحدث مع أي منهم.
- أخذ شيء من ألعابهم.
- اللعب معهم (السلوك المستهدف).

- تقديم المعزز (من المدرب ومن الأقران).

والتشكيل يبدأ بما لدى الطفل (أو الفرد) من سلوكيات يراد تطويرها، ويستمر التعزيز في كل إضافة إيجابية، والتي ستؤدي في النهاية إلى تكوين السلوك المطلوب المراد تشكيله، وتعتمد عملية التشكيل على التقريب المتتابع وذلك حسب طاقة الطفل ومهاراته ودافعيته، فلا يتم الانتقال إلى الخطوة التالية إلا بعد استيعاب الخطوة الأولى السابقة، وفي حالة التتابع التدريجي يلقي الطفل المعزز بعد الخطوة الأخيرة الصحيحة، وإذا كان الطفل يتعلم بسرعة تقل الخطوات التتابعية والعكس، وطفل التوحد يحتاج إلى وقت أطول وخطوات أكثر، كما تعتمد عملية التشكيل على التسلسل.

الجلسات التعليمية في برنامج لوفاس

تتراوح مدة الجلسة الواحدة بين 60-90 دقيقة للأطفال المبتدئين. تخلل الجلسة استراحة لمدة دقيقة أو دقيقتين بعد كل 10-15 دقيقة من التدريب وحين انتهاء الجلسة "أى بعد 60-90 دقيقة" يتمتع الطفل باستراحة أو لعب لمدة تتراوح 10-15 دقيقة " ويعود مرة أخرى لجلسة أيضا تكون مدتها "60-90 دقيقة" وهكذا إلى أن ينتهى عدد الساعات المحددة للطالب يوميا. أما بالنسبة للأطفال غير المستجدين في البرنامج، فقد تطول مدة جلستهم إلى أربع ساعات تتخللها فترات استراحة تتراوح مدتها بين 1-5 دقائق وتنته باستراحة مدتها 15 دقيقة أو أكثر ثم يعود التلميذ إلى جلسة أخرى. وهكذا إلى أن يكتمل عدد الساعات المحددة يوميا والتي تكون في العادة ثمانى ساعات ونستعرض فيما يى الخطوات التى قد يتبعها المعلم في جلسة من جلسات لوفاس والتي كما أسلفنا تعتمد بشكل كبير على التعليم من خلا المحاولات المنفصلة:

يبتدئ المعلم الجلسة بدغدغة الطفل أو عمل آخر يعتبره الطفل ممتعا ويكون هذا لمدة دقيقة أو دقيقتين

يتبع ما سلف تعليم هدف معين من خلال المحاولات المنفصلة وعلى سبيل المثال، قد يكون الهدف المراد تعليمه هو أن يرفع الطفل يده، فيقول له المعلم "أرفع يدك" (المثير) وينتظر استجابة الطفل فإذا أعطى الطفل الاستجابة الصحيحة أى إذا رفع يده (الاستجابة) قام المعلم باعطائه شيئا محبا إليه "التوابع". أما في حال إجابة الطفل الخاطئة فهو لا يعطى معززا "التوابع" تتكرر هذه العملية ما بين 5-9 مرات لنفس الهدف. ويجدر الذكر أن المعلم يستخدم نفس المثير في كل مرة فإذا استخدم عبارة "أرفع يدك" فهي تستخدم في كل محاولة وكل يوم إلى أن يتمكن الطفل من الاستجابة الصحيحة بنسبة 80-

90%

يسجل المعلم جميع استجابات الطفل على ورقة التسجيل

يكرر المعلم الهدف ذاته إلا إذا كانت نسبة استجابات الطفل الصحيحة في العرض الأول للهدف تتراوح بين 80-90% وفي مثل هذه الحالات يقوم المعلم بعرض هدف تربوى آخر يسجل المعلم جميع استجابات الطفل ويكتب أى ملاحظات قد استنتجها ويستخدم هذه المعلومات في التخطيط للجلسات القادمة

يلعب المعلم مع الطفل لمدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين يعرض المعلم هدفا تعليميا آخر على الطفل قد يكون جديدا أو قد يكون تكملة لهدف عرض في أيام سابقة

يتراوح عدد "الأهداف" التي تعطى للطفل خلال الساعة الواحدة ما بين 5-7 وقد يعطى الطفل الهدف ذاته عدة مرات خلال الساعة "5-7 مرات" أو أنه قد يعطى أهدافا مختلفة في خلال الساعة وهذا يعتمد على الخطة التربوية لطفل بعد مدة تتراوح بين 60-90 دقيقة يعطى الطفل استراحة مدتها 15 دقيقة قد تكون داخل غرفة العلاج أو خارجها

يتكرر هذا النمط من التعليم خلال اليوم لمدة ثمانى ساعات في خمسة أيام أسبوعيا أو ست ساعات يوميا خلال أيام الأسبوع جميعها يقوم المعلم بتدريب الطفل على تعميم المهارات التي تعلمها في الجلسات التعليمية ويعطى الطفل فرصا لاستخدامها في حياته اليومية خارج نطاق الجلسة التعليمية يقوم المعلم بمراجعة المهارات التي تعلمها الطفل من خلال عرضها عليه من وقت إلى آخر

مدى تقدم التلاميذ.

في دراسته التي نشرت في عام 1978 قدم لوفاس تقريرا عن مدى تقدم 19 طفلا توحديا ممن التحقوا بالبرنامج وقد ذكر أنه بعد سنتين من التدريب المكثف "40 ساعة أسبوعيا" تطور لدى 47% "19/9" من الأطفال درجة ذكاء في المعدل الطبيعي فالتحقوا بمدارس اعتيادية بينما ظل 10% "19/2" من الأطفال ملتحقين

بمدارس لمن يعانون التوحد أو التأخر الذهني الشديد ز أما باقي الأطفال فقد التحقوا بمدارس أو فصول تعنى بتعليم أشخاص ذوي إعاقات مختلفة ليس هناك شك في أن تعليم الأشخاص الذين يعانون التوحد من خلال تقنيات تعديل السلوك يعتبر من أكثر الطرق نجاحا وهو ما يؤكد عدد هائل من الدراسات العلمية وبالإضافة إلى هذا لا يوجد إلى يومنا أي دراسات أثبتت عكس ذلك إلا أن هناك انتقادات على برنامج لوفاس نوضحها فيما يلي:-

1. ن الدراسة الأصلية للوفاس اقتصرت على أطفال توحدين ممن كان أداؤهم مرتفعا أي أنه لم يقبل الأطفال الذين تدنت درجة ذكائهم عن 50 درجة أو من كانت أعمارهم أكثر من 3.5 سنوات إن لم يكن في استطاعتهم نطق كلمات يستخدمونها أو لم يكونوا يمارسون المصاداة وبالالي فإن نسبة النجاح "ارتفاع درجة ذكاء إلى المستوى الطبيعي والتحاق الأطفال بمدارس اعتيادية" التي أشار إليها لوفاس وهي 47% لا تمثل إطلاقا جميع حالات التوحد

2. عند قياس الدكتور لوفاس مدى نجاح البرنامج، أعطى أهمية كبيرة لدرجات الذكاء لدى الأطفال وحيث أن سمات التوحد الأساسية هي القصور اللغوي والاجتماعي وعدم القدرة على التخيل وليس الذكاء كان قياس لوفاس للنجاح موضع انتقاد

3. تعليم الطفل أن يستجيب لما يطلب منه لا يعينه على أن يتصرف بطريقة تلقائية أو أن يتخذ القرارات أو أن يبادر إلى الاختلاط الاجتماعي وحيث أن مثل هذه الصعوبات تمثل السمات الأساسية للتوحد ينبغي بالتالي التركيز¹

¹ الشيخ ذيب، رائد (2005): الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد (برنامج الإعاقة في سورية)، دمشق ص 16-17.

تعديل سلوك طفل توحدي

يعتبر سلوك الطفل التوحدي سلوك معقد لأننا في أغلب الظروف لا نعرف لماذا يصدر هذا السلوك و السبب أن الطفل لا يعبر بشكل طبيعي أو لا يستطيع التعبير عنه أو لا يستطيع أن يجيب مثل الطفل العادي لذلك من المهم جداً أن نحدد السلوك الذي نريد تعديله في الطفل التوحدي وهي أهم نقطة في تعديل السلوك و لا أقصد بتعديل السلوك تعريف و إنما مسؤولية تحديده أي نجاحنا في تعديل السلوك الذي تم اختياره و نحن دائماً نواجه مشكلة الاهتمام بالمظهر و هي التعريف و تسجيل البيانات و الرسم البياني دون الجوهر و هو السلوك الحقيقي و ماذا توصلنا في تعديله و هل نجحنا أم لا لذلك يجب الاهتمام بالسلوك الحقيقي أو الواقعي للطفل.

الجوانب التي يؤثر عليها السلوك التوحدي بالسلب:

بعد تحديد نوعية السلوك الذي يتم اختياره يجب أن نحدد الجوانب التي يؤثر عليها السلوك بشكل سلبي أو الجوانب التي تعاني منها أسرة الطفل في حياته اليومية معه حيث نصادف أكثر من سلوك في الطفل الواحد يحتاج إلى تعديله و في هذه الحالة يجب أن نعرف كيف تؤثر هذه السلوكيات على الجوانب الحياتية للطفل و نأخذ بالسلوك الأهم ثم المهم.

نجد أن المعلم يقوم في عملية التعديل السلوكي للطفل التوحدي بتعزيز السلوك حيث يستخدم السلوك البديل و التوجيه اللفظي و غيرها من الأساليب لكنني أرى أن تعديل السلوك يجب أن يأخذ منحى آخر يأتي بثماره الفعالة في عملية تعديل السلوك و هو مدى العلاقة بين الطفل و المعلم الذي يقوم بعملية تعديل السلوك.

" مدى استجابة الطفل للمعلم

" مدى قبول الطفل للمعلم

" هل أحساس المعلم بالاحتياجات النفسية و الشعورية الخاصة بالطفل عالية

" هل المعلم لديه المرونة الكافية في استخدام أساليب جديدة في تعديل السلوك غير الأساليب المتعارف عليها في الكتب.

لذلك نجد أن ليس كل معلم قادر على القيام بعملية تعديل السلوك بنجاح، فيجب أن تتوافر في أخصائي تعديل السلوك الصفات الآتية.
" الصبر و قوة التحمل.

" روح التجديد و التنوع في الأساليب.

" القدرة على التحكم و السيطرة على السلوك.

" ابتكار طرق جديدة في تعديل السلوك

توجيه وتهذيب الطفل التوحيدي:

يحتاج هؤلاء الأطفال إلى توجيه وإرشاد نحو السلوك القديم:

" هل يفهم الطفل أن ما فعله كان خطأ؟ يجب أن يدرك خطأه وأن يعرف لماذا هو خطأ! ومثلاً لذلك فبدل أن تقول للطفل " كنت سيء السلوك هذا اليوم" من الأفضل أن تقول له " أنت أخذت حلويات أختك وهي ليست لك".

" دع تركيزك على السلوك وليس على الطفل:

أخبر الطفل بأنك غير سعيد بما فعله (الطفل) وليس غير سعيد لوجوده ومثال ذلك لا تقل له أنت شرير أو سيء السلوك ولكن دعه يعرف بوضوح أن ما فعله كان خطأً.

" كن مدركاً بأن الطفل التوحيدي قد لا يتعلم من التجارب. حيث من الصعب عليه تطبيق ما تعلمه في موقف ما على موقف آخر أو في حالة أخرى وقد يحتاج إلى توجيهات واضحة جداً بانتظام. " قم بتشجيع وتعزيز السلوك الجيد لديه وحاول تشجيعه وحفزه للسلوك الجيد وتجاهل سلوكه السيء كلما كان ذلك ممكناً فكل اهتمام به قد يحفزه ويشجعه كثيراً.

" الحالات الخاصة. مهما يكن سلوك الطفل التوحيدي جيداً فقد تأتي أحوال وأوقات يكون تصرفه وسلوكه سيئاً فيها وهذا التدهور في السلوك يمكن أن تشاهده في حالات القلق لديه فمثلاً عندما يحدث تغيير في روتين الحياة أو في البيئة مهما كان هذا التغيير بسيطاً فإنه يصاب بالقلق الزائد

معالجة اضطرابات التواصل عند أطفال التوحد

من الجدير بالذكر أننا نستخدم مزيجاً من النمطين اللفظي وغير اللفظي للتواصل مع من حولنا، ومن هنا تبرز أهمية مساعدة الطفل التوحيدي (المصاب بمرض التوحد) على التواصل بشكل فعال مع من حوله والذي يأتي في قمة أولويات برامج التأهيل المختلفة. وذلك لأن قصور المهارات التواصلية بشقيه اللفظي وغير اللفظي من السمات التشخيصية الأساسية لاضطرابات طيف التوحد. يعرف التوحد بأنه اضطراب في النمو العصبي يؤثر على التطور في ثلاثة مجالات أساسية منها، قصور في نمو وتطور المهارات التواصلية بالإضافة إلى صعوبة التفاعل الاجتماعي وهو ما يعتبر ذا علاقة وثيقة بالمهارات التواصلية أيضاً، والمجال الثالث يتمثل في التعلق الشديد بالأعمال الروتينية والمحافظة على أنماط وأداء الأفعال على وتيرة واحدة وصعوبة القدرة على اللعب، ومن الجدير بالذكر أن الفقد التدريجي للمهارات التواصلية والاجتماعية بعد النمو الطبيعي حتى سن 18 شهراً لا يمثل أكثر من 30% (الجمعية الأمريكية للنطق والسمع ASHA، 2006) من أطفال التوحد، في حين أن التأخر منذ البداية يمثل أكثر من 70% (ASHA، 2006) من الأطفال التوحيدين، حيث يشترط ظهور نمط الأعراض قبل سن 36 شهراً، ومن هنا تتضح لنا الأهمية القصوى للقصور في النواحي التواصلية، حيث إنها لا تعتبر معياراً تشخيصياً مهماً فقط، بل تعتبر التحدي الأكبر للمختصين وأسر الأطفال التوحيدين، مؤشرات أساسية، إن المؤشرات الأساسية والأولية التي تساعد المختصين من النواحي التواصلية في تشخيص التوحد، تتمثل في أن المصاب:

- لا يناغي حتى سن 12 شهراً.
- لا يستخدم الإشارة (الإشارة إلى الأشياء وهز اليدين) حتى سن 12 شهراً.
- لا يستخدم كلمات مفردة حتى سن 16 شهراً.
- ضعف مهارات الاتصال البصري.
- تجاوب ضعيف مع الآخرين أثناء اللعب.

- لا يستخدم عبارات مكونة من كلمتين حتى سن 24 شهرا.

- تكرار الكلمات، فعند سؤال الطفل: ما اسمك؟ فيقول «ما اسمك» بدل من أن يقول «أحمد» مثلا.

- فقد واضح لأي مهارات لغوية أو اجتماعية قد يكون اكتسبها قبل سن السنتين. دور الأسرة وحين يولد الطفل، فإن أول ما يراه في الوجود هو والداه، حيث يبدأ هذا الطفل في النمو والتطور وتبدأ حركاته الأولى وابتساماته وانفعالاته واستجاباته لما حوله داخل منزله مع والديه، فالمنزل والوالدان هما البيئة الأولى التي يعيش بها الطفل ويتعلم وينشأ فيها فيكتسب من خلال هذه البيئة ويتعلم المهارات المختلفة والتي يأتي على رأسها القدرة على الحوار والتواصل مع من حوله، وهنا تكمن أهمية الوالدين في حياة الطفل، ولكن في بعض الأحيان قد يعتري هذه المهارات التي يكتسبها عادة الطفل بشكل تلقائي بعض الخلل كما هو الحال في الطفل التوحدي، مما يكون له أكبر الأثر في تطورها بشكل سليم وهنا يختار الوالدان في الطريقة المثلى لمواجهة وإصلاح هذا الخلل، فيلجأ للمتخصصين في هذا المجال لمساعدتهما وتوجيههما لإيجاد الحل المناسب كما ورد في مجلة (Behavioral Interventions, Volume 22, p.179-199, 2007)

ومع الأهمية الكبيرة للتدخل العلاجي، فلا يمكن أبدا أن يقلل من شأن دور أولياء أمر الطفل التوحدي وبيئته في علاج هذا الاضطراب، فالدور الذي تلعبه أسرة الطفل التوحدي ومشاركتهم في البرنامج العلاجي له بالغ الأثر الإيجابي في تطوير هذه المهارات بشكل فعال أكثر، وبالتالي فإن إعطاء الوالدين المعلومات والنصح والتوجيه والأساليب والاستراتيجيات المناسبة الخاصة باضطراب طفلهم التوحدي سيساعدهم في تطوير المهارات المناسبة لدى هذا الطفل، إن أفضل علاقة تربط بين أخصائي النطق واللغة كمتخصص في تشخيص وعلاج الاضطرابات التواصلية وبين الوالدين كخبراء بطفلهم ومعرفتهم ببيئته الطبيعية وحياته اليومية والخبرات المختلفة التي يتعرض لها بالإضافة لاحتياجاته الخاصة وطباعه، هي علاقة الشراكة وذلك للوصول لأفضل طريقة للتدخل لعلاج مشكلة الطفل، والخطوة الأولى في تطبيق هذه الشراكة تكون بتدريب الوالدين وإعطائهما

الأدوات المناسبة التي ستساعدهما في تطوير مهارات الطفل والذي انعكس بشكل واضح على كمية الدعم المادي الذي أولته الحكومة الأميركية على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية والذي وصل إلى 211 مليون دولار تبعاً لتقرير الجمعية الأميركية للتوحد (مارس 2009)، حيث يعتبر تدريب الوالدين وخصوصاً أثناء المراحل المبكرة لحياة الطفل عنصراً مهماً في أي برنامج علاجي.¹

وكان تدريب الوالدين ومدى تأثيره على تقدم مهارات الطفل التواصلية ومهاراته الأخرى، محور وتركيز العديد من الأبحاث العلمية حيث أثبتت الدراسات الحديثة أهمية دور آباء وأمهات الأطفال التوحديين في تنمية المهارات التواصلية لدى أطفالهم، وذلك لأن الآباء والأمهات يمثلون الجزء الأكبر في عالم الطفل والذي تتضاءل أمامه كل الأدوار الأخرى من الناحية الكمية، حيث يقضي الطفل عدداً كبيراً من الساعات مع والديه في حين أنه يقضي عدداً محدوداً من الساعات مع اختصاصي أمراض النطق واللغة، ومن هنا تتبلور أهمية تدريب الآباء والأمهات بهدف موازنة المعادلة، بحيث يصاحب التفوق الكمي جودة نوعية تساعد الآباء والأمهات على تنمية مهارات الطفل التوحيدي التواصلية والذي سينعكس على مستوى استخدامه للمهارات التواصلية كطلب الأشياء وجذب الانتباه والرفض والتعبير عن المشاعر وغيرها من الصعوبات التي يعانيها أطفال التوحد على مستوى التواصل بشقية اللفظي وغير اللفظي، إن دور الأسرة يتمثل في ضرورة أن تتدرب بشكل مكثف حتى تتمكن من إتقان الأساليب والطرق المناسبة لتعليم طفلهم التوحيدي أكاديمياً والتعامل معه من الناحية النفسية - كما يجب هنا أن لا نغفل ضرورة أن يتدرب الأهل على الطرق والأساليب التي تمكنهم من التواصل الاجتماعي مع الطفل التوحيدي كل تبعاً لمستوى أدائه، أما دور المجتمع فيتجلى بشكل كبير في بذل الكثير من الجهود حتى يزداد الوعي باضطرابات طيف التوحد والذي سينعكس بشكل كبير على نمط التقبل الاجتماعي لفئات التوحديين وأسرتهم.

¹ أيمن البلشة، الخصائص والفروق بين الأطفال المتوحدين والمتخلفين (رسالة ماجستير غير مطبوعة:- الجامعة الأردنية، عمان).

ويشير أخيرا د.الدكروري، من خبرة تناهز خمسة عشر عاما من العمل مع أطفال التوحد وأسرهم، إلى أن شبح الخوف من المستقبل هو المشكلة الرئيسية وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال العمل الجاد منذ البداية وبشكل مستمر على كل الأصعدة بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والاعتماد على الذات للأشخاص التوحديين بالإضافة للعمل على سن القوانين التي من شأنها أن تدعم توفير البرامج والخدمات ذات العلاقة باحتياجات التوحديين المتنامية تبعا للمراحل العمرية ومستوى الأداء.

المراجع

- إبراهيم، عبد الستار 1994: العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث أساليبه و ميادين تطبيقه دار الفجر، القاهرة.
- أبو العزائم، محمود جمال 2003: اضطراب الذاتوية، الصفحة النفسية، موقع د. محمود جمال أبو العزائم.
- أحمد، سهير 1998: سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية.
- ادريس، عيسى 2000: اضطراب التواصل و علاقته بنمو مفهومي "الأنا" و "الأخر" لدى الأطفال المنغلقيين، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير في علم النفس، دمشق.
- ارونز، مورين 1994: التوحد، ترجمة كريمة خطاب، مجلة العربي، العدد 422، يناير، الكويت.
- بايزيد، محمد نبيل 2001: دليل الصحة النفسية للأطباء و العاملين في الرعاية الصحية الأولية، وزارة الصحة، دمشق.
- برويكر - ف، مولخ - ف، بيتزمان 2003: سيكوفيزيولوجية الألم، ترجمة د. سامر رضوان، الثقافية النفسية المتخصصة، العدد 54، المجلد 14، أبريل، بيروت.
- بصل، مصطفى 1990: علم النفس الصيدلاني، منشورات جامعة دمشق، دمشق.
- البهي، فؤاد السيد 1998: الأسس النفسية للنمو، دار الفكر العربي، بيروت.
- جابر، عيسى عبد الله 1997: الإرشاد العلاجي للاضطرابات السلوكية لدى الأطفال باستخدام اللعب، فعاليات المؤتمر التربوي الذي عقدته كلية التربية بجامعة دمشق بالتعاون مع الجمعية السورية للعلوم النفسية بعنوان: دور كليات التربية في تطوير التربية من أجل التنمية في الوطن العربي، ج1، دمشق.
- الجلبلي، سوسن شاكر 2005 : التوحد الطفولي أسبابه، خصائصه،

- تشخيصه، علاجه ، ط 1، مؤسسة علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق.
- جوهري، أحمد 1998: التوحد العلاج باللعب، سلسلة هيا بنا نقرأ، أبريل، الكويت.
 - الحاج، فايز 2004: البرامج الفردية في التعليم العلاجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، دورة في التعريف بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الجمعية السورية للعلوم النفسية و التربوية، دمشق.
 - الحجار، محمد 2004: تشخيص الأمراض النفسية، ط1، دار النفائس، دمشق.
 - حمصي، أنطون 1990: أصول البحث في علم النفس، مطبعة الاتحاد، دمشق.
 - الخطيب، جمال 1998: الطفل الحاضر الغائب، إطلالة أخرى على التوحد، مجلة العربي، العدد 474، مايو، الكويت.
 - الخطيب، جمال وآخرون 2009 مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. عمان: دار الفك.
 - الخطيب، عاكف 2011، نموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية واضطراب التوحد، في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في الأردن، في ضوء المعايير العالمية" رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، الاردن.
 - الخليدي، عبد المجيد و وهبي، كمال حسن 1998: الأمراض النفسية و العقلية و الاضطرابات السلوكية عند الأطفال، دار الفكر العربي، بيروت.
 - خليل محمد، إيهاب 2009. الأوتيزم التوحد والإعاقة العقلية، دراسة سيكولوجية، ط1. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.
 - خليل، قمر 2000 فاعلية التعلم باللعب لدى تلاميذ الصف الأول الابتدائي، دراسة لنيل درجة الماجستير في علم النفس، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق.
 - خليل، مازن 2001: دليل الصحة النفسية للأطباء و العاملين في الرعاية

الصحية الأولية،وزارة الصحة، دمشق.

- الراوي، فضيلة توفيق، حماد، آمال صالح 1992: التوحد الإعاقاة الغامضة، الدوحة، قطر
- الروسان،فاروق 1996: سيكولوجية الأطفال غير العاديين مقدمة في التربية الخاصة ط2، دار الفكر، عمان.
- الزارع، نايف 2008. مؤشرات ضبط الجودة في البرامج التربوية للأطفال التوحدين ودرجة إنطباقها على مراكز التوحد في المملكة العربية السعودية. رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان.
- الزارع، نايف 2010. المدخل إلى اضطراب التوحد المفاهيم الأساسية وطرق التدخل، ط1، عمان: دار الفكر.
- الزريقات، إبراهيم 2004. التوحد: الخصائص والعلاج. عمان: دار وائل للطباعة والنشر.
- سرحان، وليد 2009.التوحد، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- سعد، سميرة 1997 : دراسة منشورة في المجلة التربوية الصادرة عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت، موقع مركز الكويت للتوعية بالتوحد على الانترنت.
- السعد، سميرة عبد اللطيف 1992: معاناقى و التوحد، منشورات مركز الكويت للتوعية بالتوحد.
- سعيد، إيمان فوزي 1998: التشخيص النفسي، دار زهراء الشرق، القاهرة.
- سيد سليمان، عبد الرحمن 1998: سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة، ج1، دار زهراء الشرق، القاهرة.
- شاتوك، بول و سيفري، دون 2005 :ترجمة: ياسر الفهد: التوحد كاضطراب أيضي، وحدة لأبحاث التوحد، مدرسة العلوم الصحية، جامعة سندلاند، سندلاند، انكلترا.
- الشامي، وفاء 2004. علاج التوحد: الطرق التربوية والنفسية والطبية. جدة: الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية في المملكة العربية السعودية

- الشامي، وفاء. 2004، سمات التوحد، تطورها وكيفية التعامل معها، مركز جدة، السعودية.
- الشربيني، زكريا 2001: المشكلات النفسية عند الأطفال، دار الفكر العربي، القاهرة
- شقير، زينب محمود 2000: اضطرابات اللغة و التواصل، ط1، دار النهضة المصرية، القاهرة.
- الشناوي، محمد 1998: العملية الإرشادية، دار غريب، القاهرة.
- الشيخ ذيب، رائد 2004. تصميم برنامج تدريبي لتطوير المهارات التواصلية والاجتماعية والاستقلالية الذاتية لدى الأطفال التوحدين وقياس فاعليته. رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية: عمان، الأردن.
- الشيخ ذيب، رائد 2005: الدورة الأولى في التوحد، مؤسسة كريم رضا سعيد برنامج الإعاقة في سورية، دمشق.
- عاقل، فاخر 2003: معجم العلوم النفسية، ط1، شعاع للنشر و العلوم، حلب.
- عبد الرحمن، محمد وخليفة، منى 2004. مقياس جيليام لتشخيص التوحدية، دار الرشد.
- عبد القادر، أشرف ومحمد، صلاح الدين والغنيمي، إبراهيم 2010. المهارات الاجتماعية لدى أطفال الأوتيزم ذوي الأداء المرتفع والمنخفض- دراسة مقارنة، المؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها.
- عبد المعطي، حسن 1998: علم النفس الإكلينيكي، دار قباء، القاهرة.
- عبدالغفار، سهام 1999. فاعلية كل من برنامج إرشادي للأسرة وبرنامج للتدريب على المهارات الاجتماعية للتخفيف من أعراض الذاتية لدى الأطفال. رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة طنطا
- عقروق، وداد 2006. نموذج مقترح لتطوير خدمات التدخل المبكر في ضوء الممارسات العالمية ونتائج تقويم البرامج العاملة حالياً في الأردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا: عمان، الأردن.

- العلوان، علي 2006. تقييم البرامج التربوية والعلاجية المقدمة للأطفال التوحدين في الأردن. رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عمان العربية، عمان.
- العناني، حنان عبد الحميد 1997: الصفحة النفسية للطفل، ط3، دار الفكر، عمان.
- الغريز، احمد والمخالد، خالد 2014 فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الجانب السلوكي والمهاري لدى عينة من أطفال التوحد، مجلة كلية التربية، جامعة اسيوط، الوادي الجديد.
- الغريز، احمد وعوده، بلال 2009 سيكولوجية اطفال التوحد / دار الشروق، عمان، الاردن؟
- فراج، عثمان 2002. الإعاقات الذهنية. القاهرة: المجلس العربي للطفولة والأمومة.
- فيراري 2000: علم النفس المرضي للاستدلال على الألم و الاضطرابات النفسية عند الطفل، ترجمة د. سامر اللاذقاني - ريم الأطرش، مركز المصادر عن فرنسا المعاصرة، أربيل، دمشق.
- القريطي، عبد المطلب أمين 1996 سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة.
- كاردن، تمبل 1992: ترجمة د. فؤاد عبد الله العمر، الشروق، مركز الكويت للتوحد، سلسلة التوعية بالتوحد، الكويت.
- كامل، محمد علي 1997: ذوي الأوتيزم، ط1، كلية التربية، جامعة طنطا.
- كاولي، جيفري 2003: البنات و الصبيان و داء التوحد، نيوز ويك العربية، العدد 170، 16 سبتمبر، دار الوطن، الكويت.
- كوجل، روبرت - كوجل، لن تدريس الأطفال المصابين بالتوحد استراتيجيات التفاعل الايجابية و تحسين فرص التعلم ، ترجمة أ.د. عبد العزيز السراطوي، وزارة التربية و التعليم دولة المارات العربية المتحدة، دبي.
- مايلز، كرستين 1994: التربية المختصة، ط1، ورشة الموارد العربية.

- المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، معايير الاعتماد الخاص لبرامج وخدمات التوحد، عمان: الأردن.
- محمد سري، اجلال 1990: علم النفس العلاجي، عالم الكتب، القاهرة.
- محمد، عادل 2000. فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات الاجتماعية على مستوى التفاعلات الاجتماعية للأطفال التوحدين. مجلة بحوث كلية الآداب، جامعة المنوفية، سلسلة الإصدارات الخاصة، العدد السابع.
- محمد، عادل عبد الله 2002: جداول النشاط المصورة للأطفال التوحدين، دار الرشاد، القاهرة.
- محمد،عادل عبد الله 2002: الأطفال التوحديون، دار الرشاد، القاهرة.
- مركز دبي للتوحد 2001: التوحد أكثر الإعاقات التطورية صعوبة، نشرة صحية تصدر عن الشؤون الإعلامية - دائرة الصحة و الخدمات الطبية، دبي.
- مرهج، ريتا 2001 : التوحد، نشرة علمية صادرة عن مركز لبنان للتوحد،بيروت.
- مليكة، لويس كامل 1997: العلاج النفسي - مقدمة و خاتمة، دار القلم، الكويت.
- ميلر، سوزانا 1987: سيكو لوجية اللعب، ترجمة د. حسن عيسى، سلسلة عالم المعرفة، العدد 120، مطابع الرسالة، الكويت.
- النابلسي، محمد أحمد 1989: أصول و مبادئ الفحص النفسي، ط1، جروس برس، بيروت.
- ورنر، ديفيد 1992: رعاية الأطفال المعوقين، دليل شامل للعائلة و للعاملين في إعادة التأهيل و صحة المجتمع، ترجمة: عفيف الرزاز، ط1، ورشة الموارد العربية.
- ياسين، عطوف محمود 1990 : علم النفس العيادي الإكلينيكي ، ج1، دار العلم للملايين، بيروت.

- Alcentara, P. 1994: Effects of videotape instructional Package on purchasing skills of children whit Autism. Exceptional children, vol 61, No. 1, ,P.40-55.
- Barber, C. 1996: The integration of avery able pupil with Asperger syndrome into a mainstream school. Brithish journal of social Education, Vol. 23, No.1, March..
- Baron, Cohen, S. 1988: Social and pragmatic deficits in autism: Cognitive or affective? Journal of Autism and Develpmental disorders .
- Biderman, G. and others 1994: The Negative Effectss of Positive reinforcement in teaching children with development delay. Exceptional children, Vol. 60.
- Dunlap, G. and others 1988: Team training for young children with autism: A Regional model for service delivery. Journal of the Division for early childhood, vol. 12, No.2.
- El-Khatib, O, 1993: Characteristics of autistic children Parents. Journal of Handicap childhood vol. 2.
- Goldstein, M. and Other 1986: Abnormal psychology Experiences, origins and Interventions little, Toronto Brownand company,.
- Handleman, J. and others 1990: Mathers, fathers, Teachers, and speech Thrapists as Assessors of Treatment outcome for children with autism. Education and Treatment of children, Vol. 13, No2.
- Handleman, J and others 1991: Specialization Program for preschool children with autism. Language, Speech and Hearing Services in schools, Vol 22, No.3.

- Harrison, J. and Barabasz, 1991: A. Effects of restricted environmental stimulation therapy REST on the Behavior of children with Autism Child study Journal, Vol. 21, No.3.
- Hobson, R., 1986: The Autistic child's appraisal of expressions of emotion, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 27, P. 321-342.
- Illinois stat 1987: Department of Mental Health and Development Disabilities: A Report on service Need of Persons with Autism Springfield, Ill.
- Jardon, R. and Powell, S., 1990: Autism and National curriculum. British Journal of Special Education, Vol. 14, No. 4.
- Lord, C. and Schopler, E., 1985: Differences in sex ratios in autism as a function of measured intelligence. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 15, No.2, JunP.
- Lord C. and others, . 1982: Sex differences in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 12, No.4, Dec, P.317-330.
- 25 MC - Donald A., 1972: Chambers Twentieth century Dictionary. New Delhi.
- Marchionne, A., 1982: Early Childhood Autism U. S. Illinois.
- Meyers, K. and Criesman, B., 1986: Autism: Basic Information and Autism Questions and Answers. Bancroft school, Haddon field NJ. Apr.
- Miller, M. 1990: Characteristics of autism literature review, In Eric.

- Quill, K. and Others, Daily life therapy 1989: A Japanese Model for education children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol.19, No.4.
- Robbins, F. and Others, 1991: Family characteristic family training and progress of young children with autism. Journal of Early Intervention, Vol. 15, No2, Spr.
- Roeyers, H. 1995: A peer, mediated proximity intervention to facilitate the Social Interactions of children with pervasive developmental disorder. British Journal of Special Education, Vol. 22, No. 4, Dec.
- Rogers, S., 1991: A comparative study of the effects of developmentally based instructional modle on young children with autism and Young children with Disorders of Behavior and Development Topics in Early childhood. Special Education, Vol. 11, No2.
- Rogers, S, and Others 1986: An Approach for enhancing the symbolic communicative and interpersonal functioning of young children with autism or servers emotional handicafe. Journal of the Division for early childhood, vol. 19, No.2.

الفهرس

5	مقدمة.....
7	تمهيد.....
الباب الأول	
11	مدخل إلى اضطرابات التوحد.....
13	معنى التوحد.....
15	نسبة شيوع إعاقة التوحد عالميا.....
17	أسباب التوحد.....
25	أنواع التوحد:.....
27	خصائص التوحد.....
30	خصائص التوحد (قبل عمر ثلاث سنوات).....
33	التفسيرات البيولوجية والسيكولوجية لمرض التوحد:.....
35	الأعراض العامة للتوحد:.....
37	المؤشرات العامة السلوكية الدالة التي يتفرد بها طفل التوحد.....
39	
الباب الثاني	
39	قياس التوحد وتشخيصه.....
41	سمات أطفال التوحد بحسب تصنيف Haward & Orlansky.....
43	المظاهر العامة للتوحد:.....
59	اضطرابات التواصل الشائعة لدى الأطفال التوحدين.....
68	تعريف مفهوم التشخيص وأهميته.....
69	كيف يتم تشخيص من يعانون التوحد ؟؟؟.....
69	دور الطبيب في تشخيص التوحد.....
70	أدوات تشخيص وقياس التوحد.....
77	المقاييس المستخدمة في اختبارات التوحد.....
80	الفحوصات المخبرية.....

83	أدوات تساعد في تشخيص التوحد
87	

الباب الثالث

87	البرامج العلاجية والتربوية
87	لأطفال التوحد
89	العلاج بالأدوية
96	العلاج الغذائي
97	الحمية الغذائية تساعد الأطفال التوحدين
102	تربية الأطفال التوحدين ومشكلات التواصل المشابهة
103	مبادئ وطرق التعليم
109	برنامج التكامل الحسي
111	برامج التكامل السمعي
112	العلاج بالموسيقى (Music Therapy)
113	نظام التواصل المعتمد على تبادل الصور
113	نظام بكس PECS
117	التعاقد السلوكي:
120	تشكيل السلوك في علاج حالات التوحد
122	الجلسات التعليمية في برنامج لوفاس
125	تعديل سلوك طفل توحدي:
128	معالجة اضطرابات التواصل عند أطفال التوحد
133	المراجع

يتدرج التَّوَحُّدُ أو الذاتوية من الاضطراب البسيط في التواصل أو في السلوك إلى حالات التَّوَحُّد أو الذاتوية الشديدة. إن كثير من الأسر والمربين تختلط لديهم المفاهيم بين التوحد والتخلف العقلي والقصور الذهني وغيرها من المفاهيم التي تطلق على أمراض الإضرابات العقلية، مع العلم أن هناك تفاوتاً كبيراً بين تلك المفاهيم، من النواحي العلمية والطبية، وعند الأخذ في الاعتبار تجربة الطفل الذي يعاني من اضطراب التوحد من المهم التوصل إلى فهم عام للسمات المميزة لذلك الاضطراب بالإضافة إلى الطريقة التي يُظهر الفرد من خلالها ما يعبر به عن اضطراب التوحد. ومن الأهمية أيضاً أن تؤخذ في الاعتبار العوامل الخارجية التي تؤثر على كيفية قدرة الفرد على التعلم.



+962797135504



Dar ibn alnafees

+962780080648



dar_ibnalnafees@yahoo.com



alnafees02@gmail.com



9 789923 240014